

Gesetzentwurf

der Abgeordneten Dr. Janosch Dahmen, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Dr. Armin Grau, Simone Fischer, Linda Heitmann, Johannes Wagner, Leon Eckert, Misbah Khan, Dr. Paula Piechotta und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes (Notfallgesetz – NotfallG)

A. Problem

Eine gut funktionierende und wirtschaftliche Notfall- und Akutversorgung ist ein zentraler Pfeiler einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung. Für Menschen in akuten medizinischen Notlagen ist es entscheidend, jederzeit unmittelbar Hilfe zu erhalten und dabei auf eine qualitativ hochwertige Versorgung vertrauen zu können – im ambulanten wie im stationären Bereich. Deutschland verfügt hierfür grundsätzlich über ein umfassend ausgebautes System der Notfall- und Akutversorgung einschließlich eines etablierten Rettungswesens.

Die drei Versorgungsbereiche – vertragsärztlicher Notdienst, Notaufnahmen der Krankenhäuser und Rettungsdienste – sind jedoch bislang sektoral getrennt und unzureichend aufeinander abgestimmt. Unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen, Finanzierungs- und Ordnungsprinzipien führen zu Fehlanreizen sowie zu Über-, Unter- und Fehlversorgungen. Hilfesuchende müssen oftmals selbst entscheiden, welche Versorgungsebene für sie die richtige ist. Hinzu kommt die parallele Steuerung über zwei unterschiedliche telefonische Anlaufstellen – die 116117 der Kassenärztlichen Vereinigungen und die 112 bei den Rettungsleitstellen. Dies begünstigt Fehlsteuerungen und trägt zur Überlastung insbesondere der Notaufnahmen und des Rettungsdienstes bei, die häufig auch in Fällen beansprucht werden, die vertragsärztlich hätten versorgt werden können.

Besonders der Rettungsdienst nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Er ist für die Ersteinschätzung, die fallabschließende Notfallversorgung vor Ort und den medizinisch begleiteten Transport in die gebotene Weiterbehandlung zuständig. Seit vielen Jahren steigen die Fallzahlen im Rettungsdienst deutlich an – vor allem durch die Inanspruchnahme älterer Menschen – und damit auch die Ausgaben der Sozialversicherung. Angesichts der demografischen Entwicklung ist zukünftig mit einer weiteren Zunahme chronisch kranker und alleinlebender Personen und somit mit steigenden Kosten zu rechnen. Dennoch ist der Rettungsdienst im Sozialversicherungsrecht bislang nur unzureichend abgebildet. Da seine Leistungen überwiegend auf Transportkosten begrenzt vergütet werden, kann sein volles Potenzial, insbesondere hinsichtlich einer effizienten Steuerung von Patientinnen

und Patienten sowie einer rechtssicheren Weiterleitung in die ambulante Weiterversorgung, nicht ausgeschöpft werden. Dies führt zu medizinisch nicht erforderlichen Notfalltransporten und stationären Aufnahmen und belastet die Sozialversicherung erheblich.

In den letzten Jahren wurden erste Schritte unternommen, um die Notfallversorgung besser zu koordinieren. So tragen Notdienstpraxen an oder in Krankenhäusern zur verbesserten Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen bei, und die bundesweite Rufnummer 116117 mit Terminservicestellen unterstützt Hilfesuchende in Akutfällen. Auch einzelne Initiativen zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und Rettungsleitstellen zeigen Ansätze einer engeren Zusammenarbeit. Da es jedoch bislang an verbindlichen gesetzlichen Regelungen fehlt, bestehen erhebliche regionale Unterschiede.

Fachgesellschaften, Länder und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege fordern daher seit Jahren eine umfassende Reform. Bereits 2018 wurden erhebliche Defizite in der Notfallversorgung festgestellt, und aktuelle Gutachten weisen darauf hin, dass eine Reform des Rettungsdienstes im Zusammenspiel mit der Notfallversorgung das Potenzial hat, die stationäre Belastung in Krankenhäusern um bis zu 30 Millionen Belegungstage jährlich zu reduzieren. Auch die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung hat in ihrer Vierten und Neunten Stellungnahme weitreichende Empfehlungen ausgesprochen.

Ziel muss es sein, die Notfallversorgung bundesweit einheitlich, sektorenübergreifend und ressourcenschonend auszurichten, sodass Hilfesuchende jederzeit eine gleichwertige, qualitativ hochwertige und am Stand der Wissenschaft orientierte Versorgung erhalten. Dazu gehört insbesondere die Aufnahme des Rettungsdienstes als eigenständiger Leistungsbereich in die gesetzliche Krankenversicherung. Nur wenn die sektoralen Grenzen überwunden und die Strukturen verbindlich vernetzt werden, kann der Rettungsdienst sein volles Leistungspotenzial entfalten und eine effiziente, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Notfallversorgung für alle Patientinnen und Patienten sichergestellt werden.

B. Lösung

Vor diesem Hintergrund werden umfassende gesetzliche Maßnahmen ergriffen, um die Notfallversorgung in Deutschland effizienter, wirtschaftlicher und zugleich patientenorientierter zu gestalten. Ziel ist es, die Vernetzung der Versorgungsbereiche zu verbessern, Hilfesuchende gezielter in die richtige Versorgungsebene zu steuern und gleichzeitig die Qualität der medizinischen Behandlung sicherzustellen.

Die bisherigen Aufgaben der Terminservicestellen im Bereich der Akutfallvermittlung übernimmt künftig die sogenannte Akutleitstelle der Kassenärztlichen Vereinigungen. Durch ihre enge Vernetzung mit den Rettungsleitstellen und die medienbruchfreie digitale Fallübergabe wird eine effektivere Steuerung von Patientinnen und Patienten ermöglicht. Dies trägt wesentlich zur Entlastung von Notaufnahmen und Rettungsdiensten bei.

Parallel dazu wird die notdienstliche Akutversorgung der Kassenärztlichen Vereinigungen durch Konkretisierung des Sicherstellungsauftrages ausgebaut. Sie sind verpflichtet, eine durchgängige telemedizinische und aufsuchende Versorgung anzubieten. Dadurch wird insbesondere auf die demografische Entwicklung und die Bedürfnisse immobiler Patientinnen und Patienten eingegangen. Die verstärkte Nutzung der Telemedizin verbessert die Versorgung und entlastet Ärztinnen und Ärzte.

Ein weiterer Kernpunkt ist die Etablierung Integrierter Notfallzentren als sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen. Hier arbeiten zugelassene Krankenhäuser und die Kassenärztlichen Vereinigungen verbindlich zusammen, sodass stets eine bedarfsgerechte ambulante Erstversorgung gewährleistet ist. Diese Zentren bestehen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer Notdienstpraxis sowie einer zentralen Ersteinschätzungsstelle. Die Standorte werden nach bundeseinheitlichen Vorgaben festgelegt; gelingt innerhalb von sechs Monaten keine Einigung, entscheidet das jeweilige Land. In Integrierten Notfallzentren wird mindestens telemedizinisch ein psychiatrisches, psychosomatisches oder psychotherapeutisches Konsil sichergestellt. Flächendeckend werden auch spezialisierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche eingerichtet oder durch telemedizinische Unterstützung ergänzt.

Ergänzend wird der gesetzliche Rahmen für die Finanzierung der Leistungen des Rettungsdienstes neugestaltet. Die rettungsdienstliche Notfallbehandlung wird als eigenständiger Leistungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung differenzierter geregelt. Damit wird die Rolle des Rettungsdienstes zielgerichteter auf notwendige und fachgerechte Versorgungsangebote begrenzt. Durch diese Anpassung des Leistungs- und Leistungserbringerrechts werden Finanzierungsfehlansätze beseitigt, wodurch vermeidbare Transporte und insbesondere medizinisch nicht sinnvolle stationäre Krankenhausaufenthalte deutlich reduziert werden. Dies senkt die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung erheblich und stellt zugleich eine zweckmäßige, bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten sicher.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Bund, Länder und Kommunen

Dem Bund entstehen durch das Gesetz keine Mehrausgaben. Für die Haushalte der Länder und Kommunen können allenfalls geringfügige Kosten entstehen.

Gesetzliche Krankenversicherung

Durch die geplanten Reformen in der Notfallversorgung entstehen der gesetzlichen Krankenversicherung zunächst zusätzliche Kosten. Diese liegen schätzungsweise bei rund 150 Millionen Euro, vor allem für den Ausbau des aufsuchenden Dienstes (ca. 105 Millionen Euro) und für Akutleitstellen (ca. 45 Millionen Euro). Hinzu kommen weitere, derzeit noch nicht quantifizierbare Ausgaben etwa für die Beteiligung an Integrierten Notfallzentren oder für die digitale Vernetzung. Auch die Entwicklung spezieller ambulanter Notfallversorgung (z. B. psychische Notfallhilfen, Gemeindenotfallsanitäter, vorbeugender Rettungsdienst), die Digitalisierung der Leitstellen sowie Qualitätsanforderungen verursachen zusätzliche Aufwendungen, die stark von den Strukturen in den Ländern abhängen.

Diesen Mehrausgaben stehen jedoch erhebliche Einsparpotenziale gegenüber. Durch eine verbesserte Steuerung der Patientenströme, die Vernetzung von Akut- und Rettungsleitstellen sowie die fallabschließende ambulante oder telemedizinische Versorgung können medizinisch nicht erforderliche Rettungswageneinsätze und Krankenhausaufenthalte deutlich reduziert werden. Schon die Umleitung von Rettungsstellenfällen an die Akutleitstellen wird auf mittlere Sicht jährliche Einsparungen von rund 834 Millionen Euro ermöglichen. Darüber hinaus belegt das Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-

sundheitswesen und in der Pflege 2024, dass durch eine Reform von Rettungsdienst und Notfallversorgung bis zu 30 Millionen Krankenhaus-Belegungstage pro Jahr vermieden werden könnten. Angesichts durchschnittlicher Folgekosten von etwa 3.600 Euro pro stationärem Aufenthalt ergibt sich daraus ein erhebliches Entlastungspotenzial. Da ein relevanter Anteil der heute ins Krankenhaus transportierten Patientinnen und Patienten auch ambulant oder direkt vor Ort versorgt werden kann, sind im Rahmen der Reform Einsparungen von bis zu 5 Milliarden Euro jährlich realistisch.

Insgesamt kann daher durch die Reformen langfristig nicht nur mit einer erheblichen Verbesserung der Versorgungsqualität, sondern auch mit jährlichen Minderungen in Milliardenhöhe gerechnet werden.

E. Erfüllungsaufwand

Mit den Neuregelungen der Notfallreform wird eine verbesserte Kooperation der drei Leistungsbereiche des Notdienstes der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Notaufnahmen der Krankenhäuser und des Rettungsdienstes angestrebt.

Erfüllungsaufwand entsteht durch die Verhandlungen von Kooperationsvereinbarungen für die Bildung von Gesundheitsleitsystemen und Integrierten Notfallzentren sowie die Bildung von Organisationsgremien in den Integrierten Notfallzentren. Daneben wird durch die Erweiterung der Aufgaben von Gremien, unter anderem des Qualitätsausschusses Notfallrettung entstehen.

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Krankenhäuser entsteht durch den Abschluss von rund 700 Kooperations- und Versorgungsverträgen ein einmaliger Erfüllungsaufwand von etwa 0,5 Millionen Euro bei gleichzeitig erwartbar hohen Synergieeffekten zwischen den Partnern. Hinzu kommt jährlich rund 1 Million Euro für die Arbeit in den Organisationsgremien der Integrierten Notfallzentren.

Die Landeskrankenhausesellschaften tragen einen einmaligen Aufwand von rund 205.000 bis 217.000 Euro infolge der erweiterten Aufgaben der Landesausschüsse. Bei den privaten Krankenversicherungsunternehmen liegt der einmalige Aufwand für die Vereinbarung zur finanziellen Beteiligung am Notdienst bei etwa 10.000 Euro.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Für Länder und Kommunen fällt ein einmaliger Aufwand von rund 210.000 bis 214.000 Euro für Kooperationsvereinbarungen der Gesundheitsleitsysteme an, ergänzt durch einen laufenden jährlichen Aufwand von etwa 34.000 bis 334.000 Euro für die zusätzliche Arbeit der Rettungsdienst-Vertretungen in den erweiterten Landesausschüssen. Zudem entsteht ein nicht näher bezifferbarer Aufwand für die Vertretung im Qualitätsausschuss Notfallrettung.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen einmaligen Aufwand zwischen 635.000 und 836.000 Euro für den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern und Gesundheitsleitsystemen. Hinzu kommen jährlich rund

1,25 bis 1,27 Millionen Euro für die Organisationsgremien der Integrierten Notfallzentren sowie einmalige Kosten von rund 218.000 bis 229.000 Euro für die Arbeit in den erweiterten Landesausschüssen. Darüber hinaus entstehen Kosten für jährliche Berichtspflichten in Höhe von 29.000 bis 71.000 Euro sowie ein nicht bezifferbarer Aufwand im Qualitätsausschuss Notfallrettung. Den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenversicherung entsteht zudem ein einmaliger Aufwand von rund 228.000 bis 230.000 Euro für ihre Beteiligung an den erweiterten Landesausschüssen.

Für den Bewertungsausschuss schließlich sind mehrere einmalige Aufwände vorgesehen, darunter rund 13.500 Euro für die Beschlussfassung zur Vergütung der Ersteinschätzung, etwa 17.000 Euro für die Evaluation sowie weitere 7.500 bis 10.000 Euro für Beratungen zu Notaufnahmen und Notdienststrukturen.

F. Weitere Kosten

Keine. Vielmehr ist durch eine verbesserte Steuerung und damit gezieltere Nutzung der Notfalleinrichtungen davon auszugehen, dass sich finanzielle Entlastungen für das Gesundheitssystem ergeben.

**Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung
und des Rettungsdienstes
(Notfallgesetz – NotfallG)**

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 217) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 27 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
 - a) In Nummer 6 wird die Angabe „Leistungen.“ durch die Angabe „Leistungen,“ ersetzt.
 - b) Nach Nummer 6 wird die folgende Nummer 7 eingefügt:
„7. Leistungen der medizinischen Notfallrettung.“
2. § 30 wird durch den folgenden § 30 ersetzt:

„§ 30

Medizinische Notfallrettung

(1) Bei Vorliegen eines rettungsdienstlichen Notfalls haben Versicherte Anspruch auf medizinische Notfallrettung durch einen zugelassenen Leistungserbringer nach § 133 Absatz 1. Ein rettungsdienstlicher Notfall liegt vor, wenn sich der Versicherte aus ex ante Sicht in unmittelbarer Lebensgefahr befindet oder eine lebensbedrohende Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder eine schwere gesundheitliche Schädigung zu befürchten ist, sofern nicht eine sofortige medizinische Versorgung erfolgt. Für einen Anspruch auf Leistungen des Notfallmanagements nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist es ausreichend, dass der begründete Verdacht besteht, dass ein Versicherter einen Bedarf an Leistungen der notfallmedizinischen Versorgung nach Absatz 2 Nummer 2 oder an Leistungen der notdienstlichen Akutversorgung nach § 75 Absatz 1b SGB V hat.

(2) Die medizinische Notfallrettung umfasst:

1. das Notfallmanagement,
2. die notfallmedizinische Versorgung,
3. den Notfalltransport,
4. die spezielle ambulante Notfallversorgung.

Die aufgrund einer Abfrage eines Gesundheitsleitsystems nach § 133a getroffene Entscheidung zur Auslösung der medizinischen Notfallrettung gilt als Nachweis des Vorliegens eines rettungsdienstlichen Notfalls nach Absatz 1 Satz 2. Für die Leistung nach Satz 1 Nummer 4 gilt bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] als Nachweis die auf Grundlage einer protokollgestützten, standardisierten, softwaregestützten und qualitätsgesicherten Notrufabfrage getroffene Entscheidung.

(3) Das Notfallmanagement nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 für rettungsdienstliche Notfälle nach Absatz 1 umfasst die Entgegennahme des medizinischen Hilfersuchens, die Vermittlung der erforderlichen Hilfe auf Grundlage einer protokollgestützten, standardisierten, qualitätsgesicherten und softwaregestützten Notrufabfrage und die telefonische und telemedizinische Notfallberatung sowie standardisierte und qualitätsgesicherte Erste-Hilfe-Anweisungen einschließlich der auf digitalen Anwendungen basierenden Entsendung von Ersthelfern bei besonders lebensbedrohlichen Notfällen, soweit entsprechende digitale Anwendungen bestehen. Die Erforderlichkeit der Vermittlung auf Grundlage einer standardisierten, qualitätsgesicherten und softwaregestützten Notrufabfrage gilt ab dem ... [einsetzen: Datum des letzten Tages des elften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats]. Das Notfallmanagement umfasst auch die digitale Fallübergabe zwischen den Leistungserbringern im Rettungsdienst, den am Notdienst beteiligten Akteuren der Kassenärztlichen Vereinigungen und den Integrierten Notfallzentren.

(4) Die notfallmedizinische Versorgung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 umfasst die aus medizinischer Sicht erforderliche Versorgung vor Ort nach dem Stand der Wissenschaft durch ärztliches und nicht-ärztliches Personal, auch telemedizinisch.

(5) Der Notfalltransport nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 umfasst den aus medizinischer Sicht erforderlichen Transport in die grundsätzlich nächste geeignete Versorgungseinrichtung oder die aus zwingenden medizinischen Gründen erforderliche Verlegung von einer Einrichtung in eine andere Einrichtung, bei der aus medizinischer Sicht die Beförderung mit einem qualifizierten boden- oder luftgebundenen Rettungsmittel erforderlich ist, sowie die notfallmedizinische Versorgung nach Absatz 4 während des Transports. Der Anspruch umfasst nicht den Rücktransport in das Inland. § 18 bleibt unberührt.

(6) Die spezielle ambulante Notfallversorgung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 umfasst geeignete spezialisierte ambulante Versorgungsangebote; hierzu zählen unter anderem notfallpflegerische Leistungen, psychische Notfallhilfen sowie Leistungen einer fachgerechten Versorgung außerklinischer, geburtshilflicher Notfälle. Die für das Notfallmanagement nach Absatz 3 zuständigen Stellen haben die Vermittlung dieser Leistungen für den Bedarfsfall in geeigneter Weise sicherzustellen.

(7) Versicherte leisten zu Leistungen des Notfalltransports nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 eine Zuzahlung in Höhe des sich nach § 61 ergebenden Betrages. Die Krankenkasse zieht die Zuzahlung vom Versicherten ein oder übernimmt die Kosten unter Abzug des sich nach § 61 ergebenden Betrages.“

3. § 60 wird durch den folgenden § 60 ersetzt:

„§ 60

Krankentransporte, Krankentransportflüge und Krankenfahrten

(1) Versicherte haben unbeschadet der Regelung in § 27 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 in Verbindung mit § 30 nach Absatz 2 Anspruch auf Übernahme der Kosten für Krankentransporte, Krankentransportflüge und Krankenfahrten, wenn sie im Zusammenhang mit einer Leistung der Krankenkasse aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sind. Welches Transportmittel genutzt werden kann, richtet sich nach der medizinischen Notwendigkeit im Einzelfall.

(2) Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für Krankentransporte und Krankenfahrten nach Absatz 1 Satz 1 bei

1. Fahrten zur stationären Behandlung,
2. Fahrten im Zuge einer Verlegung

- a) in ein anderes Krankenhaus während einer stationären Behandlung, wenn die Verlegung aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist oder soweit es zur Behandlung des Versicherten der besonderen Mittel des Krankenhauses der höheren Stufe nicht oder nicht mehr bedarf und die dortigen Versorgungskapazitäten für andere Patienten benötigt werden,
 - b) in ein anderes Krankenhaus zur Behandlung im Rahmen des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a oder
 - c) in ein wohnortnahes Krankenhaus, wenn die Krankenkasse in die Verlegung eingewilligt hat,
3. Fahrten
- a) zu einer vor- oder nachstationären Behandlung im Krankenhaus nach § 115a,
 - b) zu einer ambulanten Operation im Krankenhaus nach § 115b oder
 - c) zu einer ambulanten Operation in einer Vertragsarztpraxis einschließlich der hierzu erforderlichen Vor- und Nachbehandlungen innerhalb der Fristen des § 115a Absatz 2 Satz 1 bis 3,
- wenn dadurch eine aus medizinischen Gründen erforderliche vollstationäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung im Sinne des § 39 vermieden oder verkürzt wird oder wenn diese nicht ausführbar ist,
4. Fahrten zu ambulanten Behandlungen, sofern aus medizinischer Sicht ein Krankentransport zwingend erforderlich ist oder sofern ein besonderer Ausnahmefall vorliegt, den der Gemeinsame Bundesausschuss in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 festgelegt hat,
5. Fahrten zur Versorgung in einem Integrierten Notfallzentrum nach der Entscheidung eines Gesundheitsleitsystems, sofern die Fahrt nach den Umständen des Einzelfalls zwingend erforderlich ist; die Entscheidung des Gesundheitsleitsystems gilt als Verordnung dieser Leistung.

Bei einer Verlegung nach Nummer 2 Buchstabe c (Verlegung in ein wohnortnahes Krankenhaus) ist über den Antrag auf Genehmigung abweichend von § 13 Absatz 3a Satz 1 innerhalb von 24 Stunden nach Antrags Eingang zu entscheiden.

(3) Krankentransporte sind Fahrten mit medizinisch-fachlicher Betreuung, die in Kraftfahrzeugen durchgeführt werden, die über die besondere Einrichtung eines Krankenkraftwagens verfügen. Krankentransporte werden für Versicherte durchgeführt, die einer solchen Betreuung oder Einrichtung während der Fahrt bedürfen oder deren Zustand erwarten lässt, dass eine solche Betreuung oder Einrichtung während der Fahrt erforderlich ist. Bei einem Krankentransport zu einer ambulanten Behandlung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 besteht ein Anspruch auf Kostenübernahme nur nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse. Die Regelungen dieses Absatzes gelten entsprechend für Krankentransportflüge.

(4) Krankenfahrten sind Fahrten ohne medizinisch-fachliche Betreuung, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten Kraftfahrzeugen, Mietwagen oder Taxen durchgeführt werden. Bei Krankenfahrten zu ambulanten Behandlungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 zweite Alternative besteht ein Anspruch auf Kostenübernahme nur nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse. Die Genehmigung nach Satz 2 gilt als erteilt, sofern eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

- 1. ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“, „Bl“, „H“ oder „TBl“, wobei bei Vorliegen der Merkzeichen „Bl“, „H“ und „TBl“ auch die Genehmigung für eine Begleitperson als erteilt gilt,
- 2. eine Einordnung gemäß § 15 des Elften Buches in den Pflegegrad 3, 4 oder 5, bei Einordnung in den Pflegegrad 3 zusätzlich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität, oder
- 3. bis zum 31. Dezember 2016 eine Einordnung in die Pflegestufe 2 gemäß § 15 des Elften Buches in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung und seit dem 1. Januar 2017 mindestens eine Einordnung in den Pflegegrad 3.

(5) Die Höhe der nach Absatz 1 Satz 1 übernommenen Kosten für Krankentransporte richtet sich nach § 133 Absatz 2 und 3. Für Krankenfahrten sind als Kosten anerkannt:

- 1. bei der Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels der Fahrpreis unter Ausschöpfen von Fahrpreisermäßigungen,

2. bei Benutzung eines Taxis oder Mietwagens der Betrag nach § 133 Absatz 4,
3. bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs für jeden gefahrenen Kilometer der jeweils aufgrund des Bundesreisekostengesetzes festgesetzte Höchstbetrag für Wegstreckenentschädigung, höchstens jedoch die Kosten, die bei Inanspruchnahme des nach Nummer 1 oder Nummer 2 erforderlichen Transportmittels entstanden wären.

(6) Die Krankenkasse übernimmt die Kosten nach Absatz 1 Satz 1 unter Abzug des sich nach § 61 ergebenden Betrages oder zieht den sich nach § 61 ergebenden Betrag von den Versicherten ein.

(7) Die Kosten eines Rücktransports in das Inland werden nicht übernommen. § 18 bleibt unberührt.

(8) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden Reisekosten nach § 73 Absatz 1 und 3 des Neunten Buches übernommen. Zu den Reisekosten nach Satz 1 gehören bei Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches auch die Reisekosten, die im Zusammenhang mit der Versorgung Pflegebedürftiger nach § 40 Absatz 3a Satz 1 und 2 entstehen. Die Reisekosten von Pflegebedürftigen, die gemäß § 40 Absatz 3a Satz 2 während einer stationären Rehabilitation ihrer Pflegeperson im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches eine Kurzzeitpflege nach § 42 des Elften Buches erhalten, hat die Pflegekasse des Pflegebedürftigen der Krankenkasse der Pflegeperson im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches zu erstatten.

(9) Krankentransportflüge sind luftgebundene Verlegungen von Versicherten, die einer medizinisch-fachlichen Betreuung bzw. Behandlung und der besonderen Einrichtung eines Rettungshubschraubers bedürfen oder deren Erforderlichkeit aufgrund ihres Zustandes zu erwarten ist. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für Krankentransportflüge bei Transporten gemäß Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, wenn diese aus medizinischen Gründen notwendig sind. Der Anspruch zur Kostenübernahme besteht nach Absatz 1 Satz 1 durch ärztliche Verordnung oder nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse.“

4. In § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 wird nach der Angabe „Krankentransporten“ die Angabe „Krankentransportflüge und Krankenfahrten“ eingefügt.
5. In § 73b Absatz 4 Satz 7 wird die Angabe „vertragsärztlichen Versorgung zu den stundenfreien Zeiten“ durch die Angabe „notdienstlichen Akutversorgung nach § 75 Absatz 1b“ ersetzt.
6. § 75 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1a wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

„Hierzu informieren die Kassenärztlichen Vereinigungen die Versicherten im Internet in geeigneter Weise bundesweit einheitlich über die Sprechstundenzeiten der Vertragsärzte und über die Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zur Versorgung (Barrierefreiheit) und richten Terminservicestellen ein, die an Werktagen unter einer bundesweit einheitlichen Telefonnummer und 24 Stunden täglich über ein bundesweit einheitliches digitales Angebot erreichbar sein müssen; die Terminservicestellen können in Kooperation mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen betrieben werden. Die Leistungen der Terminservicestellen sind telefonisch und im Rahmen des digitalen Angebotes durch Kooperation mit digitalen Dolmetschdiensten in den wichtigsten Sprachen und in Gebärdensprache anzubieten. Genauer regelt die Kassenärztliche Bundesvereinigung.“

bb) Der neue Satz 5 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 3 wird die Angabe „unterstützen und“ durch die Angabe „unterstützen.“ ersetzt.

bbb) Nummer 4 wird gestrichen.

cc) Der neue Satz 6 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „oder einem Frauenarzt“ durch die Angabe „oder einem Frauenarzt und“ ersetzt.

- bbb) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
- „2. der Fälle, in denen bei einer zuvor erfolgten Inanspruchnahme eines Integrierten Notfallzentrums nach den §§ 123 und 123b eine weitere Behandlungsnotwendigkeit festgestellt wurde.“
- ccc) Nummer 3 wird gestrichen.
- dd) Der neue Satz 13 wird wie folgt geändert:
- aaa) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 76 Absatz 1a Satz 2.“ durch die Angabe „§ 76 Absatz 1a Satz 2,“ ersetzt.
- bbb) Nach Nummer 5 wird die folgende Nummer 6 eingefügt:
- „6. zur Gewährleistung der einheitlichen telefonischen Erreichbarkeit der Terminservicestellen.“
- ee) Die neuen Sätze 20 und 21 werden gestrichen.
- ff) Nach dem neuen Satz 23 wird der folgende Satz eingefügt:
- „Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben Integrierten Notfallzentren nach § 123 und Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123b die Buchung von Behandlungsterminen für die Fälle des Absatzes 1a Satz 6 Nummer 2 bei Vertragsärzten zu ermöglichen.“
- b) Absatz 1b wird durch die folgenden Absätze 1b bis 1f ersetzt:
- „(1b) Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst auch die vertragsärztliche Erstversorgung 24 Stunden täglich in Fällen, in denen eine unverzügliche Behandlung aus medizinischen Gründen erforderlich ist; die Maßnahmen richten sich nach dem medizinisch erforderlichen Behandlungsbedarf der Versicherten (notdienstliche Akutversorgung) und umfassen je nach medizinischer Erfordernis auch die fallabschließende Behandlung oder Weiterleitung in eine weiterführende ambulante Behandlung. Die besonderen Bedarfe in der Notfallbehandlung psychisch erkrankter Menschen und der Intervention bei psychischen Krisen sind zu berücksichtigen. Die notdienstliche Akutversorgung umfasst auch die Feststellung und Bescheinigung einer Arbeitsunfähigkeit sowie die Verordnung von Arzneimitteln, Krankenfahrten, Krankentransporten und Apotheken-Botendiensten. Nicht vom Sicherstellungsauftrag nach Satz 1 umfasst ist die notärztliche Versorgung im Rahmen des Rettungsdienstes, soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen stellen die notdienstliche Akutversorgung insbesondere durch
1. die Beteiligung an Integrierten Notfallzentren nach § 123 und Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123b,
 2. ein telefonisches und videounterstütztes ärztliches Versorgungsangebot 24 Stunden täglich auch durch Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und
 3. einen aufsuchenden Dienst 24 Stunden täglich
- sicher (Notdienst). Zur wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben nach Satz 5 Nummer 2 und 3 sollen die Kassenärztlichen Vereinigungen untereinander sowie mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kooperieren. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können zur Erfüllung der Aufgabe nach Satz 5 Nummer 3 speziell geschulte Angehörige der Gesundheitsfachberufe unter ärztlicher Anordnung und Verantwortung einsetzen. Wenn und soweit Landesrecht dies zulässt, können sie hierfür Kooperationen mit dem Rettungsdienst eingehen. Der aufsuchende Dienst nach Satz 5 Nummer 3 ist so zu planen, dass 10 Prozent der dringlichen Einsätze innerhalb von einer Stunde, 90 Prozent der weniger dringlichen Einsätze innerhalb von vier Stunden und 100 Prozent der Einsätze in einer Planungsregion innerhalb von sechs Stunden versorgt werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen können Integrierte Notfallzentren nach § 123 durch kinder- und jugendmedizinische telemedizinische Konsilien nach § 367 oder telefonische Konsilien unterstützen. Nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende zugelassene Krankenhäuser und Ärzte, die aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung in den Notdienst einbezogen sind, sind zur Leistungserbringung im Rahmen des Notdiens-

tes berechtigt und nehmen zu diesem Zweck an der vertragsärztlichen Versorgung teil. Satz 9 gilt entsprechend für nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte im Rahmen der notärztlichen Versorgung des Rettungsdienstes, soweit entsprechend Satz 3 durch Landesrecht bestimmt ist, dass auch diese Versorgung vom Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen umfasst ist. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen mit den Landesapothekerkammern in einen Informationsaustausch über die Organisation des Notdienstes treten, um die Versorgung der Versicherten zu verbessern. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellt den Kassenärztlichen Vereinigungen bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] ein einheitliches softwaregestütztes System zur Dokumentation der Versorgung durch den Ärztlichen Bereitschaftsdienst, die Akuteitstellen und die Behandlung in einer Notdienstpraxis eines Integrierten Notfallzentrums zur Verfügung, welches die gemeinsame Notfallversorgung der Versicherten sowie eine digitale Fallübergabe, einschließlich aller für die Weiterbehandlung relevanten medizinischen Informationen, bei einer Weiterleitung an eine weiterführende Versorgungseinrichtung sicherstellt. Bei der Bereitstellung des Systems ist die Kompatibilität mit der Telematikinfrastruktur zu gewährleisten.

(1c) Zur Terminvermittlung in Akutfällen und zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1b betreibt jede Kassenärztliche Vereinigung eine Akuteitstelle, die 24 Stunden täglich und spätestens innerhalb von drei Minuten in 75 Prozent der Anrufe und zehn Minuten in 95 Prozent der Anrufe unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer nach Absatz 1a Satz 2 und 24 Stunden täglich über ein bundesweit einheitliches digitales Angebot erreichbar ist; die Erreichbarkeitsvorgaben sind spätestens zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu erfüllen. Die Akuteitstelle hat Versicherten in Akutfällen auf der Grundlage eines bundesweit einheitlichen standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 6 eine unmittelbare ärztliche Versorgung in der medizinisch gebotenen Versorgungsebene, in geeigneten Fällen auch in Form einer telefonischen oder videounterstützten ärztlichen Konsultation, zu vermitteln. Wenn medizinisch erforderlich, muss ein Krankentransport, eine Krankenfahrt oder ein Apothekenbotendienst vermittelt werden. Die Terminvermittlung in Akutfällen, die telefonische oder videounterstützte ärztliche Konsultation und die Vermittlung von Krankentransporten, Krankenfahrten und Apotheken-Botendiensten sind durch Kooperation mit digitalen Dolmetschdiensten oder die Nutzung anderer digitaler Instrumente in den wichtigsten Sprachen und in Gebärdensprache sicherzustellen. Für die Terminvermittlung in die fachärztliche Versorgung bedarf es im Akutfall keiner Überweisung. Auf Antrag eines Trägers einer Rettungsleitstelle ist die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zur Kooperation nach § 133a Absatz 1 Satz 1 verpflichtet.

(1d) Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, personenbezogene Daten der Anrufer zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1a bis 1c und 1e zu verarbeiten und für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.

(1e) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung evaluiert die Auswirkungen der Tätigkeit der Terminservicestellen nach Absatz 1a insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der fristgemäßen Vermittlung von Arztterminen, auf die Häufigkeit der Inanspruchnahme und auf die Vermittlungsquote. Über die Ergebnisse hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung dem Bundesministerium für Gesundheit zum 30. Juni 2025 zu berichten.

(1f) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen stellen den vertragszahnärztlichen Notdienst außerhalb der Sprechstundenzeiten sicher und informieren die Versicherten im Internet in geeigneter Weise bundesweit einheitlich über die Sprechstundenzeiten der Vertragszahnärzte und über die Zugangsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen zur Versorgung (Barrierefreiheit). Die Absätze 1a bis 1e gelten insoweit nicht.“

c) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird die Angabe „Telefonnummer“ durch die Angabe „Rufnummer“ ersetzt.

bb) In den Nummern 5 und 6 wird jeweils die Angabe „Absatz 1a Satz 3 Nummer 3“ durch die Angabe „Absatz 1c Satz 3“ ersetzt.

7. § 76 Absatz 1a wird wie folgt geändert:
 - a) In Satz 1 wird die Angabe „die Terminservicestelle Versicherte in den Fällen des § 75 Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 in eine Notfallambulanz“ durch die Angabe „die Akutleitstelle Versicherte in den in § 75 Absatz 1c Satz 3 genannten Fällen in eine Notaufnahme“ ersetzt.
 - b) In Satz 2 wird nach der Angabe „Die Inanspruchnahme umfasst“ die Angabe „in den in Satz 1 erster Halbsatz genannten Fällen“ eingefügt.
8. In § 87 Absatz 2b Satz 3 Nummer 1 und Absatz 2c Satz 3 Nummer 1 wird jeweils die Angabe „§ 75 Absatz 1a Satz 3 Nummer 4“ durch die Angabe „§ 75 Absatz 1c Satz 2“ ersetzt und wird jeweils die Angabe „Terminservicestelle“ durch die Angabe „Akutleitstelle“ ersetzt.
9. In § 87a Absatz 3 Satz 5 Nummer 3 wird die Angabe „§ 75 Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 und 4“ durch die Angabe „§ 75 Absatz 1a Satz 5 Nummer 1 und durch die Akutleitstelle nach § 75 Absatz 1c Satz 2“ ersetzt.
10. § 90 wird wie folgt geändert:
 - a) In Absatz 4 Satz 2 wird nach der Angabe „erweiterten Landesausschüssen nach § 116b Absatz 3“ die Angabe „, § 123 Absatz 6, § 123a Absatz 1 und 4 sowie § 123b Absatz 1“ eingefügt.
 - b) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Der Landesausschuss nach Absatz 1 wird für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 116b Absatz 2, § 123 Absatz 6, § 123a Absatz 1 sowie § 123b Absatz 1 um Vertreter der Krankenhäuser in der gleichen Zahl erweitert, wie sie nach Absatz 2 jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und die Vertreter der Ärzte vorgesehen ist (erweiterter Landesausschuss). Die Vertreter der Krankenhäuser werden von der Landeskrankenhausgesellschaft bestellt. Über den Vorsitzenden des erweiterten Landesausschusses und die zwei weiteren unparteiischen Mitglieder sowie deren Stellvertreter sollen sich die beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen sowie die Landeskrankenhausgesellschaft einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, werden sie durch die für die Sozialversicherung zuständige oberste Verwaltungsbehörde des Landes im Benehmen mit den beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen, den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie der Landeskrankenhausgesellschaft berufen. Die dem erweiterten Landesausschuss durch die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 116b Absatz 2, § 123 Absatz 6, § 123a Absatz 1 sowie § 123b Absatz 1 entstehenden Kosten werden zur Hälfte von den Verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie zu je einem Viertel von den beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen und der Landeskrankenhausgesellschaft getragen. Der erweiterte Landesausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit; bei der Gewichtung der Stimmen zählen die Stimmen der Vertreter der Krankenkassen doppelt. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 ist Einvernehmen mit den obersten Landesplanungsbehörden herzustellen. Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 123 Absatz 6, § 123a Absatz 1 sowie § 123b Absatz 1 erhalten Vertreter der Leistungserbringer im Rettungsdienst ein Mitberatungsrecht im Umfang einer Stimme. Kommt die Festlegung nach § 123a Absatz 1 oder § 123b Absatz 1 ganz oder teilweise nicht fristgemäß zustande, setzt die für die Sozialversicherung zuständige oberste Landesbehörde unverzüglich eine Nachfrist, die sechs Wochen nicht überschreiten darf. Ist auch die Nachfrist ergebnislos verstrichen, erfolgt die Festlegung durch die für die Sozialversicherung zuständige oberste Landesbehörde innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Nachfrist. Der erweiterte Landesausschuss stellt die hierfür erforderlichen Informationen, Unterlagen und Stellungnahmen unverzüglich zur Verfügung. Die Standortbestimmungen nach § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 sind in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.“
11. In § 90a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „und der Landeskrankenhausgesellschaft“ durch die Angabe „, der Landeskrankenhausgesellschaft und der Rettungsdienste“ ersetzt.
12. In § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 wird nach der Angabe „Krankentransporten“ ein die Angabe „, Krankentransportflüge und Krankenfahrten“ eingefügt.“

13. § 105 Absatz 1b wird durch den folgenden Absatz 1b ersetzt:

„(1b) Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich vereinbaren über die Mittel nach Absatz 1a hinaus einen zusätzlichen jährlich von beiden Vertragsparteien in gleicher Höhe bereitzustellenden zweckgebundenen Betrag zur Förderung der Sicherstellung der Strukturen des Notdienstes. Die privaten Krankenversicherungsunternehmen müssen in die Vertragsverhandlungen einbezogen werden, um eine finanzielle Beteiligung an den Strukturen des Notdienstes zu vereinbaren. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. bestimmt das Nähere zur Umsetzung der Beteiligung der privaten Krankenversicherungsunternehmen. Der von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bereitzustellende Betrag vermindert sich um den durch die privaten Krankenversicherungsunternehmen nach Satz 2 bereitgestellten Betrag. Die Mittel müssen für folgende Maßnahmen verwendet werden:

1. Förderung der Strukturen nach § 75 Absatz 1b Satz 5 Nummer 2 und 3, Absatz 1c und § 133a,
2. Förderung der integrierten Notfallstrukturen nach den §§ 123 bis 123b.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen legen hierzu ihren Vertragspartnern eine detaillierte Kalkulation und den Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen insbesondere zur Vernetzung und Kooperation vor. Die nach der regionalen Euro-Gebührenordnung oder nach Gesamtvertrag abrechenbaren Leistungen und Kosten sowie die von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht verbrauchten Mittel des Honorarvolumens nach § 87b Absatz 1 Satz 3 sind mindernd zu berücksichtigen. Der vereinbarte Betrag und das Fortbestehen der Voraussetzungen nach Satz 1 sind jährlich von den Vertragsparteien zu überprüfen. § 89 gilt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat erstmals bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] und anschließend jährlich dem Bundesministerium für Gesundheit über die Anzahl und den jeweiligen Stand der Vereinbarungen einschließlich der vereinbarten Beträge zu berichten.“

14. Nach § 115a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Die Behandlung nach Satz 1 Nummer 1 ist auch bei Zuweisung der Versicherten durch den Rettungsdienst zulässig, wenn das Krankenhaus über ein Integriertes Notfallzentrum nach § 123 verfügt.“

15. § 115e Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- a) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

„Im Rahmen der tagesstationären Behandlung besteht ab dem Zeitpunkt der ersten Aufnahme im Krankenhaus kein Anspruch auf Kostenübernahme für Krankentransporte und Krankenfahrten nach § 60; ausgenommen sind Krankenfahrten, die nach § 60 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe b in Verbindung mit den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 auch zu ambulanten Behandlungen übernahmefähig wären.“

- b) Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:

„Der Anspruch auf Notfalltransport nach § 30 bleibt unberührt.“

16. § 116b wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 1 erweiterten Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen nach § 90 Absatz 1“ durch die Angabe „erweiterten Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a“ ersetzt.

- b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

„(3) Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a kann für die Beschlussfassung über Entscheidungen im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach Absatz 2 in seiner Geschäftsordnung abweichend von § 90 Absatz 4a Satz 1 die Besetzung mit einer kleineren Zahl von Mitgliedern festlegen; die Mitberatungsrechte nach § 90 Absatz 4a Satz 7 sowie § 140f Absatz 3 bleiben unberührt. Er ist befugt, geeignete Dritte ganz oder teilweise mit der Durchführung von Aufgaben nach Absatz 2 zu beauftragen und kann hierfür nähere Vorgaben beschließen.“

17. § 120 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „nach § 75 Absatz 1b Satz 2“ durch die Angabe „nach § 75 Absatz 1b Satz 9“ ersetzt.
- b) Absatz 3b wird gestrichen.

18. § 123 wird durch den folgenden § 123 ersetzt:

„§ 123

Integrierte Notfallzentren

(1) Integrierte Notfallzentren bestehen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (Notdienstpraxis) in räumlicher Integration mit der Notaufnahme des Krankenhauses und einer zentralen Ersteinschätzungsstelle. Die fachliche Leitung und Verantwortung für die zentrale Ersteinschätzungsstelle obliegt dem Krankenhaus, wenn in der Kooperationsvereinbarung nach § 123a Absatz 2 nichts Abweichendes geregelt ist. Die Kassenärztlichen Vereinigungen stellen die notdienstliche Akutversorgung insbesondere durch Kooperation und organisatorische Verknüpfung mit zugelassenen Krankenhäusern im Rahmen von Integrierten Notfallzentren sicher und binden die Notaufnahme des jeweiligen Krankenhauses unmittelbar in den Notdienst gemäß § 75 Absatz 1b Satz 9 ein. Zugelassene Krankenhäuser, von denen ein Standort nach § 123a Absatz 1 Satz 1 als Standort eines Integrierten Notfallzentrums bestimmt worden ist, sind zur Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung verpflichtet. Innerhalb des Integrierten Notfallzentrums erfolgt eine digitale Fallübergabe in einem interoperablen Datenformat unter Beachtung der geltenden verbindlichen Festlegungen nach § 385 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und unter Sicherstellung einer technischen Schnittstelle zum System der digitalen Fallübergabe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Absatz 1b.

(2) Für Hilfesuchende, die mit einem von ihnen als dringend erachteten gesundheitlichen Anliegen selbständig ein Integriertes Notfallzentrum aufsuchen, trifft die zentrale Ersteinschätzungsstelle eine Entscheidung über die Behandlungsdringlichkeit und die geeignete Versorgungsebene innerhalb des jeweiligen Integrierten Notfallzentrums. Die Ersteinschätzung kann im Wege der Delegation erbracht werden. Ab dem Zeitpunkt, den der Gemeinsame Bundesausschuss nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 bestimmt, erfolgt die Ersteinschätzung auf der Grundlage eines standardisierten digitalen Ersteinschätzungsinstrumentes. Wenn nach einer notdienstlichen Akutversorgung im Integrierten Notfallzentrum eine ambulante Weiterbehandlung erforderlich ist, ist die Buchung eines Termins für die Patienten in der ambulanten Regelversorgung über das System der Terminservicestelle verpflichtend. Wird ein Termin über die Terminservicestelle vereinbart, geht die medizinische Verantwortung für die Versicherten in die vertragsärztliche Versorgung über. Wird kein Termin vereinbart, verbleibt die medizinische Verantwortung für die Versicherten bei dem Krankenhaus. Hilfesuchende, die das Integrierte Notfallzentrum im Rahmen einer telefonischen Vermittlung durch die Akutleitstelle aufsuchen, sind dort bei gleicher medizinischer Behandlungsdringlichkeit nach Satz 1 grundsätzlich vorrangig zu behandeln. Das Nähere zum Nachweis der Vermittlung regelt der Bundesmantelvertrag.

(3) Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in einer Richtlinie

1. Vorgaben an ein standardisiertes digitales Ersteinschätzungsinstrument, das für Hilfesuchende einerseits die Dringlichkeit des Behandlungsbedarfs feststellt und andererseits die Bestimmung der sachgerechten Versorgungsebene innerhalb der Kooperation nach Absatz 1 als Grundlage für die Ersteinschätzungsstelle ermöglicht,
2. Vorgaben zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen nach Nummer 1 durch das Ersteinschätzungsinstrument,
3. Vorgaben zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Verwendung des Ersteinschätzungsinstrumentes an der jeweiligen Ersteinschätzungsstelle,

4. den Zeitpunkt, ab dem das Ersteinschätzungsinstrument von der Ersteinschätzungsstelle zu verwenden ist,
5. Mindestanforderungen an die sachliche und personelle Ausstattung der Notdienstpraxen und der Ersteinschätzungsstelle in Integrierten Notfallzentren, inklusive der Mindestanforderungen an die Qualifikation des eingesetzten Personals,
6. einen Katalog von Mindestanforderungen an die Auswahl der Standorte zur Einrichtung von Integrierten Notfallzentren nach § 123a Absatz 1 und Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123b,
7. Vorgaben zum Nachweis und zur Kontrolle der Einhaltung der Mindestanforderungen nach Nummer 5 sowie
8. das Nähere zur Umsetzung des Überprüfungs- und Berichtsauftrags nach Satz 6, einschließlich der Übermittlung der hierzu erforderlichen Informationen an den Gemeinsamen Bundesausschuss.

Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Regelungen zu einem gestuften System der Notfallversorgung in Krankenhäusern nach § 136c Absatz 4 in der Fassung vom 19. April 2018 (BAnz AT 18.5.2018 B4), geändert am 20. November 2020 (Banz AT 24.12.2020 B2), sind zu berücksichtigen. Die Vergütung der Ersteinschätzung nach § 123 Absatz 4 setzt ab dem Zeitpunkt, den der Gemeinsame Bundesausschuss nach Satz 1 Nummer 4 bestimmt, voraus, dass ein Nachweis nach Satz 1 Nummer 3 erbracht wird. § 92 Absatz 7e gilt entsprechend. Vor der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Richtlinie nach Satz 1 ist den einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Auswirkungen der Richtlinie nach Satz 1 hinsichtlich der Entwicklung der Inanspruchnahme der Notaufnahmen und der Notdienstpraxen, der Auswirkungen auf die Patientenversorgung sowie die Erforderlichkeit einer Anpassung seiner Regelungen bis zum 31. Dezember 2026 zu prüfen und dem Bundesministerium für Gesundheit zu berichten.

(4) Mit Wirkung zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des übernächsten auf die Verkündung folgenden Quartals] beschließt der Bewertungsausschuss in der Zusammensetzung nach § 87 Absatz 5a im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztliche Leistungen die notwendigen Anpassungen für die Vergütung der Ersteinschätzung nach Absatz 2 Satz 1 als unabhängig von der Weiterbehandlung zu vergütende Einzelleistung. Er hat die Auswirkungen des Beschlusses nach Satz 1 hinsichtlich der Entwicklung der Leistungen der Notaufnahmen und der Notdienstpraxen, der Auswirkungen auf die Versorgung und Vergütung zu evaluieren und hierüber dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2027 zu berichten; § 87 Absatz 3a gilt entsprechend.

(5) Integrierte Notfallzentren haben bei einem Hinweis auf eine vorliegende psychische Erkrankung psychiatrische und psychosomatische Behandlungskompetenz sicherzustellen. Bei fehlender psychiatrischer und psychosomatischer Behandlungskompetenz ist diese durch ein externes Fachkrankenhaus durch telemedizinische Konsile nach § 367 oder telefonische Konsile von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, Fachärzten für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Fachpsychotherapeuten für Erwachsene oder Fachpsychotherapeuten für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Bei Hinweisen auf akute psychische Krisen sind, wo möglich, die psychiatrischen und psychosozialen Krisendienste einzubeziehen.

(6) Integrierte Notfallzentren haben bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen Unterstützung durch telemedizinische Konsilien nach § 367 oder telefonische Konsilien von Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin zu gewährleisten, wenn an ihrem Standort kein Integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche vorhanden ist. Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a bestimmt die Konzeption und Koordinierung dieser telemedizinischen Unterstützung. Die entsprechenden Integrierten Notfallzentren haben die erforderliche technische Ausstattung für eine telemedizinische Anbindung vorzuhalten.

(7) Die Kassenärztlichen Vereinigungen berichten den für die Sozialversicherung und den für die Krankenhausplanung zuständigen obersten Verwaltungsbehörden der Länder jährlich, erstmals zum ... [einsetzen: erster Tag des 18. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats], über die Versorgung in den Integrierten Notfallzentren in Hinblick auf Abweichungen von den gesetzlichen Öffnungszeiten der Notdienst-

praxis, auf die Anzahl der eingerichteten Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche und auf die Anteile der Inanspruchnahme des Integrierten Notfallzentrums mit und ohne vorherigen Kontakt zur Akutleitstelle. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich, erstmals zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des 18. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats].

(8) Die Vergütung von ambulanten Leistungen zur Behandlung von Notfällen nach § 76 Absatz 1 Satz 2 im Krankenhaus setzt ab dem Inkrafttreten der Richtlinie nach Absatz 3 voraus, dass das Ersteinschätzungsinstrument nach Absatz 3 genutzt wurde und ein sofortiger Behandlungsbedarf festgestellt wurde oder eine Weiterleitung nach Satz 2 aufgrund fehlender Verfügbarkeit von Kapazitäten in der Notdienstpraxis des nächstgelegenen Integrierten Notfallzentrums, aufgrund des Fehlens eines nächstgelegenen Krankenhauses mit Integriertem Notfallzentrum, oder über die Terminservicestelle nicht möglich ist. In allen anderen Fällen sind die Krankenhäuser mit Notaufnahme verpflichtet, die Versicherten gemäß dem Ergebnis des Ersteinschätzungsinstrumentes in die Notdienstpraxis des nächstgelegenen (maximal 30 Minuten Fahrzeit mit Personenkraftwagen) Integrierten Notfallzentrums oder eine Weiterbehandlung im ambulanten Bereich weiterzuleiten und über die Terminservicestelle oder die Akutleitstelle eine entsprechende Terminbuchung vorzunehmen und, falls medizinisch erforderlich, über die Akutleitstelle die Verordnung einer Krankenfahrt zu organisieren. In Fällen, in denen die Behandlung eines Versicherten in einer Notaufnahme stattfindet, die nicht den Regelungen nach Satz 1 entspricht, ist die Vergütung der Leistung nach § 76 Absatz 1 Satz 2 um 50 Prozent zu kürzen. Diese Regelung gilt entsprechend für die Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen in Krankenhäusern ohne ein Integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche.

(9) Alle Krankenhäuser mit Notaufnahme sind verpflichtet, die Daten über die Behandlung der Versicherten in der Notaufnahme im Umfang der aktuellen Version des Notfalldatensatzes der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin an das AKTIN-Notaufnahmeregister zu melden.“

19. Nach § 123 werden die folgenden §§ 123a und 123b eingefügt:

„§ 123a

Einrichtung von Integrierten Notfallzentren

(1) Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a bestimmt bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Standorte der zugelassenen Krankenhäuser, an denen Integrierte Notfallzentren eingerichtet werden. Bei der Bestimmung der Standorte ist ein Einvernehmen mit der obersten Landesplanungsbehörde herzustellen. Er legt hierzu zunächst geeignete Planungsregionen zur flächendeckenden Versorgung mit Integrierten Notfallzentren fest. Ein Krankenhausstandort kann als Standort für ein Integriertes Notfallzentrum bestimmt werden, wenn

1. die Voraussetzung der Notfallstufe Basisnotfallversorgung gemäß den vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Regelungen zu einem gestuften System der Notfallversorgung in Krankenhäusern nach § 136c Absatz 4 in der Fassung vom 19. April 2018 (BAnz AT 18.5.2018 B4), geändert am 20. November 2020 (BAnz AT 24.12.2020 B2), erfüllt sind und
2. keine berechtigten Interessen des Krankenhauses entgegenstehen.

Bei der Standortfestlegung sollen insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt werden:

1. die Erreichbarkeit innerhalb von 30 Fahrzeitminuten für mindestens 95 Prozent der zu versorgenden Menschen in einer Planungsregion,
2. die Zahl der zu versorgenden Menschen in einer Planungsregion,
3. die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr und
4. die Möglichkeiten der Kooperation mit Vertragsärzten oder medizinischen Versorgungszentren in der Nähe des Krankenhauses.

Wenn in einer Planungsregion mehrere Krankenhausstandorte für die Einrichtung eines Integrierten Notfallzentrums gleich geeignet sind, sollen Krankenhausstandorte bevorzugt werden, die eine höhere Notfallstufe

gemäß den vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Regelungen zu einem gestuften System der Notfallversorgung in Krankenhäusern nach § 136c Absatz 4 in der in Satz 3 Nummer 1 genannten Fassung erfüllen oder eine nach anderen objektiven Kriterien, insbesondere Fallzahlen, leistungsfähigere Notaufnahme aufweisen,

1. die notfallmedizinisch relevante Fachabteilungen vorhalten und
2. in denen Notdienstpraxen unmittelbar in der Notaufnahme eingerichtet werden können.

Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a kann abweichend von den Sätzen 3 bis 5 einen Krankenhausstandort bestimmen, wenn dies zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erforderlich ist. Die Bestimmung eines Krankenhausstandorts durch den erweiterten Landesausschuss nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt durch Bescheid. Gegen den Bescheid ist der Rechtsweg vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit eröffnet. Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Zur Organisation des Integrierten Notfallzentrums schließen die Kassenärztliche Vereinigung und der Krankenhausträger innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Krankenhausstandort als Standort eines Integrierten Notfallzentrums nach Absatz 1 Satz 1 bestimmt worden ist, eine Kooperationsvereinbarung. Sie richten ein gemeinsames Organisationsgremium zur operativen Umsetzung der Zusammenarbeit und eines gemeinsamen Qualitätsmanagements ein. Die Kooperationspartner sind befugt, die für das gemeinsame Qualitätsmanagement erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten. In der Kooperationsvereinbarung nach Satz 1 ist insbesondere das Nähere zu vereinbaren

1. zu dem gemeinsamen Organisationsgremium nach Satz 2,
2. zur Vernetzung und interoperablen, digitalen Fallübergabe innerhalb des Integrierten Notfallzentrums,
3. zur Durchführung der Ersteinschätzung nach § 123 Absatz 2 bis zu dem vom Gemeinsamen Bundesausschuss in seiner Richtlinie nach § 123 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 festgelegten Zeitpunkt,
4. zur Organisation und zur personellen Besetzung der Ersteinschätzungsstelle einschließlich der Qualifikationen, erforderlichen Schulungen und regelmäßigen Fortbildungen des Personals gemäß den Mindestanforderungen der Richtlinie nach § 123 Absatz 3 Nummer 5,
5. zur Anmietung oder eigenen Gestellung von Räumlichkeiten, Einrichtung und Verbrauchsmaterial der Notdienstpraxis,
6. zur Nutzung der technischen und diagnostischen Einrichtungen des Krankenhauses durch die Notdienstpraxis einschließlich Nutzungsentgelten,
7. zu Regelungen für den Fall wiederholter und schwerwiegender Verstöße gegen die Kooperationsvereinbarung oder für den Fall, dass die Notdienstpraxis zu den Zeiten nach Satz 4 oder 5 nicht geöffnet hat.

Die Notdienstpraxis ist im Rahmen der Kooperation täglich von 10 bis 22 Uhr zu öffnen. Kürzere Öffnungszeiten können in der Kooperationsvereinbarung festgelegt werden, soweit aufgrund von empirischen Daten belegbar ist, dass die Öffnungszeiten nach Satz 4 aufgrund der tatsächlichen regionalen Inanspruchnahme nicht bedarfsnotwendig sind. Entsprechende vertragliche Regelungen nach Satz 4 können als Rahmenvertrag in dreiseitigen Verträgen nach § 115 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 landesweit vorgegeben werden.

(3) Kommt eine Kooperationsvereinbarung nach Absatz 2 nicht rechtzeitig zustande, wird der Vertragsinhalt durch eine von den Vertragspartnern zu bestimmende unabhängige Schiedsperson innerhalb von drei Monaten festgelegt. Einigen sich die Vertragspartner nicht auf eine Schiedsperson, wird diese innerhalb eines Monats nach Vorliegen der für die Bestimmung der Schiedsperson notwendigen Informationen von der für die Sozialversicherung zuständigen obersten Verwaltungsbehörde des Landes bestimmt. Die Kosten des Schiedsverfahrens tragen die Vertragsparteien zu gleichen Teilen. Klagen gegen die Bestimmung der Schiedsperson haben keine aufschiebende Wirkung. Klagen gegen die Festlegung des Vertragsinhalts richten sich gegen eine der beiden Vertragsparteien, nicht gegen die Schiedsperson.

(4) Nach § 75 Absatz 1b Satz 3 in der Fassung vom ... [einsetzen: Datum des Tages vor der Verkündung] in oder an Krankenhäusern eingerichtete Notdienstpraxen sind in Integrierte Notfallzentren zu überführen.

§ 123b

Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche

(1) Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a kann Standorte zugelassener Krankenhäuser bestimmen, an denen Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden. Bis zum [...] [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] hat er erstmals über die Einrichtung von Standorten nach Satz 1 zu entscheiden. Ein Krankenhausstandort kann als Standort für ein Integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche bestimmt werden, wenn

1. die Voraussetzungen des Moduls Notfallversorgung Kinder gemäß den vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Regelungen zu einem gestuften System der Notfallversorgung in Krankenhäusern nach § 136c Absatz 4 in der Fassung vom 19. April 2018 (BAnz AT 18.5.2018 B4), geändert am 20. November 2020 (BAnz AT 24.12.2020 B2), erfüllt sind und
2. keine berechtigten Interessen des Krankenhauses oder der Kassenärztlichen Vereinigung entgegenstehen.

(2) § 123 Absatz 1 bis 3 und 5 sowie § 123a Absatz 2 bis 4 gelten entsprechend.“

20. § 133 wird durch den folgenden § 133 ersetzt:

„§ 133

Versorgung mit Leistungen der medizinischen Notfallrettung, Krankentransporten, Krankentransportflügen und Krankenfahrten

(1) Leistungen der medizinischen Notfallrettung nach § 30 werden ausschließlich durch Leistungserbringer erbracht, die nach Landesrecht dafür vorgesehen oder beauftragt worden sind. Die Planung, Organisation, Steuerung und Überwachung des Rettungsdienstes ist den Ländern vorbehalten.

(2) Soweit die Entgelte für die Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen der medizinischen Notfallrettung und von Krankentransporten nicht durch landesrechtliche oder kommunalrechtliche Bestimmungen festgelegt werden, schließen die Krankenkassen oder ihre Landesverbände Verträge über die Vergütung dieser Leistungen unter Beachtung des § 71 Absatz 1 bis 3 mit den zuständigen Landesbehörden oder mit den nach Landesrecht vorgesehenen Trägern oder beauftragten Einrichtungen oder Unternehmen. Kommt eine Vereinbarung nach Satz 1 nicht zu Stande und sieht das Landesrecht für diesen Fall eine Festlegung der Vergütungen vor, ist auch bei dieser Festlegung § 71 Absatz 1 bis 3 zu beachten. Die besonderen Anforderungen für Rettungsleitstellen, die Teil eines Gesundheitsleitsystems nach § 133a sind, sind angemessen zu berücksichtigen. Die für die Kalkulation der Vergütung der einzelnen Leistungen zu Grunde liegenden Daten müssen den Krankenkassen oder ihren Landesverbänden vor Vertragsschluss transparent vorliegen. Die Empfehlungen des Qualitätsausschusses Notfallrettung nach § 133c Absatz 1 Nummer 1 sind zu berücksichtigen. Die vereinbarten Preise sind Höchstpreise. Die Preisvereinbarungen haben sich an möglichst preisgünstigen Versorgungsmöglichkeiten auszurichten.

(3) Die Entgelte für die Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen der medizinischen Notfallrettung und von Krankentransporten werden durch landesrechtliche oder kommunalrechtliche Bestimmungen festgelegt oder aufgrund landesrechtlicher Regelungen ermittelt. Versicherte haben Anspruch auf die medizinische Notfallrettung unabhängig von der Entgeltfestsetzung. Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen, die zu diesem Zweck in jedem Land eine Arbeitsgemeinschaft bilden, setzen für die Leistungen nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 einheitliche Festbeträge für ein Bundesland, eine Kommune oder einen administrativen Rettungsdienstbereich insoweit fest, wenn

1. die Berechnungsgrundlagen nicht transparent dargelegt wurden oder die Entgelte nicht nach den Leistungsbereichen des § 30 Absatz 2 differenzieren oder vor der Entgeltfestsetzung den Krankenkassen oder ihren Verbänden keine Gelegenheit zur Erörterung gegeben wurde,

2. bei der Entgeltbemessung Investitionskosten und Kosten der Reservevorhaltung berücksichtigt worden sind, die durch eine über die Sicherstellung der Leistungen der medizinischen Notfallrettung und von Krankentransporten hinausgehende öffentliche Aufgabe bedingt sind, oder
3. die Leistungserbringung gemessen an den rechtlich vorgegebenen Sicherstellungsverpflichtungen unwirtschaftlich ist oder sie die Empfehlungen des Qualitätsausschusses Notfallrettung nach § 133c Absatz 1 Nummer 1 nicht berücksichtigen.

(4) Die Krankenkassen oder ihre Landesverbände schließen Verträge über die Vergütung der Krankenfahrten nach § 60 unter Beachtung des § 71 Absatz 1 bis 3 mit dafür geeigneten Einrichtungen oder Unternehmen.

(5) Das Landesrecht kann die unmittelbare Abrechnung der Leistungserbringer mit den Krankenkassen vorsehen.

(6) Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt in einer Richtlinie das Nähere zum Verfahren und zur Umsetzung der Vertragsgestaltung nach Absatz 2 Satz 1 und von Festbeträgen nach Absatz 3 Satz 3 Nummer 3.“

21. Nach § 133 werden die folgenden § 133a bis 133e eingefügt:

„§ 133a

Gesundheitsleitsystem

(1) Die Träger der Rettungsleitstellen und die Kassenärztlichen Vereinigungen als Träger der Akutleitstelle, die eine Kooperation nach Absatz 2 eingehen, arbeiten im Rahmen einer digitalen Vernetzung der Leitstellen verbindlich zusammen und bilden ein Gesundheitsleitsystem. Darüber hinaus sind weitere Formen der Zusammenarbeit bis hin zur gemeinsamen Trägerschaft im Einvernehmen der Kooperationspartner möglich. Das Gesundheitsleitsystem vermittelt Hilfesuchenden, die sich entweder an die Akutleitstelle oder an die Rettungsleitstelle wenden, die erforderliche medizinische Versorgung. Die weiteren Aufgaben der Kooperationspartner bleiben unberührt.

(2) Auf Antrag eines Trägers einer Rettungsleitstelle ist die zuständige Kassenärztliche Vereinigung zur Kooperation nach Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. Voraussetzung für die Kooperation ist, dass die Rettungsleitstelle über eine digitale standardisierte Notrufabfrage verfügt. Die Verfahren der Notrufabfrage der Rettungsleitstelle und das bundesweit einheitliche standardisierte Ersteinschätzungsverfahren der Kassenärztlichen Vereinigungen sind als Abfragesysteme im Gesundheitsleitsystem so aufeinander abzustimmen, dass es zu übereinstimmenden Bewertungen des Gesundheitszustandes kommt. In einer Kooperationsvereinbarung sind die Einzelheiten der Zusammenarbeit festzulegen. Es ist insbesondere die Abstimmung der Abfragesysteme und der für das jeweilige Abfrageergebnis aufgrund der infrage kommenden Versorgungsstrukturen zuständigen Kooperationspartner zu vereinbaren. Die Einhaltung der Standards der Abfragesysteme im Gesundheitsleitsystem müssen überprüfbar sein und einer kontinuierlichen Kontrolle unterliegen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen wirken darauf hin, dass die Vereinbarungen zur Abstimmung der Abfragesysteme mit den Rettungsleitstellen möglichst einheitlich sind. Es ist eine Verpflichtung zur Übernahme und unverzüglichen Bearbeitung von Fällen vorzusehen, die aufgrund des Ergebnisses des jeweiligen Abfragesystems und der erfolgten Festlegungen der Zuständigkeiten an die jeweils andere Leitstelle übergeben werden. Die beiden Kooperationspartner müssen technisch so miteinander vernetzt sein, dass eine unmittelbare telefonische Weiterleitung und Bearbeitung des Hilfeersuchens erfolgen kann. Die jeweils aufgenommenen Daten müssen medienbruchfrei an den anderen Kooperationspartner übertragen werden. Für die Vernetzung ist, sobald die hierfür erforderlichen Dienste und Komponenten flächendeckend zur Verfügung stehen, die Telematikinfrastruktur zu nutzen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellt eine technische und inhaltliche Schnittstelle zur Fallübergabe zur Verfügung, die mit dem System zur digitalen Fallübergabe und Dokumentation nach § 75 Absatz 1b mindestens technisch kompatibel ist.

(3) Die Kooperationspartner nach Absatz 1 Satz 1 vereinbaren ein gemeinsames Qualitätsmanagement für die ständige Evaluation der Abstimmung der Abfragesysteme und die Zuordnung von Hilfesuchenden zur jeweiligen Versorgungsebene nach Absatz 2. Hierfür sind die einzelnen Prozessabläufe der Abfrage

in den Leitstellen nachverfolgbar zu dokumentieren, mit den entsprechenden Daten der jeweils vermittelten aufsuchenden Leistungserbringer zusammenzuführen und auszuwerten. Dafür übermitteln diese der Leitstelle die hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten. Die Kooperationspartner nach Absatz 1 Satz 1 sind befugt, personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Absatz zu verarbeiten, sie untereinander auszutauschen und für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Dies gilt auch für aufgrund von Einwilligung oder auf der Grundlage von landesrechtlichen Befugnisnormen aufgezeichnete Anrufe. Das Nähere regelt die Kooperationsvereinbarung nach Absatz 2.

(4) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Vertragsparteien vermitteln Krankentransporte, soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Sie sollen Leistungen der speziellen ambulanten Notfallversorgung sowie komplementäre Dienste für vulnerable Gruppen vermitteln.

(5) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet erstmals bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] und anschließend jährlich dem Bundesministerium für Gesundheit über die Anzahl sowie den jeweiligen Stand und die wesentlichen Inhalte der Vereinbarungen nach Absatz 2 einschließlich der Auswertungen des gemeinsamen Qualitätsmanagements. Das Bundesministerium für Gesundheit kann das Nähere zum Inhalt des Berichts und zu den dafür erforderlichen Auswertungen bestimmen. Der Bericht ist zwei Monate nach Zuleitung durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung durch das Bundesministerium für Gesundheit in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

§ 133b

Qualitätsausschuss Notfallrettung

(1) Das Bundesministerium für Gesundheit richtet einen Qualitätsausschuss Notfallrettung ein. Der Qualitätsausschuss Notfallrettung hat die Aufgabe, Empfehlungen nach § 133c zu erlassen. Diese sind ständig zu überprüfen, erforderlichenfalls fortzuschreiben und zu ändern. Der Qualitätsausschuss berät das Bundesministerium für Gesundheit in allen Fragen der medizinischen Notfallrettung.

(2) Der Qualitätsausschuss Notfallrettung besteht aus 31 stimmberechtigten Mitgliedern und einem Vorsitzenden. Die Bundesländer können jeweils ein Mitglied und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen acht Mitglieder vorschlagen. Die Mitglieder, die der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vorschlagen kann, verfügen über jeweils zwei Stimmen. Die Mitglieder der Bundesländer und die Mitglieder des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen bestimmen mit einfacher Mehrheit einen unabhängigen Vorsitz, der über kein Stimmrecht verfügt. Können sich die Mitglieder bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] nicht auf einen Vorsitz einigen, ernennt das Bundesministerium für Gesundheit nach sachgerechtem Ermessen unverzüglich einen kommissarischen Vorsitz für die Dauer von einem Jahr. Die Mitglieder, die aufgrund von Satz 2 ernannt werden, können mit einfacher Mehrheit insgesamt sieben weitere Vertreter aus den Bereichen der Leistungserbringer des Rettungsdienstes, der maßgeblichen Fachgesellschaften und der maßgeblichen Berufsverbände im Rettungsdienst vorschlagen. Das Bundesministerium für Gesundheit ernennt die vorgeschlagenen Personen, wenn keine grundlegenden Bedenken gegen die Ernennung bestehen. Wird bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] von den Vorschlagsrechten kein abschließender Gebrauch gemacht, ernennt das Bundesministerium für Gesundheit nach sachgerechtem Ermessen unverzüglich die fehlenden Mitglieder nach den Sätzen 2 und 6. Die Mitglieder sind bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden. Die Amtszeit der Ausschussmitglieder beträgt fünf Jahre. Der Qualitätsausschuss Notfallrettung legt das Nähere zur Arbeitsweise, Besetzung und Beschlussfassung unverzüglich in einer Geschäftsordnung fest. Die Geschäftsordnung und ihre Änderung bedürfen der Genehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit. Die Genehmigung der Geschäftsordnung durch das Bundesministerium für Gesundheit beschränkt sich auf die rechtliche Zulässigkeit. Wird die Geschäftsordnung nicht bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] beschlossen, legt das Bundesministerium für Gesundheit die Geschäftsordnung unverzüglich fest. Zur Koordinierung der Tätigkeit des Ausschusses richtet das Bundesministerium für Gesundheit eine Geschäftsstelle ein.

(3) Der Qualitätsausschuss Notfallrettung kann empfehlen, dass das Bundesministerium für Gesundheit geeignete Dritte beauftragt, Leistungen zur Unterstützung seiner Tätigkeit zu erbringen. Die Patientenorganisationen nach § 140f können beratend an den Sitzungen des Qualitätsausschusses Notfallrettung teilnehmen. Er soll sachverständige Personen hinzuziehen und vor Beschluss der Empfehlungen weitere geeignete Fachgesellschaften und Vertreter der maßgeblichen Berufsverbände und maßgeblichen Leistungserbringer im Rettungsdienst oder deren Verbände anhören.

§ 133c

Empfehlungen des Qualitätsausschusses Notfallrettung

(1) Der Qualitätsausschuss Notfallrettung nach § 133b beschließt Empfehlungen in Form eines Katalogs von Struktur- und Prozessqualitätsparametern für die medizinische Notfallrettung gemäß § 30 sowie für Krankentransporte und Krankentransportflüge gemäß § 60 und schreibt diese fort. Der Katalog berücksichtigt den aktuellen Stand der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse und regelt insbesondere

1. Umfang und Ausgestaltung der jeweiligen Qualitätsparameter,
2. Indikatoren zur Erfassung der Qualitätsparameter nach Nummer 1,
3. den Grad der Umsetzung der Qualitätsparameter nach Nummer 1,
4. Abweichungsmöglichkeiten und
5. den Zeitpunkt der Umsetzung und der regelmäßigen Evaluation der einzelnen Qualitätsparameter nach Nummer 1 und die Feststellung einer nicht hinreichenden Berücksichtigung dieser in einem Bundesland, einer Kommune oder einem administrativen Rettungsdienstbereich.

(2) Der Katalog nach Absatz 1 enthält für das Notfallmanagement nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 insbesondere Empfehlungen hinsichtlich

1. der Qualifikation des Personals, der Ausstattung, Besetzung und ärztlichen Leitung der Leitstellen einschließlich des Einsatzes eines Telenotarztes zur Unterstützung und Sicherstellung einer fachgerechten Patientenversorgung,
2. der automatisierten und standardisierten Ortung von Notrufenden,
3. der Nutzung von protokollgestützten, qualitätsgesicherten, standardisierten, softwaregestützten Abfragesystemen sowie standardisierten und qualitätsgesicherten Erste-Hilfe-Anweisungen vor Eintreffen des Rettungsdienstes,
4. Maßnahmen zur Förderung der Laienreanimation und der Ersten Hilfe durch Laien in anderen zeitkritischen lebensbedrohlichen Situationen sowie der Einbindung registrierter Ersthelfer in smartphonebasierte Ersthelfersysteme und die Integration von AED-Registern,
5. nach medizinischer Indikation und disponiertem Einsatzmittel differenzierter Hilfsfristen beziehungsweise Planungsfristen sowie Maßnahmen zur Optimierung des jeweiligen Zielerreichungsgrades,
6. der Auswahl von bedarfsgerechten Einsatzmitteln (Disposition) und Maßnahmen zur Disposition anhand des Einsatzmittelstandorts,
7. der Nutzung standardisierter und vernetzter Einsatzleitsysteme (Leitstellensoftware) zur Ermöglichung einer landkreis- und länderübergreifenden Alarmierung von Einsatzmitteln einschließlich der Bereitstellung entsprechender technischer und organisatorischer Schnittstellen,
8. des Einsatzes von digitalen Lösungen zur Patientensteuerung, zur Patientenzuweisung und zur Patientenvoranmeldung mithilfe eines integrierten softwaregestützten Behandlungskapazitäten-Nachweises in geeignete Versorgungseinrichtungen,
9. der Anbindung und Koordination von spezialisierten Formen der ambulanten Notfallversorgung oder weiteren ambulanten Versorgungsformen sowie Maßnahmen des vorbeugenden Rettungsdienstes,

10. der Nutzung digitaler Instrumente zur Weitergabe von Fall- und Einsatzdaten zwischen den am Notfallmanagement beteiligten Akteuren, den Leistungserbringern im Rettungsdienst und den weiterführenden Versorgungseinrichtungen.

(3) Der Katalog nach Absatz 1 enthält für die notfallmedizinische Versorgung, den Notfalltransport und die spezielle ambulante Notfallversorgung nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 bis 4 Empfehlungen insbesondere hinsichtlich

1. der Qualifikation des Personals, der Ausstattung und der Besetzung der Einsatzmittel einschließlich des Einsatzes eines Telenotarztes zur Unterstützung oder Sicherstellung einer fachgerechten Patientenversorgung,
2. nach medizinischer Indikation und disponiertem Einsatzmittel differenzierter Hilfsfristen, soweit medizinisch geboten auch zu Prähospitalzeiten, und Maßnahmen zur Optimierung des jeweiligen Zielerreichungsgrades,
3. der medizinischen Versorgung vor Ort und während des Transports,
4. der Aufgaben der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes,
5. der Entscheidung bezüglich der Art und Weise einer Weiterversorgung im Krankenhaus, in der ambulanten Versorgung und anderen komplementären Systemen,
6. der Qualitätssicherung für die medizinische Notfallrettung,
7. des Einsatzes von Luftrettungsmitteln, Intensivtransportwagen und spezialisierten Rettungsfahrzeugen für die Versorgung von Kindern, soweit medizinisch im Speziellen erforderlich,
8. des Einsatzes eines ärztlichen Führungsdienstes, soweit medizinisch aufgrund der Komplexität des Einsatzgeschehens oder der Durchführung besonderer invasiver medizinischer Maßnahmen erforderlich.

(4) Der Qualitätsausschuss Notfallrettung erstellt entsprechend Absatz 3 auch einen Katalog mit Empfehlungen zum Krankentransport und zu Krankentransportflügen.

(5) Soweit das Bundesministerium für Gesundheit oder eine zuständige oberste Landesbehörde beantragt, dass über ein Thema beraten wird, hat der Qualitätsausschuss Notfallrettung hierüber zu beraten und zu beschließen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann Fristen für die Erstellung von Empfehlungen setzen. Kommen diese Empfehlungen innerhalb der Fristen nicht zustande, kann das Bundesministerium für Gesundheit die Empfehlungen selbst erstellen. Die Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses Notfallrettung veröffentlicht die Empfehlungen.

(6) Der Qualitätsausschuss Notfallrettung erstellt bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] Empfehlungen für die Übermittlung der Daten der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung nach § 133e. Das Bundesministerium für Gesundheit erlässt eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bezüglich der Übermittlung der für die Ermittlung der Leistungsqualität erforderlichen Daten der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung nach Satz 1.

(7) Der Qualitätsausschuss Notfallrettung erstellt Spezifikationen für eine strukturierte, einheitliche und digitale Dokumentation und Kommunikation nach § 133d auf Grundlage der Spezifikationen nach § 123a Absatz 2 Satz 10 und § 133a Absatz 2 Satz 8 im Einvernehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Bei der Erstellung der Spezifikation nach Satz 1 ist das Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen nach § 311 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 in Verbindung mit § 385 einzubeziehen. Die Spezifikation ist dem Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen nach § 385 bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des 24. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] vorzulegen. Über die verbindliche Festlegung der Spezifikation nach Satz 1 für nicht ausschließlich in die Zuständigkeit der Länder fallende informationstechnische Systeme, für einen Bereich des Gesundheitswesens oder das gesamte Gesundheitswesen entscheidet gemäß § 385 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen der Rechtsverordnung nach § 385 Absatz 1 Satz 1. Die Spezifikationen nach Satz 1 sind auf der Plattform nach § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 zu veröffentlichen.

§ 133d

Digitale Notfalldokumentation

Zur Versorgung von rettungsdienstlichen Notfällen und in der notdienstlichen Akutversorgung sind die

1. Leistungserbringer der medizinischen Notfallrettung,
2. an der stationären Notfallversorgung beteiligten zugelassenen Krankenhäuser,
3. die Akutleitstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen und
4. die Ärzte, die notdienstliche Akutversorgung gemäß § 75 Absatz 1b Satz 5 erbringen,

zur digitalen Erhebung und Speicherung der für die weitere medizinische Diagnostik und Versorgung erforderlichen personenbezogenen Daten und zu deren Übermittlung an die jeweils weiterversorgende Stelle und deren Empfang verpflichtet (digitale Notfalldokumentation). Hierfür sind bundeseinheitlich definierte, digitale Schnittstellen und Standards für die Datensätze einzurichten. Sobald die hierfür erforderlichen Komponenten und Dienste flächendeckend zur Verfügung stehen, sind für die digitale Notfalldokumentation nach Satz 1 Dienste der Telematikinfrastruktur nach § 311 zu nutzen. Zugriffsberechtigte Leistungserbringer und andere zugriffsberechtigte Personen nach § 352, die im Rahmen einer Tätigkeit nach Satz 1 in die Versorgung von rettungsdienstlichen Notfällen und Akutfällen eingebunden sind, haben, soweit die hierzu erforderlichen technischen Zugriffsvoraussetzungen vorliegen, die von ihnen im Rahmen der Notfall- und Akutversorgung erhobenen personenbezogenen Daten der digitalen Notfalldokumentation unmittelbar nach der erfolgten Versorgung als Ergebnis in die elektronische Patientenakte nach § 341 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d zu speichern.

§ 133e

Datenübermittlung zur Qualitätssicherung

(1) Die Leistungserbringer der medizinischen Notfallrettung übermitteln in elektronischer anonymisierter Form jeweils zum 31. März, erstmals zum 31. März, der auf den Erlass der Rechtsverordnung nach § 133c Absatz 6 Satz 2 folgt, für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr die für die Ermittlung der Leistungsqualität erforderlichen Daten gemäß der Rechtsverordnung nach § 133c Absatz 6 Satz 2 an eine vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen geführte Datenstelle auf Bundesebene. Das Nähere zur Übermittlung bestimmt der Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Zweck der Qualitätssicherung ist die Messung und Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Leistungen nach § 30.

(2) Die Datenstelle veröffentlicht die zusammengefassten Daten in anonymisierte Form und nach Abschluss der Möglichkeit von Rückschlüssen auf Leistungserbringer und einzelne Einsätze bis zum 1. Juli gegliedert nach bundes- und landesweiten Ergebnissen. Dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Qualitätsausschuss Notfallrettung, den für den Rettungsdienst zuständigen Landesbehörden sowie den Landesverbänden der Krankenkassen und Ersatzkassen sind auf Anforderung Auswertungen für ihre Belange zur Verfügung zu stellen.“

22. Nach § 136b Absatz 8 wird der folgende Absatz 9 eingefügt:

„(9) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] eine Richtlinie, die Vorgaben zur Einrichtung und Durchführung eines interdisziplinären Echtzeit-Nachweises der Behandlungs- und Versorgungskapazitäten (Verzeichnis) von Krankenhäusern sowie zur Pflege der entsprechenden Daten beinhaltet. Die nach § 136c Absatz 4 beschlossenen Festlegungen sind zu berücksichtigen. Im Rahmen der Richtlinie ist auch das Nähere vorzugeben

1. zur Stärkung von Patientensicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Notfallversorgung durch die bundesweite Verbesserung der überregionalen Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Ret-

- tungsdienst, um Zeitverzögerungen während der Behandlung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu minimieren,
2. zur Meldeverpflichtung von Krankenhäusern zu freien (betreibbaren) oder überlasteten bzw. belegten Versorgungskapazitäten aller Leistungsgruppen bzw. Fachabteilungen bis hin zu den kleinsten organisatorischen Einheiten,
 3. zur Meldeverpflichtung von Notdienstpraxen gemäß § 75 Absatz 1b Satz 3 zu freien oder überlasteten Versorgungskapazitäten bis hin zu den kleinsten organisatorischen Einheiten,
 4. zur Meldeverpflichtung von Rettungsleitstellen oder Rettungseinsatzmitteln mit der Benennung der Erkrankung oder Verletzung und weiterer notwendiger Daten der Notfallpatienten zur Zuweisung in ein Krankenhaus, um den Transport des jeweiligen Notfalles entsprechend dem Stand der Wissenschaft gezielt in das nächstgelegene, verfügbare und geeignete Krankenhaus zu steuern,
 5. zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Durchführung der Meldeverpflichtungen,
 6. zu Übergangsfristen für die Umsetzung der Richtlinie, soweit diese für eine rechtzeitige Integration der Richtlinie in die organisatorischen Abläufe der Krankenhäuser, Rettungsleitstellen und Rettungseinsatzmittel erforderlich sind,
 7. zur webbasierten Veröffentlichung strukturierter Daten zur transparenten, aktuellen Ausweisung regionaler und überregionaler Versorgungskapazitäten und der Entität und Häufigkeit von Verletzungen oder Erkrankungen zugewiesener Notfallpatienten,
 8. zur Regelung des Datenzugriffes auf die Versorgungskapazitäten bei Großschadenslagen, Krisen- und Katastrophenfällen für die für das Krisenmanagement verantwortlichen Behörden der Kommunen, Länder und des Bundes sowie des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.

Die zugelassenen Krankenhäuser sind verpflichtet, der das Verzeichnis führenden Stelle auf Anforderung die für den Aufbau und die Durchführung des Verzeichnisses erforderlichen Daten sowie Veränderungen dieser Daten auch ohne Anforderung zu übermitteln. Die Kosten zur Führung des Verzeichnisses tragen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft je zur Hälfte. Wird das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus mit der Führung des Verzeichnisses beauftragt, sind die notwendigen Aufwendungen des Instituts aus dem Zuschlag nach § 17b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu finanzieren. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Auswirkungen der Richtlinie nach Satz 1 hinsichtlich der Entwicklung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Notfallversorgung, der Auswirkungen auf die Patientenversorgung sowie die Erforderlichkeit einer Anpassung seiner Regelungen bis zum ... [einsetzen: Datum des letzten Tages des elften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu prüfen und hierüber dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum ... [einsetzen: Datum des letzten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] zu berichten.“

23. Nach § 136c Absatz 4 Satz 2 wird der folgende Satz eingefügt:

„Grundlage der Festlegungen sind die Empfehlungen zur Struktur und Ausstattung von Intensivstationen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und die Empfehlungen zur Struktur und Ausstattung der Notaufnahmen der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin; Abweichungen von den Empfehlungen hinsichtlich der Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten beziehungsweise Notfallpatienten sowie der Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals sind besonders zu begründen.“

24. In § 291b Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „nach § 75 Absatz 1b Satz 3“ durch die Angabe „nach § 75 Absatz 1b Satz 9“ ersetzt.
25. In § 377 Absatz 5 wird die Angabe „Notfallambulanzen“ durch die Angabe „Notaufnahmen“ ersetzt.

Artikel 2

Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 75 Absatz 1e wird durch den folgenden Absatz 1e ersetzt:

„(1e) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung evaluiert die Auswirkungen der Tätigkeit der Terminservicestellen und der Akutleitstellen insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der fristgemäßen Vermittlung von Arztterminen, auf die Weiterleitung in offene Sprechstunden, auf die Vermittlungsquote von telefonischen oder videounterstützten ärztlichen Beratungen oder von Leistungen des aufsuchenden Dienstes, auf die Häufigkeit der Inanspruchnahme, insbesondere die Gesamtanzahl der Anrufe, die Anzahl der angenommenen Anrufe, die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme des Anrufes und die Anzahl der abgebrochenen Anrufe und auf die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] über die Ergebnisse. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] ein Evaluationskonzept vorzulegen.“

Artikel 3

Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes

Das Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 12a Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 wird die Angabe „integrierter Notfallstrukturen“ durch die Angabe „Integrierter Notfallzentren nach § 123 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und Integrierter Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.
2. § 17b Absatz 1a Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:
 - „1. die Vorhaltefinanzierung der Personalkosten des ärztlichen Personals in der Notfallversorgung nach den Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,“.

Artikel 4

Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes

Das Krankenhausentgeltgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 9 Absatz 1a in Nummer 5 wird nach der Angabe „zu entwickeln ist“ die Angabe „und sind an die Weiterentwicklung der Anforderungen anzupassen“ eingefügt.

Artikel 5

Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung

Die Krankenhausstrukturfonds-Verordnung vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), die durch Artikel 4a des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

In § 11 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „integrierter Notfallstrukturen“ durch die Angabe „Integrierter Notfallzentren nach § 123 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und Integrierter Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte

Die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 8230-25, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 40) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 19a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1. Nach Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:

„Bei der Festsetzung der offenen Sprechstunden ist das Bedürfnis einer ausreichenden vertragsärztlichen Versorgung in Akutfällen innerhalb ihrer Arztgruppe im jeweiligen Planungsbereich zu berücksichtigen.“

2. In dem neuen Satz 7 wird die Angabe „Satz 5“ durch die Angabe „Satz 6“ ersetzt.

3. Nach Satz 7 wird der folgende Satz eingefügt:

„Im Bundesmantelvertrag nach § 82 Absatz 1 werden bundeseinheitliche Regelungen zur Umsetzung einer möglichst gleichmäßigen zeitlichen Verteilung der Sprechstunden nach Satz 3 innerhalb der verpflichteten Arztgruppen im jeweiligen Planungsbereich getroffen.“

Artikel 7

Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter

Das Bundesministerium für Gesundheit wird verpflichtet, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend die gemäß § 14 des Notfallsanitätergesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 7c des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, erlassene Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter vom 16. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4280), die zuletzt durch Artikel 12 der Verordnung vom 7. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 148) geändert worden ist, bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] an die Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen.

Artikel 8**Evaluierung**

Die Auswirkungen der §§ 30, 60 sowie 133 bis 133e werden spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch das Bundesministerium für Gesundheit evaluiert; der Bericht ist dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zuzuleiten.

Artikel 9**Inkrafttreten**

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
- (2) Artikel 2 tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

Berlin, den 14. Oktober 2025

Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Fraktion

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Eine gut funktionierende und wirtschaftliche Notfall-, Akut- und rettungsdienstliche Versorgung ist essenzieller Bestandteil einer leistungsfähigen Gesundheitsversorgung. Für Menschen in einer akuten medizinischen Notlage ist es entscheidend, jederzeit unmittelbar bedarfsgerechte Hilfe zu erhalten und hierbei auf eine qualitativ hochwertige Versorgung vertrauen zu können. Eine leistungsfähige Notfallversorgung setzt eine enge Verzahnung von vertragsärztlichem Notdienst, Notaufnahmen und Rettungsdiensten voraus. Derzeit fehlt jedoch eine verlässliche Steuerung, was zu Fehlanreizen und Überlastungen insbesondere der Notaufnahmen und des Rettungsdienstes führt. Rettungsmittel und Fachpersonal werden häufig in medizinisch nicht erforderlichen Fällen gebunden, während Patientinnen und Patienten keine Klarheit über ihren Anspruch auf umfassende Notfallversorgung haben. Trotz des gut ausgebauten Systems in Deutschland verhindert der auf Fahrkosten reduzierte Finanzierungsrahmen sowie die mangelnde Vernetzung der Strukturen eine bedarfsgerechte und ressourcenschonende Versorgung. Reformempfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege und anderen Expertengremien sowie Anträge zu Reformbedarfen aus den Ländern verdeutlichen die Notwendigkeit, den sozialversicherungsrechtlichen Rahmen zu modernisieren, um Transparenz, Wirtschaftlichkeit und eine qualitativ hochwertige Notfallversorgung sicherzustellen.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Es werden gesetzliche Maßnahmen ergriffen, um die Steuerung der Hilfesuchenden zu verbessern. Ziel ist es, durch eine Vernetzung die Notaufnahmen und den Rettungsdienst zu entlasten und Patientinnen und Patienten, die ambulant behandelt werden können, jederzeit in eine geeignete Versorgungsstruktur zu steuern.

Verbesserung der Steuerung durch Vernetzung der Leitstellen

Zur besseren Steuerung von Hilfesuchenden werden die Notrufnummer 112 und die bundesweite Rufnummer 116117 digital und organisatorisch vernetzt. Akutleitstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen und Rettungsleitstellen kooperieren künftig flächendeckend und nutzen hierfür die Telematikinfrastruktur. Die bereits erhobenen personenbezogenen Daten können so wechselseitig übermittelt werden.

Durch die Abstimmung standardisierter Abfragesysteme wird eine klare und rechtssichere Überleitung von Patientinnen und Patienten ermöglicht. Die Rufnummer 116117 wird organisatorisch in Terminservicestellen und Akutleitstellen aufgeteilt, um dem wachsenden Gesprächsaufkommen gerecht zu werden. Für Akutleitstellen gelten verbindliche Vorgaben zur Erreichbarkeit, das telemedizinische Angebot wird verpflichtend ausgebaut. Die Finanzierung erfolgt über eine paritätische Vorhaltepauschale von gesetzlicher Krankenversicherung und Kassenärztlichen Vereinigungen, wobei auch private Krankenversicherungen entsprechend ihrer Marktstellung beteiligt werden.

Konkretisierung des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen

Der Begriff der notdienstlichen Akutversorgung wird neu gefasst und umfasst künftig die rund um die Uhr verfügbare unverzüglich Behandlung von Patientinnen und Patienten. Diese ist sowohl telemedizinisch als auch durch aufsuchende Dienste sicherzustellen. Damit wird eine bundesweit einheitliche Qualität gewährleistet und zugleich eine Entlastung anderer Notfallstrukturen erreicht.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden verpflichtet, durchgängig eine telemedizinische Versorgung vorzuhalten, auch in kinder- und jugendmedizinischen Fachgebieten. Ergänzend können qualifiziertes nichtärztliches Personal eingebunden oder Kooperationen mit dem Rettungsdienst genutzt werden. Zudem sind Kooperationen

zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen untereinander sowie mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ausdrücklich vorgesehen.

Einrichtung von Integrierten Notfallzentren (INZ)

Flächendeckend werden Integrierte Notfallzentren etabliert, die aus drei Säulen bestehen: der Notaufnahme eines zugelassenen Krankenhauses, einer Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung und einer zentralen Ersteinschätzungsstelle. Diese Zentren stellen rund um die Uhr eine bedarfsgerechte Erstversorgung sicher.

Die digitale Vernetzung der beteiligten Einrichtungen gewährleistet eine medienbruchfreie Weitergabe der Patientendaten. Zentrale Rolle spielt die Ersteinschätzungsstelle, die Hilfesuchende in die geeignete Struktur leitet. Perspektivisch wird hierfür ein standardisiertes, validiertes digitales Ersteinschätzungsinstrument entwickelt, das Behandlungsdringlichkeit und Versorgungsebene festlegt. Für den Betrieb dieser Stelle ist eine gesonderte fallbezogene Vergütung vorgesehen.

Die Standorte der INZ werden von den Selbstverwaltungspartnern nach bundesweit einheitlichen Rahmenvorgaben festgelegt. Kommt innerhalb von sechs Monaten keine Einigung zustande, entscheidet das jeweilige Land. Spezielle INZ für Kinder und Jugendliche können an geeigneten Standorten eingerichtet werden; andernorts wird eine telemedizinische Anbindung an pädiatrische Fachärzte gewährleistet.

Mindestöffnungszeiten und Kooperationsmodelle

Für Notdienstpraxen gelten bundeseinheitliche Mindestöffnungszeiten täglich von 10 bis 22 Uhr. Abweichungen sind nur möglich, wenn empirisch nachgewiesen wird, dass eine Öffnung aufgrund geringer Inanspruchnahme nicht bedarfsnotwendig ist. Die Kooperationsvereinbarungen zwischen Krankenhäusern und Kassenärztlichen Vereinigungen enthalten zudem Regelungen für den Fall, dass diese Öffnungszeiten nicht eingehalten werden.

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten übernimmt die Notaufnahmen die gesamte ambulante Notdienstversorgung im Integrierten Notfallzentrum neben den 24/7 verfügbaren telemedizinischen und aufsuchenden Diensten der Kassenärztlichen Vereinigungen.

Neugestaltung des Finanzierungsrahmens für den Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wird künftig als eigenständiger Leistungsbereich der gesetzlichen Krankenversicherung verankert. Damit erhalten Patientinnen und Patienten im Rahmen einer Notfallbehandlung einen Anspruch auf ein umfassendes Leistungsbündel: strukturiertes Notfallmanagement durch die Leitstellen, qualifizierte notfallmedizinische Versorgung am Einsatzort, Transporte in geeigneten Rettungsmitteln sowie spezielle ambulante Notfallversorgung (SANV) wie notfallpflegerische Angebote, psychische Notfallhilfen, oder vorbeugender Rettungsdienst.

Die tatsächlich erbrachten Leistungen – von der Disposition über die Versorgung vor Ort bis hin zum Transport – werden gesetzlich festgeschrieben und an Qualitätsparametern ausgerichtet. So entsteht ein transparenter Finanzierungsrahmen, der den realen Einsatzbedingungen entspricht und den Kostenträgern wie Leistungserbringern auf Landes- und kommunaler Ebene Planungssicherheit gibt. Durch die von anderen Leistungsansprüchen unabhängige Finanzierung wird ein System geschaffen, das Ressourcen effizient nutzt, Überlastungen vermeidet und die Versorgungsqualität für Patientinnen und Patienten steigert.

Gesamtwirkung der Reform

Mit der Neugestaltung des Finanzierungsrahmens für den Rettungsdienst, der Vernetzung der Leitstellen, der Konkretisierung des Sicherstellungsauftrags sowie der Einrichtung Integrierter Notfallzentren entsteht ein eng verzahntes, digital gestütztes und qualitätsgesichertes System der Notfallversorgung. Die Überlastung von Rettungsdienst und Notaufnahmen wird reduziert, die Steuerung der Patientinnen und Patienten verbessert und die Versorgungssicherheit nachhaltig gestärkt.

III. Alternativen

Keine. Die Ziele können nur durch eine Gesetzesänderung erreicht werden. Andere Alternativen sind weder zielführend noch effektiv. Die Reform ist mit Blick auf die Überlastung von Notaufnahmen und Rettungsdiensten mit steigenden Fallzahlen, die mangelnde Vernetzung der Sektoren im Bereich der Notfallversorgung und ange-

sichts des zunehmenden Mangels an Fachkräften dringend notwendig. Alternative Regelungen, wie etwa die Schaffung eines eigenen Notfallversorgungssektors, sind nicht in gleichem Maße geeignet. Hiermit würden zusätzliche Barrieren zwischen den Sektoren aufgebaut und eine effiziente Fallbearbeitung weiter erschwert. Es besteht daher keine Alternative zu den vorgesehenen Regelungen, welche die Ziele des Gesetzes in gleichem Maße erreichen würden.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes. Danach hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die Sozialversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung trägt in erheblichem Umfang die Kosten der rettungsdienstlichen Notfallversorgung und ist damit nicht nur Finanzier, sondern auch Garant einer flächendeckend gleichwertigen Notfallversorgung. Die Regelungskompetenz des Bundes umfasst daher nicht nur die Bestimmung von Leistungsansprüchen, sondern auch die Ausgestaltung der Art und Weise ihrer Erbringung sowie die Qualitätssicherung.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Beteiligung der privaten Krankenversicherung an der Förderung der Strukturen des Notdienstes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Sie ist erforderlich, weil medizinische Notfälle unabhängig vom Versichertenstatus eintreten und deshalb sektoren- und versicherungsübergreifende Strukturen zur Versorgung aller Versicherten geschaffen werden müssen. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die besondere Berücksichtigung der Bundeswehrkrankenhäuser folgt aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 GG und der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung für eine wirkungsvolle militärische Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und damit für die Sicherung der staatlichen Existenz durch Streitkräfte.

Im Bereich der Leistungen des Rettungsdienstes normiert das Gesetz zum einen bisher in der Rechtsprechung anerkannte, im Gesetz indes nur rudimentär geregelte Leistungsansprüche der Versicherten. Die Normierung von Leistungsansprüchen zählt zum Kernbereich, der von der Kompetenznorm des Art. 74 Absatz 1 Nummer 12 GG erfasst wird. Ebenso gehören dazu die Regelungen zur Leistungserbringung und insbesondere der Finanzierung. Die bisherige Festbetragsregelung des § 133 Absatz 2 SGB V wird mit diesem Gesetz differenziert weiterentwickelt. Dabei wird klargestellt, dass die Notfallrettung funktional nicht als bloßer Transportdienst, sondern als erste Stufe der medizinischen Versorgung der Versicherten anzusehen ist. Sie bildet die Schnittstelle zwischen vorstationärer Notfallversorgung und der nachfolgenden ambulanten oder stationären Behandlung und entspricht damit in ihrer Bedeutung der vertragsärztlichen Versorgung, für die die Gesetzgebungskompetenz des Bundes unstreitig anerkannt ist.

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Bundes, bundeseinheitliche Mindeststandards für die Qualität und Struktur der rettungsdienstlichen Versorgung zu schaffen, um die Wirksamkeit und Gleichwertigkeit der durch die Sozialversicherung finanzierten Leistungen zu gewährleisten. Die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder aus Artikel 30 und 70 GG bleibt unberührt: Organisation, Disposition und Durchführung der rettungsdienstlichen Aufgaben obliegen weiterhin den Ländern und Kommunen. Die Regelungen des Bundes beschränken sich auf die Schaffung eines Rahmens, der den Schutzauftrag aus Artikel 2 Absatz 2 GG (Leben und Gesundheit) und das Gebot gleichwertiger Lebensverhältnisse nach Artikel 72 Absatz 2 GG umsetzt.

Mit dem vorliegenden Gesetz wird die bestehende bundesgesetzliche Kompetenz im Bereich der Sozialversicherung inhaltlich klarer ausgefüllt und anhand konkreter Struktur- und Qualitätsparameter weiterentwickelt. Auf diese Weise wird eine qualitativ hochwertige und für alle Versicherten gleichwertige Notfallversorgung gesichert, ohne die Organisationshoheit der Länder zu verdrängen. Der Zustimmungspflicht der Bundesländer unterliegt diese ausschließlich das SGB V betreffende gesetzliche Regelung nicht.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union und den völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VI. Gesetzesfolgen

Die Notfallversorgung wird durch den Ausbau und die Stärkung ambulanter Notdienststrukturen, die verbindliche Vernetzung der Notrufnummer 112 und der Rufnummer 116117 sowie den flächendeckenden Aufbau von Integrierten Notfallzentren stabiler aufgestellt und insbesondere die Notaufnahmen der Krankenhäuser und der Rettungsdienst werden durch eine effizientere und bedarfsgerechte Patientensteuerung entlastet.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Prozesse der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit in der Notfallversorgung sollen bundesweit einheitlich geregelt und vereinfacht werden. Dies wird über die Vernetzung der Akutleitstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Rettungsleitstellen mit verlässlichen Überleitungsmöglichkeiten für Hilfesuchende sowie durch die Einrichtung Integrierter Notfallzentren umgesetzt, die eine verbindliche Zusammenarbeit von Notaufnahmen der Krankenhäuser und Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigungen sicherstellen. Ergänzend trägt das Gesetz durch die Schaffung finanzieller Anreize zur Standardisierung und Vereinheitlichung der bislang heterogenen Rettungsdienststrukturen bei und leistet damit einen Beitrag zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung in den Aufsichtsbehörden sowie zur verbesserten Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung hinsichtlich Gesundheit, Lebensqualität, sozialem Zusammenhalt und sozialer Verantwortung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.

Mit den Regelungen des Gesetzentwurfes werden die Strukturen der Notfallversorgung weiterentwickelt und mit Unterstützung digitaler Instrumente zweckmäßig gestaltet. Dadurch ergeben sich Entlastungen der bisher bestehenden Strukturen, beziehungsweise werden die vorhandenen Ressourcen effektiver genutzt. Damit wird mit den Neuregelungen dieses Gesetzentwurfes vor allem das Nachhaltigkeitsziel Nummer 3 der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie („Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern“) wirksam unterstützt. Der effektivere Einsatz vorhandener Finanzmittel stärkt das Gesundheitssystem. Durch eine gezieltere Nutzung der Notfalleinrichtungen wird deren Verfügbarkeit für die Patientinnen und Patienten verbessert und die Belastung des Personals reduziert. Vor diesem Hintergrund werden durch den Gesetzentwurf auch die Nachhaltigkeitsziele Nummer 9 („Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“) und Nummer 5 („Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“) der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie maßgeblich unterstützt.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Mit den Neuregelungen der Notfallreform wird eine verbesserte Kooperation der drei Leistungsbereiche des Notdienstes der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Notaufnahmen der Krankenhäuser und des Rettungsdienstes erreicht.

Bund, Länder und Kommunen

Dem Bund entstehen durch die Reform keine Mehrausgaben. Die Haushalte der Länder und Kommunen werden durch die Kooperationsvereinbarungen zu den Gesundheitsleitsystemen, die durch eine Vernetzung der Akutleitstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Rettungsleitstellen der Länder und Kommunen gebildet werden, allenfalls geringfügig belastet. Investitionskosten für die Einrichtung von Integrierten Notfallzentren entstehen den Ländern höchstens in geringfügigem Umfang, da in der Regel auf bereits vorhandene Strukturen in den Krankenhäusern aufgesetzt werden kann. Darüber hinaus stehen Mittel des Krankenhausstrukturfonds zur Verfügung, wodurch der Anteil des vom Land zu tragenden Betrages zusätzlich um die Hälfte reduziert würde. Für die Länder und Kommunen, die bereits jetzt umfassende Rettungsdienstleistungen anbieten, ist durch den erweiterten Finanzierungsrahmen der gesetzlichen Krankenversicherung mit nicht bezifferbaren Minderausgaben zu rechnen.

Gesetzliche Krankenversicherung

Mehrausgaben Ausbau des aufsuchenden Dienstes

Der verpflichtende Ausbau des aufsuchenden Dienstes nach § 75 Absatz 1b Satz 5 Nummer 3 SGB V auf einen 24-Stunden-Betrieb führt zu geschätzten Mehrausgaben der gesetzlichen Krankenkassen von rund 98 Millionen Euro. Schon heute entstehen den Kassenärztlichen Vereinigungen durch Finanzierung und Organisation des fahrenden Bereitschaftsdienstes Kosten von etwa 70 Millionen Euro jährlich. Bei einer Ausweitung auf einen 24-Stunden-Betrieb könnten sich diese Kosten auf rund 210 Millionen Euro verdreifachen. Die gesetzliche und die private Krankenversicherung übernehmen dabei zusammen höchstens die Hälfte der Kosten, das entspricht 105 Millionen Euro. Nach Abzug des Anteils der privaten Krankenversicherung entfällt auf die gesetzliche Krankenversicherung ein Betrag von etwa 98 Millionen Euro.

Mehrbedarf Akutleitstelle

Für die Erweiterung der Aufgaben der Akutleitstellen werden Mehrausgaben in Höhe von etwa 90 Millionen Euro prognostiziert. Davon entfallen auf den Personalbedarf rund 71,5 Millionen Euro. In dieser Summe enthalten sind der Einsatz von Beratungsärzten rund um die Uhr, eine zusätzliche Führungskraft sowie eine Aufstockung des Personals an der Rufnummer 116117 um etwa 30 Prozent. Geht man von einem Anteil der Personalkosten von 80 Prozent an den Gesamtkosten aus, ergibt sich der Gesamtbedarf von rund 90 Millionen Euro.

Die Finanzierung der Akutleitstellen sowie der Vorhaltekosten des Fahrdienstes erfolgt nach § 105 Absatz 1b SGB V durch Fördervereinbarungen. Diese decken Investitionen und laufende Kosten ab und werden zu höchstens 50 Prozent von der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung gemeinsam getragen. Durch die Beteiligung der privaten Krankenversicherung reduziert sich der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung um 7 Prozent. Mindernd wirken außerdem bestehende Finanzierungsmodelle der Kassenärztlichen Vereinigungen, die jedoch regional unterschiedlich ausgestaltet sind und deshalb nicht bundesweit beziffert werden können.

Mehrausgaben Rettungsdienst

Zusätzlich entstehen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht bezifferbare Mehrkosten. Diese resultieren aus höher vergüteten rettungsdienstlichen Leistungen nach Qualitätskriterien des Gesetzes, aus der Anpassung der Notfallversorgung mit speziellen ambulanten Einsatzmitteln, aus der Digitalisierung von Leitstellen- und Rettungsdienstsystemen sowie aus neuen Qualitätsvorgaben für Ausstattung und Qualifikation.

Entlastungen

Den zusätzlichen Ausgaben stehen erhebliche Entlastungen gegenüber. Durch die Vernetzung von Akut- und Rettungsleitstellen können Versicherte gezielter gesteuert und Notfalleinrichtungen besser ausgelastet werden. Gegenwärtig werden nur sehr wenige Anrufe von Rettungsleitstellen an die Akutleitstellen der Kassenärztlichen Vereinigungen weitergeleitet. Prognosen gehen jedoch davon aus, dass künftig bis zu 14,5 Prozent der Fälle, das heißt etwa 1,2 Millionen Fälle pro Jahr, übertragen werden können. Allein durch die Verringerung der Rettungseinsätze entstehen Minderausgaben bei den Fahrkosten von rund 843 Millionen Euro jährlich.

Hinzu kommen bis zu vier Milliarden Euro Einsparungen durch vermiedene (kurzzeit-)stationäre Behandlungen im Krankenhaus. Der Sachverständigenrats für das Gesundheitswesen geht von einem Einsparpotenzial von bis zu 30 Millionen Krankenhaus-Belegungstagen bei einer Senkung der Aufnahmequote um bis zu 15 Prozent aus, bei durchschnittlichen Kosten von 3600 Euro pro Krankenhausaufenthalt.

Es ist davon auszugehen, dass zunächst etwa 30 Prozent der Rettungsleitstellen kooperieren, sodass sich das volle Einsparpotenzial erst ab dem vierten Jahr entfalten wird. Darüber hinaus können telemedizinische Beratungen in den Akutleitstellen bis zu 70 Prozent der Hilfeersuchen abschließend klären. Dadurch sinkt die Zahl der Hausbesuche sowie der Selbstvorstellungen in den Notaufnahmen erheblich.

Langfristig ist daher mit jährlichen Entlastungen der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von bis zu 5 Milliarden Euro zu rechnen.

Private Krankenversicherungen

Auch die privaten Krankenversicherungsunternehmen beteiligen sich an der Finanzierung der Notfallstrukturen. Für sie ergibt sich ein jährlicher Mehraufwand von rund 10 Millionen Euro. Gleichzeitig profitieren sie jedoch

von denselben Entlastungseffekten wie die gesetzliche Krankenversicherung. Das Einsparpotenzial liegt bei etwa 80 Millionen Euro durch die Weiterleitung von Fällen an die Akutleitstellen und weiteren 20 Millionen Euro durch vermiedene Krankenhausaufenthalte. Insgesamt können die privaten Krankenversicherungen daher langfristig mit jährlichen Einsparungen von rund 100 Millionen Euro rechnen.

4. Erfüllungsaufwand

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Durch die Neuregelungen entsteht kein neuer Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. Bürgerinnen und Bürgern werden vielmehr durch die Neustrukturierung der medizinischen Notfallversorgung bei der Suche nach Hilfe in medizinischen Akut- und Notfällen entlastet.

4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft

4.2.1 Erfüllungsaufwand für Krankenhäuser

Für die Krankenhäuser entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 0,5 Millionen Euro durch den Abschluss von rund 700 Kooperations- und Versorgungsverträgen, bei erwartbar hohen Synergieeffekten zwischen den Kooperationspartnern. Zusätzlich fällt jährlich etwa 1 Million Euro laufender Aufwand für die Arbeit in den Organisationsgremien der Integrierten Notfallzentren an.

4.2.2 Erfüllungsaufwand für die Landeskrankenhausesellschaften

Bei den Landeskrankenhausesellschaften entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von etwa 205.000 Euro aufgrund der erweiterten Aufgaben der Landesausschüsse.

4.2.3 Erfüllungsaufwand für die privaten Krankenversicherungsunternehmen

Die privaten Krankenversicherungsunternehmen tragen einen einmaligen Erfüllungsaufwand von rund 10.000 Euro für die Vereinbarung zur finanziellen Beteiligung am Notdienst.

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

4.3.1 Erfüllungsaufwand für Länder und Kommunen

Für Länder und Kommunen entsteht ein einmaliger Aufwand von rund 210.000 Euro durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen der Gesundheitsleitsysteme. Hinzu kommt ein jährlicher Aufwand von etwa 334.000 Euro für die zusätzliche Arbeit der Rettungsdienst-Vertretungen in den erweiterten Landesausschüssen. Zusätzlich entsteht ein nicht bezifferbarer Erfüllungsaufwand für die Arbeit im Qualitätsausschuss Notfallrettung.

4.3.2 Erfüllungsaufwand der Kassenärztlichen Vereinigungen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben einen einmaligen Aufwand von rund 635.000 Euro für die Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern sowie einen laufenden Aufwand von etwa 1,27 Millionen Euro für den Betrieb der Organisationsgremien. Hinzu kommen weitere einmalige Aufwände von etwa 218.000 Euro für Vereinbarungen zu den Gesundheitsleitsystemen und rund 229.000 Euro für die Arbeit der erweiterten Landesausschüsse. Für die Vorlage von Mittelverwendungs-Kalkulationen entsteht ein jährlicher Aufwand von rund 71.000 Euro. Größere zusätzliche Kosten für die Errichtung der Integrierten Notfallzentren werden nicht erwartet, da überwiegend bestehende Strukturen genutzt werden. Zusätzlich entsteht ein nicht bezifferbarer Erfüllungsaufwand für die Arbeit im Qualitätsausschuss Notfallrettung.

4.3.3 Erfüllungsaufwand der Landesverbände der gesetzlichen Krankenversicherung

Den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenversicherung entsteht ein einmaliger Aufwand von rund 230.000 Euro durch die erweiterte Arbeit in den Landesausschüssen.

4.3.4 Erfüllungsaufwand für den Bewertungsausschuss

Dem ergänzten Bewertungsausschuss entstehen mehrere einmalige Aufwände: rund 13.500 Euro für die Beschlussfassung zur Vergütung der Ersteinschätzung, etwa 17.000 Euro für die Evaluation der Auswirkungen die-

ses Beschlusses sowie rund 7.500 Euro und 10.000 Euro für weitere Beratungen und Beschlüsse zu Kennzeichnungen von Notaufnahmen und Notdienststrukturen.

5. Weitere Kosten

Keine.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Nachteilige Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher oder nachteilige gleichstellungspolitische oder demografische Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Gleichwertige Lebensverhältnisse werden durch die Konkretisierung des Sicherstellungsauftrages der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie eine flächendeckende Einführung von Gesundheitsleitsystemen und Integrierten Notfallzentren gefördert.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung erfolgt nicht. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung evaluiert die Tätigkeit der Akutleitstellen nach § 75c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit über die Anzahl und den Stand der Kooperationsvereinbarungen der eingerichteten Gesundheitsleitsysteme. Die Kassenärztlichen Vereinigungen evaluieren die Versorgung in den Integrierten Notfallzentren. Die Ergebnisse werden über die Kassenärztliche Bundesvereinigung dem Bundesministerium für Gesundheit berichtet.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 27)

Die medizinische Notfallrettung wird als eigenständige Leistung im Fünften Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Anspruch der Versicherten auf medizinische Notfallrettung. Sie wird zur Klarstellung in den Katalog der Krankenbehandlung nach § 27 aufgenommen. Mit den Neuregelungen des Leistungsrahmens in § 30 werden die Kosten für die medizinische Notfallrettung (Notfallmanagement, notfallmedizinische Versorgung, Notfalltransport in eine geeignete Einrichtung, spezielle ambulante Notfallversorgung) im Rahmen des Rettungsdienstes nicht mehr im Sinne von Fahrkosten von der Durchführung eines Transportes abhängig gemacht und sind damit nicht mehr als akzessorische Nebenleistung zu anderen Leistungen der Krankenkassen, sondern als eigener Leistungsbereich anzusehen.

Zu Nummer 2 (§ 30)

§ 30 regelt den Anspruch der Versicherten auf Leistungen der medizinischen Notfallrettung.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird festgelegt, dass Versicherte bei Vorliegen eines rettungsdienstlichen Notfalles Anspruch auf Leistungen der medizinischen Notfallrettung haben. Bisher wurde der Rettungsdienst im Fünften Buch Sozialgesetzbuch ausschließlich als Transportleistung mit dazugehörigen Nebenleistungen behandelt und die Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen davon abhängig gemacht, ob ein Transport durchgeführt wurde. Diese Herangehensweise ist mit Blick auf die tatsächliche Leistung des Rettungsdienstes und die Einsatzpraxis sowie angesichts der wachsenden Bedeutung des Rettungsdienstes für die präklinische Versorgung nicht mehr zeitgemäß. Sie führt dazu, dass Ressourcen aufgrund längerer Beanspruchung über das erforderliche Maß hinaus gebunden, Notaufnahmen der Krankenhäuser belastet und die Potenziale der rettungsdienstlichen Versorgung nicht genutzt werden.

Ein rettungsdienstlicher Notfall liegt vor, wenn sich der Versicherte aus Ex-ante-Sicht in unmittelbarer Lebensgefahr befindet, sein Gesundheitszustand eine lebensbedrohende Verschlechterung erwarten lässt oder schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, sofern nicht eine sofortige medizinische Versorgung erfolgt. Dies gilt auch, wenn die Notwendigkeit einer präklinischen Notfallversorgung medizinisch nicht ausgeschlossen werden kann. Im Sinne der Beurteilung in der Ex-ante Sicht gilt der Anspruch auf Leistungen des Notfallmanagements.

ments nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 auch, wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Versicherter einen Bedarf an Leistungen der notfallmedizinischen Versorgung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder an Leistungen der notdienstlichen Akutversorgung nach § 75 Absatz 1b SGB V hat.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt den Inhalt der medizinischen Notfallrettung auf welchen die Versicherten in rettungsdienstlichen Notfällen Anspruch haben. Die medizinische Notfallrettung umfasst das Notfallmanagement, die notfallmedizinische Versorgung vor Ort, den Notfalltransport in eine geeignete Einrichtung sowie die spezielle ambulante Notfallversorgung.

Soweit ein Gesundheitsleitsystem nach § 133a die notfallmedizinische Versorgung vor Ort veranlasst hat, gilt dies als Nachweis des Vorliegens eines rettungsdienstlichen Notfalls und eine etwaig untergesetzlich vorgesehene Verordnung ist nicht erforderlich. Die Gleichsetzung mit einer vertragsärztlichen Verordnung ist durch das standardisierte Abfragesystem gerechtfertigt, auf deren Grundlage das Gesundheitsleitsystem seine Dispositionsentscheidungen trifft. Übergangsweise gilt für Leistungen der speziellen ambulanten Notfallversorgung als Nachweis die auf Grundlage einer protokollgestützten, standardisierten, softwaregestützten und qualitätsgesicherten Notrufabfrage getroffene Entscheidung.

Zu Absatz 3

Absatz 3 definiert den Anspruch auf Notfallmanagement, der durch Rettungsleitstellen erbracht wird. Dies ist unabhängig davon, ob sie Teil eines Gesundheitsleitsystems sind oder nicht. Rettungsleitstellen sind solche der europaeinheitlichen Notfallnummer nach § 164 Absatz 1 Telekommunikationsgesetz und der Richtlinie 2022/22/EG (112). Das Notfallmanagement umfasst die Entgegennahme des Hilfersuchens, die Vermittlung der erforderlichen Hilfe sowie bei Bedarf eine telefonische oder telemedizinische Notfallberatung und standardisierte und qualitätsgesicherte Erste-Hilfe-Anweisungen. Hierzu gehört auch die auf smartphonebasierte Ersthelferalarmierung bei besonders lebensbedrohlichen Notfällen (Ersthelfer-App). Ab einer Frist von elf Monaten gilt ist die Vermittlung verpflichtet auf Grundlage einer protokollgestützten, standardisierten, qualitätsgesicherten und softwaregestützten Notrufabfrage durchzuführen. Zusätzlich wird klargestellt, dass das Notfallmanagement auch die digitale Fallübergabe zwischen den im Rettungsdienst tätigen Leistungserbringern, den am Notdienst beteiligten Akteuren der Kassenärztlichen Vereinigungen sowie den Integrierten Notfallzentren umfasst. Damit wird eine medienbruchfreie Weitergabe der für die Versorgung relevanten medizinischen Informationen sichergestellt. Die digitale Fallübergabe ermöglicht, dass Patientinnen und Patienten ohne Verzögerung und Informationsverluste in die jeweils erforderliche weitere Versorgung übergeleitet werden können. Sie trägt dazu bei, Doppeluntersuchungen und Fehlsteuerungen zu vermeiden, verbessert die Versorgungsqualität und erhöht die Patientensicherheit. Zugleich unterstützt sie die sektorenübergreifende Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in der Notfallversorgung und schafft die Grundlage für eine bundesweit einheitliche und interoperable Dokumentation.

Zu Absatz 4

Absatz 4 definiert den Umfang der notfallmedizinischen Versorgung von Versicherten am Notfallort. Die Versicherten haben Anspruch auf eine notfallmedizinische Versorgung nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft, die je nach medizinischem Bedarf eine notärztliche Versorgung, die Versorgung durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sowie die telefonische und telemedizinische Notfallversorgung umfasst.

Zu Absatz 5

Falls medizinisch erforderlich, haben Versicherte Anspruch auf einen Transport in eine geeignete Einrichtung sowie eine notfallmedizinische Versorgung während des Transports. Geeignete Einrichtungen sind regelmäßig Krankenhäuser können im Einzelfall jedoch auch ambulante Versorger sein. Für die notfallmedizinische Versorgung während des Transports gelten die Regelungen in Absatz 4. Der Transport kann bei medizinischer Erforderlichkeit mit luftgebundenen Rettungsmitteln erfolgen. Zu den Leistungen des Notfalltransportes zählen auch Notverlegungen, also medizinisch keinen Aufschub duldende Beförderungen von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten aus einer Gesundheitseinrichtung in eine andere Gesundheitseinrichtung, die über die Möglichkeit einer besseren medizinischen Versorgung verfügt, wenn die Beförderungen zur Abwehr einer Lebensgefahr oder zur Abwendung von schweren unmittelbar drohenden gesundheitlichen Schäden unter fachgerechter ärztlicher Betreuung einschließlich der Erhaltung und Überwachung der lebenswichtigen Körperfunktionen erfolgen. Hierzu zählen im Sinne dieses Gesetzes auch dringliche und planbare Intensivtransporte, wenn hierfür Einsatzmittel der

medizinischen Notfallrettung wie Rettungswagen, Notarztfahrzeuge und Rettungshubschrauber oder Spezialrettungsmittel, wie zum Beispiel Intensivtransportwagen und -hubschrauber, erforderlich sind. Zielsetzung ist eine möglichst effiziente Auslastung dieser Einsatzmittel. Die hier gesetzlich vorgesehene Verlegung im rettungsdienstlichen Notfall setzt das Erfordernis des Transports durch ein qualifiziertes Rettungsmittel voraus. Der Anspruch umfasst nicht einen Rücktransport aus dem Ausland in das Inland.

Zu Absatz 6

Neben der notfallmedizinischen Versorgung kann je nach medizinischem Bedarf die Versorgung auch durch eine spezialisierte ambulante Versorgungsangebote erfolgen. Dies können etwa Angebote der notfallpflegerischen oder notfallpalliativen Versorgung, der psychischen Notfallhilfe, des vorbeugenden Rettungsdienstes, der notfallmäßigen außerklinischen geburtshilflichen Versorgung oder Gemeindenotfallsanitäter sein. Spezialisierte ambulante Versorgungsangebote erlauben eine zielgerichtete Reaktion auf die speziellen Bedürfnisse der Hilfesuchenden und können mit spezialisierter Erfahrung und gegebenenfalls größerer zeitlicher Freiheit eine angemessene Versorgung der Patientinnen und Patienten bieten. Der Rettungsdienst wird hierdurch entlastet und unnötige Krankenhauseinweisungen verhindert. Die Leistungserbringer der Leistungen des Notfallmanagements müssen die Vermittlung dieser Leistungen für den Bedarfsfall in geeigneter Weise sicherstellen.

Zu Absatz 7

Absatz 6 regelt Zuzahlungen in Höhe von 10 Euro, die Versicherte für die Leistung des Notfalltransportes nach Absatz 2 Nummer 3 leisten müssen. Für die anderen Leistungen nach Absatz 2 ist keine Zuzahlung zu leisten.

Zu Nummer 3 (§ 60)

§ 60 wurde neu strukturiert. Es wird nun klar zwischen Krankentransporten und Krankentransportflügen sowie Krankenfahrten differenziert, die in den Absätzen 3 und 4 definiert werden. Die bisher umfassten Rettungsfahrten sind nicht mehr Teil der Regelung des § 60, sondern als Notfalltransport in § 30 geregelt.

Zu Absatz 1

Absatz 1 umfasst inhaltlich den bisherigen Absatz 1 Satz 1 und 2. Er wird ergänzt durch die Klarstellung, dass die medizinische Notfallrettung nach § 27 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 in Verbindung mit § 30 nicht zu den Fahrkosten im Sinne dieser Vorschrift gehört, sondern als eigenständige Leistung der GKV zu gewähren ist. Damit wird die bisherige Unschärfe zwischen Fahrkostenleistungen und der medizinischen Notfallrettung aufgehoben. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (Urteil vom 20. Februar 2025 – B 1 KR 7/24 R) wird die Notfallrettung nicht mehr auf die bloße Übernahme von Kosten reduziert, sondern als originäre Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung ausgestaltet. Die Klarstellung dient auch der systematischen Abgrenzung: Fahrkostenregelungen erfassen weiterhin insbesondere Krankenfahrten, Krankentransporte und Krankentransportflüge, die der Beförderung von Versicherten zu oder von Behandlungen dienen. Demgegenüber umfasst die medizinische Notfallrettung die in § 30 dargestellten Leistungen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, wie auch der bisherige Absatz 2, für welche Fahrten die Kosten durch die Krankenkasse übernommen werden. Absatz 2 gilt grundsätzlich sowohl für Krankentransporte und Krankentransportflüge als auch für Krankenfahrten, soweit sich aus den einzelnen Regelungen nichts anderes ergibt. Die Wahl des Transportmittels hängt von den Bedarfen des Einzelfalles ab.

Satz 1 Nummer 1 und 2 entsprechen dabei der bisherigen Nummer 1. Neu ist Nummer 2 Buchstabe b, der eine Fahrt in ein anderes Krankenhaus zur Behandlung im Rahmen des Entlassmanagements nach § 39 Absatz 1a vorsieht. Ebenfalls neu ist eine Ergänzung in Nummer 2 Buchstabe a, die eine Verlegung dann als kostenübernahmefähig festsetzt, soweit es zur Behandlung des Versicherten der besonderen Mittel des Krankenhauses der höheren Stufe nicht oder nicht mehr bedarf und die dortigen Versorgungskapazitäten für andere Patienten benötigt werden.

Die Nummern 3 und 4 nehmen die Regelungsgegenstände der bisherigen Nummer 4 auf. In Nummer 3 ist lediglich Buchstabe b neu, der Fahrten zu einer ambulanten Operation in einer Vertragsarztpraxis einschließlich der hierzu erforderlichen Vor- und Nachbehandlungen innerhalb der Fristen des § 115a Absatz 2 Satz 1 bis 3 vorsieht. Die ambulante Operation in Vertragsarztpraxen wird somit der ambulanten Operationen im Krankenhaus gleichgestellt.

In Nummer 4 wird die Kostenübernahme für Fahrten zu ambulanten Behandlungen nicht mehr an die notwendige Vermeidung einer voll- oder teilstationären Krankenhausbehandlung geknüpft, da dies für regelmäßig ambulant durchgeführte, ihrer Natur nach häufigen Behandlungen, für die insbesondere Krankenfahrten medizinisch notwendig sein können, nicht passend ist. Es wird nun für Krankenfahrten vielmehr an die Ausnahmetatbestände nach § 8 der Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 des Gemeinsamen Bundesausschusses angeknüpft. Ein Ausnahmetatbestand liegt vor, wenn der Patient mit einem durch die Grunderkrankung vorgegebenen Therapieschema behandelt wird, das eine hohe Behandlungsfrequenz über einen längeren Zeitraum aufweist, oder eine Beförderung zur Vermeidung von Schaden an Leib und Leben unerlässlich ist, weil die Behandlung oder der zu dieser Behandlung führende Krankheitsverlauf den Patienten entsprechend beeinträchtigt.

Für Krankentransporte wird auf die zwingende medizinische Erforderlichkeit abgestellt. Der Patient muss aufgrund seiner Erkrankung auf die medizinisch-fachlicher Betreuung beziehungsweise die besondere Einrichtung eines Krankenkraftwagens angewiesen sein, um den Ort der ambulanten Behandlung sicher aufsuchen zu können.

Die Neufassung von Nummer 5 bildet die Einrichtung von Integrierten Notfallzentren ab. Es werden die Kosten für Fahrten zu einer notdienstlichen Versorgung in einem Integrierten Notfallzentrum nach Entscheidung eines Gesundheitsleitsystems von der Krankenkasse übernommen. Die Notfallbehandlung entspricht einer gesetzlich vorgesehenen Hauptleistung, sodass Fahrkosten, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser anfallen, erstattet werden können. Die Gesundheitsleitsysteme können insofern auch Fahrten, bei denen zwar keine Notfallsituation im Sinne des § 30 Absatz 1 vorliegt, aber ein Transport des Hilfesuchenden aus medizinischer Sicht geboten und auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erforderlich ist, disponieren. Dabei ist beispielsweise entscheidend, ob sich der Hilfesuchende in der Öffentlichkeit befindet und möglicherweise den Wetterbedingungen ausgesetzt ist oder ob die Fahrt auch durch eine dritte Person durchgeführt werden könnte. Insgesamt soll die Disposition von bedarfsgerechten Transportmitteln gefördert werden. So kann der Rettungsdienst im Rahmen des Notfallmanagements mögliche Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingehen und auf Grundlage des standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens auch Krankentransporte disponieren. Ebenso können die Kassenärztlichen Vereinigungen entsprechende Kooperationen eingehen und gegebenenfalls Krankentransporte zur vertragsärztlichen Versorgung disponieren. Bisher war die Durchführung erstattungsfähiger Krankentransporte zur ambulanten Erstversorgung nicht ohne weiteres möglich. Künftig sollen Rettungstransportwagen nur dann disponiert werden, wenn ein Krankentransport oder eine Krankenfahrt zu einer Notfallbehandlung beziehungsweise eine fallabschließende Versorgung vor Ort im Einzelfall aus medizinischer Sicht nicht ausreicht.

Krankentransporte bedürfen der ärztlichen Verordnung nach § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7. Erfolgt der Krankentransport aufgrund der Entscheidung im Rahmen eines Gesundheitsleitsystems, steht diese Entscheidung der ärztlichen Verordnung dieser Leistung gleich. Die ärztliche Verordnung wird folglich auf Grundlage des verbindlichen Ersteinschätzungsverfahrens als qualifizierte medizinische Entscheidung ersetzt. Diese Fiktion ist sachgerecht, da die Abfragesysteme von Rettungsleitstellen und Kassenärztlicher Vereinigung aus medizinischer Sicht unter Berücksichtigung aller Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Frage beantwortet, in welchen Fällen ein Krankentransport zu einer notdienstlichen Versorgung erfolgen soll. Der beauftragte Leistungserbringer muss sich darauf verlassen können, dass er die Leistung nicht „umsonst“ erbringt. Im Übrigen gilt es, unnötigen bürokratischen Aufwand zu vermeiden.

Bei Verlegungen in ein wohnortnahes Krankenhaus wird eine Entscheidungsfrist von 24 Stunden nach Antrags- eingang der Genehmigungen bei den Krankenkassen eingeführt, um eine möglichst effiziente Entlastung von wohnortfernen Spezialkrankenhäusern sicherzustellen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 definiert den Krankentransport und entspricht sinngemäß dem bisherigen Absatz 2 Satz 1 Nummer 3. Als Krankentransport anzusehen sind Fahrten mit medizinisch-fachlicher Betreuung, die in Kraftfahrzeugen durchgeführt werden, die über die besondere Einrichtung eines Krankenkraftwagens verfügen. Versicherte, die einer solchen Betreuung oder Einrichtung während der Fahrt bedürfen oder deren Zustand die Erforderlichkeit während der Fahrt erwarten lässt, haben Anspruch auf Kostenübernahme für einen Krankentransport. Ein solcher Anspruch besteht bei einem Krankentransport zu einer ambulanten Behandlung nach Absatz 2 Nummer 4 nur nach vorheriger Genehmigung durch die Krankenkasse. Es wird klargestellt, dass alle Regelungen für bodengebundene Krankentransporte ebenso für Krankentransportflüge gelten.

Zu Absatz 4

Absatz 4 definiert die Krankenfahrt als Fahrt ohne medizinisch-fachliche Betreuung, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln, privaten Kraftfahrzeugen, Mietwagen oder Taxen durchgeführt wird.

Zu Absatz 5

Absatz 5 entspricht dem bisherigen Absatz 3. Geregelt wird, in welcher Höhe Kosten für Krankentransporte und Krankenfahrten erstattet werden können. Für Krankentransporte wird dabei auf die Beträge verwiesen, die gemäß § 133 Absatz 2 und 3 festgesetzt oder vereinbart wurden. Für Krankenfahrten richten sich die anerkannten Kosten bei öffentlichen Verkehrsmitteln nach dem Fahrpreis, wobei Fahrpreisermäßigungen auszuschöpfen sind, bei Taxi oder Mietwagen nach den gemäß § 133 Absatz 4 vereinbarten Preisen und bei privaten Kraftfahrzeugen nach dem durch das Bundesreisekostengesetz vorgegebenen Kilometergeld.

Zu Absatz 6

Gemäß Absatz 6 sind Versicherte bei Krankentransporten und Krankenfahrten zur Zuzahlung in der nach § 61 Satz 1 vorgesehenen Höhe verpflichtet. Der Einzug erfolgt durch die Krankenkasse.

Zu den Absätzen 7 und 8

Die Absätze 7 und 8 entsprechen den bisherigen Absätzen 4 und 5.

Zu Absatz 9

In Absatz 9 wird konkretisiert, wann die Krankenkasse die Kosten für Krankentransportflüge und andere Verlegungen mittels luftgebundener Rettungsmittel zwischen medizinischen Behandlungseinrichtungen übernimmt, sofern diese aus medizinischen Gründen notwendig sind. Bezüglich des Anspruchs auf Kostenübernahme steht die ärztliche Verordnung der vorherigen Genehmigung durch die Krankenkasse gleich. Dies begründet sich mit der in vielen Fällen hohen zeitlichen Dringlichkeit entsprechender Verlegungen und der Verminderung bürokratischen Aufwands. Für die Regelung der Kostenübernahme bei Krankentransportflügen zur Verlegung in ein auf einen Eingriff oder eine Versorgung spezialisiertes Krankenhaus ergibt sich die Notwendigkeit zusätzlich aus der Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft in Deutschland und der damit einhergehenden Spezialisierung der Krankenhäuser. Die definitorische Differenzierung zwischen Rettungsflügen (gemäß § 60 Absatz 1 Nummer 3) und Krankentransportflügen stellt zudem eine Harmonisierung mit dem EU-Luftfahrtrecht gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1020 der Kommission vom 24. Mai 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 hinsichtlich der Anforderungen an den Flugbetrieb von Hubschraubern im medizinischen Noteinsatz dar.

Zu Nummer 4 (§ 73)

In § 60 wird nunmehr explizit ein Anspruch auf Krankentransporte, Krankentransportflüge und Krankenfahrten geregelt. Daher wird ausdrücklich klargestellt, dass Ärztinnen und Ärzte diese verordnen können.

Zu Nummer 5 (§ 73b)

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Einbindung von Notaufnahmen im Rahmen integrierter Notfallzentren in den Notdienst wird nunmehr in § 123 Absatz 1 Satz 4 geregelt.

Zu Nummer 6 (§ 75)**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich insgesamt um Folgeänderungen zu der Einführung der neuen Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen nach Absatz 1c, eine Akutleitstelle zu betreiben.

Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Neufassung wird eine redaktionelle Anpassung vorgenommen, da auf das Datum zur Einführung der Terminservicestelle verzichtet werden kann und die Terminservicestellen bereits seit dem Jahr 2020 aktiv sind. Aufgrund der organisatorischen Trennung der Aufgaben der Terminservicestellen und der Akutleitstellen ist eine tägliche Erreichbarkeit der Terminservicestellen an 24 Stunden künftig nicht mehr erforderlich. Daher wird zur Entlastung der Kassenärztlichen Vereinigungen geregelt, dass die Terminservicestellen an Werktagen unter der

bundesweit einheitlichen Rufnummer 116117 erreichbar sein müssen. Bei Anrufen zu der Rufnummer 116117 handelt es sich nicht um eine Notrufverbindung im Sinne des § 164 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes. Die Kassenärztlichen Vereinigungen bieten zudem überwiegend auch digitale Angebote an. Damit jedoch alle Versicherten unabhängig vom Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung zu den gleichen Bedingungen die Möglichkeit haben, Termine zu buchen, wird eine Konkretisierung hinsichtlich bundesweiter Einheitlichkeit der digitalen Angebote vorgenommen. Zusätzlich wird im Sinne der Barrierefreiheit festgelegt, dass die telefonischen und digitalen Angebote mit der Unterstützung digitaler Dolmetschdienste in den wichtigsten Sprachen und in Gebärdensprache verfügbar sein müssen. Die genaueren Regelungen für die Verfügbarkeit dieser Dienste bestimmt im Sinne der Bundeseinheitlichkeit die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Da nunmehr eine Verpflichtung der Akutleitstellen zur Kooperation mit den Rettungsleitstellen in § 133a Absatz 1 Satz 1 vorgesehen ist, entfällt die Regelung der Kooperationsmöglichkeit der Terminservicestellen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der Akutleitstellen.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Bisher hatten die Terminservicestellen die Aufgabe, Versicherten in Akutfällen auf der Grundlage eines bundesweit einheitlichen, standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens eine unmittelbare ärztliche Versorgung in der medizinisch gebotenen Versorgungsebene, in geeigneten Fällen auch in Form einer telefonischen ärztlichen Konsultation, zu vermitteln. Diese Aufgabe wird nunmehr der neuen Akutleitstelle nach Absatz 1c übertragen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Regelung, wann für die Vermittlung eines Termins bei einer Fachärztin oder bei einem Facharzt durch die Terminservicestelle ausnahmsweise auf eine Überweisung verzichtet werden kann, wird sprachlich angepasst. Künftig entfällt das Überweisungserfordernis nach einer Behandlung in einem Integrierten Notfallzentrum. Inhaltlich bleibt es die Aufgabe der Terminservicestelle, Versicherten ohne Überweisungserfordernis Termine zu vermitteln sollte sich nach Inanspruchnahme eines Integrierten Notfallzentrums ein weiterer Behandlungsbedarf ergeben haben. Dies ist eine Folgeanpassung zur flächendeckenden Einführung von Integrierten Notfallzentren. Da nunmehr die Akutleitstellen die Ersteinschätzung durchführen, wird der Entfall des Überweisungserfordernisses in Absatz 1c überführt.

Zu Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe bbb

Um die Erreichbarkeit der Terminservicestellen patientenfreundlich in allen Bundesländern einheitlich und auf einem hohen Niveau zu gewährleisten, werden die Vertragsparteien des Bundesmantelvertrags – Ärzte verpflichtet, entsprechende Regelungen dort festzulegen.

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung nutzen insgesamt 15 von 17 Kassenärztlichen Vereinigungen den elektronischen Terminservice nach Satz 16 zur digitalen Terminbuchung über die Terminservicestelle. Damit bundesweit einheitlich agiert wird und folglich allen Versicherten die gleichen barrierefreien Möglichkeiten zur Terminbuchung (digital und telefonisch) über die Terminservicestelle zur Verfügung stehen, werden nun alle Kassenärztlichen Vereinigungen zur Nutzung des elektronischen Terminservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung verpflichtet. Eigene digitale Angebote der Kassenärztlichen Vereinigungen können weiterhin zusätzlich angeboten werden. Darüber hinaus wird damit gewährleistet, dass Regelungen die an den elektronischen Terminservice anknüpfen (zum Beispiel § 370a) bundesweit einheitlich greifen können und eine Stärkung der Barrierefreiheit bei der bundesweiten Terminbuchung ermöglicht wird.

Zu Doppelbuchstabe ee

Die Regelungen der bisherigen Sätze 18 und 19 werden in den neuen Absatz 1e wortgleich überführt.

Zu Doppelbuchstabe ff

Es wird geregelt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen Integrierten Notfallzentren im Bedarfsfall eine Terminbuchung bei Vertragsärzten ermöglichen müssen. Ziel ist es, die notwendige Weiterversorgung sicherzustellen und eine erneute Inanspruchnahme der Notdienststrukturen zu vermeiden.

Zu Buchstabe b**Zu Absatz 1b**

Der Sicherstellungsauftrag nach Absatz 1 umfasst mit der Konkretisierung des Absatz 1b eine jederzeit verfügbare Versorgung in Fällen, in denen eine unverzügliche Behandlung aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Diese Versorgung ist durchgängig sicherzustellen, das bedeutet 24 Stunden täglich an sieben Tagen der Woche. Sie kann und soll wie bisher innerhalb der vertragsärztlichen Sprechstunden erbracht werden. In diesem Fall ist die Behandlung nicht auf bestimmte Maßnahmen begrenzt und kann über das zur Erstversorgung Notwendige hinausgehen. Sofern die Versorgung jedoch im Rahmen des Notdienstes der Kassenärztlichen Vereinigungen nach Satz 5 erbracht wird, wird sie künftig als notdienstliche Akutversorgung legaldefiniert. Sie umfasst in der notdienstlichen Akutversorgung alle Maßnahmen des medizinischen Behandlungsbedarfs und je nach medizinischer Erfordernis auch die fallabschließende Behandlung oder Weiterleitung in eine weiterführende ambulante Behandlung. Sie kann auch die Feststellung einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit sowie die Verordnung von kurzfristig benötigten Arzneimitteln, Krankenfahrten, Krankentransporten und Apotheken-Botendiensten umfassen. Entsprechend der bisherigen Rechtslage wird die notdienstliche Akutversorgung als vertragsärztliche Leistung erbracht.

In Satz 5 wird konkretisiert, welche Strukturen die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen des Notdienstes im Besonderen gewährleisten müssen. Sie haben die notdienstliche Akutversorgung künftig insbesondere durch die Beteiligung an Integrierten Notfallzentren sowie durch ein telemedizinisches und ein aufsuchendes Versorgungsangebot sicherzustellen. Mit diesen Angeboten werden neben den zugelassenen und ermächtigten Leistungserbringern zusätzliche zentrale Anlaufstellen der vertragsärztlichen Versorgung in Not- oder Akutfällen geschaffen. Damit bleibt aber unberührt, dass in Fällen, in denen eine unverzügliche Behandlung aus medizinischen Gründen erforderlich ist, die Behandlung prioritär durch verfügbare zugelassene und ermächtigte Leistungserbringer in der Regelversorgung umfassend erfolgt. Durch die Formulierung „insbesondere“ in Satz 5 wird klar gestellt, dass es neben diesen nicht abschließend aufgezählten Versorgungsangeboten weiterhin den Kassenärztlichen Vereinigungen obliegt, einen hinreichenden fachärztlichen Notdienst, zum Beispiel durch Augenärztinnen und -ärzte, zu gewährleisten. Soweit eine entsprechende Versorgung durch die in Satz 5 aufgezählten Angebote nicht sichergestellt werden kann, sind (fachärztliche) Notdienststrukturen – insbesondere zu den sprechstundenfreien Zeiten – zu schaffen oder aufrecht zu erhalten.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, sich an flächendeckend einzurichtenden Integrierten Notfallzentren nach den Maßgaben der §§ 123 ff. zu beteiligen, also entsprechend Kooperationsverträge abzuschließen und die jeweilige Notaufnahme des zugelassenen Krankenhauses unmittelbar in den ambulanten Notdienst gemäß § 123 Absatz 1 Satz 4 einzubinden (Nummer 1). Wie bereits heute gilt dann das jeweilige zugelassene Krankenhaus als zur vertragsärztlichen Versorgung gehörig und unterliegt diesbezüglich nicht den Einschränkungen des § 76 Absatz 1 Satz 2; es kann selbständig eine notdienstliche ambulante Erstversorgung erbringen und diese auch vertragsärztlich abrechnen; dies ergibt sich aus Absatz 1b Satz 10.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben darüber hinaus sicherzustellen, dass Ärztinnen und Ärzte jederzeit für eine telefonische und videounterstützte Versorgung erreichbar sind. Dabei kann es sich um Ärztinnen und Ärzte der Akutleitstelle (Beratungsärztinnen und -ärzte) oder anderer Einrichtungen der vertragsärztlichen Versorgung handeln (Nummer 2). Die Versorgung erfolgt durch einen über die Akutleitstelle vermittelten telefonischen oder videounterstützten Kontakt. Sie kann als Videosprechstunde nach § 365 erbracht und nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab abgerechnet werden. Zur Finanzierung des Ausbaus der technischen und personellen Ausstattung und einer rund um die Uhr zu gewährleistenden telefonischen und videounterstützten ärztlichen Beratungsleistung müssen die entsprechenden Selbstverwaltungspartner gegebenenfalls zusätzliche Mittel gemäß der nunmehr schiedsfähigen Verpflichtung nach § 105 Absatz 1b zur Verfügung stellen. Zur weiteren Entlastung der Kassenärztlichen Vereinigungen und zur Erreichung von Synergieeffekten sollen diese untereinander und mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kooperieren, da entsprechende Leistungen auch dezentral erbracht werden können. Die Akutleitstelle kann Integrierten Notfallzentren nach § 123 durch die Angebote telefonischer Konsilien oder telemedizinischer Konsilien nach § 367 bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen unterstützen. Diese zusätzlichen Angebote führen insgesamt zu einer erheblichen Entlastung sonstiger Notfallstrukturen.

Speziell mit Blick auf die demographische Bevölkerungsentwicklung ist neben dem telefonischen beziehungsweise videounterstützten Versorgungsangebot ein aufsuchender Dienst, der täglich 24 Stunden angeboten werden

muss, notwendig für eine bedarfsgerechte notdienstliche Versorgung (Nummer 3). Insbesondere soll diese Versorgung auch auf die besonderen Belange von Pflegebedürftigen eingehen und Versorgungslücken insbesondere für immobile Patientinnen und Patienten schließen. Unter anderem können dadurch (etwa durch Klärung der Transportnotwendigkeit oder Behandlung vor Ort) Fahrten in die Notaufnahmen der Krankenhäuser und nicht bedarfsgerechte Einsätze der Rettungsdienste reduziert werden. Die Organisation der notdienstlichen Versorgung obliegt der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung. Zur personellen und wirtschaftlichen Entlastung wird den Kassenärztlichen Vereinigungen ermöglicht, hierzu Kooperationen mit dem Rettungsdienst einzugehen und diese Leistung auch durch speziell geschulte Angehörige der Gesundheitsfachberufe zu erbringen, welche aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erworben haben, um im Rahmen ärztlicher Delegation nach § 28 Absatz 1 tätig zu werden.

Die Sätze 10 und 11 entsprechen Absatz 1b Satz 5 und 6 des geltenden Rechts.

Satz 12 entspricht Absatz 1b Satz 7 des geltenden Rechts. Damit wird an der Vorgabe festgehalten, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Landesapothekerkammern in einen Informationsaustausch treten sollen. Auch im Rahmen der Organisation der notdienstlichen Versorgung muss es das Ziel sein, die Versorgung von Versicherten mit Arzneimitteln nach Möglichkeit zu erleichtern.

Satz 13 verpflichtet die Kassenärztliche Bundesvereinigung zur Bereitstellung eines einheitlichen softwaregestützten Systems zur Dokumentation der Versorgung durch den Ärztlichen Bereitschaftsdienstes, der Akutleitstellen und der Behandlung in einer Notdienstpraxis eines Integrierten Notfallzentrums, welches die gemeinsame Notfallversorgung der Versicherten sowie eine digitale Fallübergabe, einschließlich aller für die Weiterbehandlung relevanter medizinischer Informationen, bei einer Weiterleitung an eine weiterführende Versorgungseinrichtung sicherstellt. Die digitale Fallübergabe innerhalb Integrierter Notfallzentren und die Kompatibilität mit der Telematikinfrastruktur sind dabei zu gewährleisten.

Zu Absatz 1c

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben nunmehr unter derselben bundesweiten Rufnummer nach Absatz 1a Satz 2 zusätzlich zu den Terminservicestellen sogenannte Akutleitstellen nach Absatz 1c einzurichten. Diese dienen als zentrale erste Anlaufstelle für Personen, die von einer sofortigen ambulanten Behandlungsnotwendigkeit ausgehen. Die Akutleitstellen sind nach § 133a Absatz 2 Satz 1 verpflichtet, Kooperationen nach § 133a mit den Rettungsleitstellen unter der Notrufnummer 112 einzugehen, um bedarfsgerecht in die angemessene Versorgungsstruktur zu steuern.

Es handelt sich bei Anrufen zu den Akutleitstellen nicht um Notrufverbindungen im Sinne des § 164 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Es ist auch nicht geplant, dass die Akutleitstellen eine Filterfunktion für die Notrufnummer 112 wahrnehmen. Beide Nummern bleiben weiter bestehen.

Als entscheidende Voraussetzung, dass eine Vernetzung mit den Rettungsleitstellen gelingen kann, werden konkrete Erreichbarkeitsvorgaben für die Akutleitstelle in den Sicherstellungsauftrag aufgenommen. Hier werden die Empfehlungen der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung aufgegriffen und wird gesetzlich festgelegt, dass bei der Akutleitstelle die Wartezeit auf eine Ersteinschätzung maximal drei Minuten in 75 Prozent aller Anrufe und maximal zehn Minuten in 95 Prozent aller Anrufe betragen darf. Letztgenanntes verhindert, dass Anrufende sich lediglich aufgrund zu langer Wartezeiten („Warteschleife“) an den Notruf 112 wenden. Es obliegt der Rechtsaufsicht der Länder, diese Vorgaben zu kontrollieren. Zusätzlich sind die Akutleitstellen 24 Stunden täglich über digitale Angebote erreichbar. Zur Anpassung an die Neuregelung der Erreichbarkeit ist ein Übergangszeitraum von sechs Monaten notwendig. Diese Übergangsfrist soll es den Kassenärztlichen Vereinigungen ermöglichen, das für die vorgeschriebenen Erreichbarkeitszeiten gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Personal bereitzustellen.

Die Akutleitstellen vermitteln auf der Grundlage eines bundeseinheitlichen, standardisierten Ersteinschätzungsverfahrens bei sofortiger Behandlungsbedürftigkeit und in geeigneten Fällen primär in die vertragsärztliche Regelversorgung (Akuttermin bei einer in zumutbarer Nähe gelegenen Praxis, Termin zur Videosprechstunde bei einer Vertragsärztin oder einem Vertragsarzt, Vermittlung in offene Sprechstunden, Hausbesuche). Eine Überweisung oder ein Vermittlungscode sind in diesen Fällen nicht notwendig.

Wenn durch die Akutleitstelle keine rechtzeitige oder zumutbare ambulante Behandlung in der Regelversorgung vermittelt werden kann, stehen die nach Absatz 1b Satz 5 vorgesehenen Angebote der notdienstlichen Akutver-

sorgung zur Verfügung. Hier wird die bereits bestehende Verpflichtung, in geeigneten Fällen eine telefonische ärztliche Konsultation anzubieten, erweitert auf videounterstützte Verfahren. In den Ausnahmefällen, in denen ein lebensbedrohlicher Notfall vorliegt und der Anrufende eigentlich die Notrufnummer 112 hätte wählen müssen, leitet die Akutleitstelle den Anrufenden unmittelbar an die Rettungsleitstelle weiter. In diesen Fällen findet keine Übermittlung der Standortangaben statt, da es sich bei der weitergeleiteten Verbindung nicht um eine Notrufverbindung im Sinne des § 164 Absatz 1 Satz 1 TKG handelt.

Ergibt die Ersteinschätzung keine sofortige Behandlungsbedürftigkeit beziehungsweise einen Akutfall, so gilt bei einem sonstigen Behandlungsbedarf nach wie vor Absatz 1a.

Zusätzlich wird im Sinne der Barrierefreiheit festgelegt, dass die telefonischen und digitalen Angebote mit der Unterstützung digitaler Dolmetschdienste in den wichtigsten Sprachen und in Gebärdensprache verfügbar sein müssen. Die genaueren Regelungen für die Verfügbarkeit dieser Dienste bestimmt im Sinne der Bundeseinheitlichkeit die Kassenärztliche Bundesvereinigung.

Zu Absatz 1d

Der neue Absatz 1d stellt klar, dass sowohl die Terminservicestellen als auch die Akutleitstellen personenbezogene Daten der Anrufenden zur Erfüllung ihrer Aufgaben verarbeiten dürfen. Die Akutleitstellen dürfen auch Sprachaufzeichnungen fertigen. Da es in der Akutleitstelle nicht nur um reine Terminvermittlung, sondern auch um die Weiterleitung von Notfällen an die Rettungsleitstellen, die Vermittlung von Akutfällen und die medizinische Beratung durch Beratungsärztinnen und -ärzte geht, sind die aufgenommenen personenbezogenen Daten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Diese Daten können beispielsweise zur Klärung von Haftungsfällen, zur Qualitätssicherung für das gemeinsame Qualitätsmanagement nach § 133a Absatz 3 oder zum besseren Umgang mit und zur Identifikation von häufig Anrufenden dienen.

Zu Absatz 1e

Absatz 1e entspricht Absatz 1a Satz 23 und 24 des geltenden Rechts.

Zu Absatz 1f

Die vertragszahnärztliche Versorgung zu den sprechstundenfreien Zeiten (zahnärztlicher Notdienst) bleibt von der Neufassung der notdienstlichen Akutversorgung in den Absätzen 1a bis 1e unberührt. Eine Änderung des bislang bestehenden Sicherstellungsauftrags der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen für den zahnärztlichen Notdienst und der damit verbundenen Pflichten erfolgt nicht. Es wird lediglich klargestellt, dass die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen die Versicherten dennoch bundesweit einheitlich im Internet über die Sprechstundenzeiten sowie barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu informieren haben.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Verweisanpassung als Folgeänderung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anpassung ist eine Folgeänderung und dient einheitliche Verwendung des Begriffs „Rufnummer“ in § 75.

Zu Nummer 7 (§ 76)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuregelung der Akutleitstelle in § 75 Absatz 1c. Zudem soll die Inanspruchnahme einer Notaufnahme für auf die Erstversorgung folgende weitere Behandlungen nur noch im Fall der Vermittlungen der Terminservicestelle nach § 75 Absatz 1a Satz 7 in eine Notaufnahme möglich sein.

Zu Nummer 8 (§ 87)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Regelung der Akutleitstelle in § 75 Absatz 1c.

Zu Nummer 9 (§ 87a)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Regelung der Akutleitstelle in § 75 Absatz 1c.

Zu Nummer 10 (§ 90)**Zu Buchstabe a**

Die zuständigen obersten Landesbehörden wirken auch für die neuen Aufgaben nach § 123 Absatz 6 Satz 2, § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 im erweiterten Landesausschuss beratend mit. Das Mitberatungsrecht umfasst auch das Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung und das Recht zur Antragstellung, damit die zuständige oberste Landesbehörde ihre versorgungs- und planungsrelevanten Erkenntnisse bestmöglich in die Beratungen einbringen kann.

Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 4a regelt den erweiterten Landesausschuss und das Verfahren bezüglich seiner Aufgaben.

Der erweiterte Landesausschuss nach dem bisherigen § 116b Absatz 3 erhält mit der Standortfestlegung von Integrierten Notfallzentren und Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 neue Aufgaben und wird systematisch neu verortet. Es kommt auch die Aufgabe nach § 123 Absatz 6 Satz 2, die Konzeption und Koordinierung der telemedizinischen Unterstützung von Integrierten Notfallzentren, an deren Standort kein Integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche vorhanden ist, hinzu.

Der Landesausschuss nach Absatz 1 wird als erweiterter Landesausschuss um Vertreter der Krankenhäuser in der gleichen Zahl erweitert, wie sie jeweils für die Vertreter der Krankenkassen und die Vertreter der Ärzte vorgesehen ist. Die dem erweiterten Landesausschuss durch die Wahrnehmung seiner neuen Aufgaben entstehenden Kosten werden zur Hälfte von den Verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen sowie zu je einem Viertel von den beteiligten Kassenärztlichen Vereinigungen und der Landeskrankenhausesellschaft getragen. Bei Entscheidungen nach § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 ist Einvernehmen mit den obersten Landesplanungsbehörden herzustellen. Im Zusammenhang mit den Aufgaben nach § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 sind Vertreter der Leistungserbringer im Rettungsdienst im Umfang von einer Stimme mit Mitberatungsrecht eingebunden. Diese werden von der zuständigen obersten Landesbehörde benannt. Kommt die Festlegung nach § 123a Absatz 1 oder § 123b Absatz 1 ganz oder teilweise nicht fristgemäß zustande, setzt die zuständige oberste Landesbehörde unverzüglich eine angemessene Nachfrist, die sechs Wochen nicht überschreiten darf. Ist auch die Nachfrist ergebnislos verstrichen, erfolgt die Festlegung durch die zuständige oberste Landesbehörde innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der Nachfrist. Der erweiterte Landesausschuss stellt die hierfür erforderlichen Informationen, Unterlagen und Stellungnahmen unverzüglich zur Verfügung. Der Ablauf der Frist zur Ersatzvornahme wird bis zum Eingang der angeforderten Informationen, Stellungnahmen und Unterlagen unterbrochen. Die Festlegung der Standorte nach § 123a Absatz 1 und § 123b Absatz 1 sind regelmäßig zu überprüfen. Bei Veränderungen der tatsächlichen Gegebenheiten, etwa in dem Fall, dass ein Krankenhausstandort Kriterien nach § 123a Absatz 1 Satz 3 bis 5 nicht mehr erfüllt, die für seine Bestimmung wesentlich waren, kann eine neue Standortfestlegung beschlossen werden.

Zu Nummer 11 (§ 90a)

Vertreter des Rettungsdienstes werden explizit als mögliche Mitglieder in die Regelung der gemeinsamen Landesgremien nach § 90a aufgenommen. Dies geschieht, um die Expertise der Rettungsdienste insbesondere bei Empfehlungen zur sektorenübergreifenden Notfallversorgung mit einzubinden und die Mitspracherechte für sie als wichtige Akteure der Notfallversorgung zu erweitern. Aufgrund der unterschiedlichen landesrechtlichen organisatorischen Ausgestaltung des Rettungsdienstes obliegt es den Ländern, die konkreten Mitglieder in Abstimmung mit der landesrechtlichen Verantwortung für Rettungsleitstellen und Leistungserbringung im Rettungsdienst zu benennen.

Zu Nummer 12 (§ 92)

Es handelt sich um eine Klarstellung, dass die Ermächtigung des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 Regelungen zu Krankentransporten, Krankentransportflügen und Krankenfahrten nach § 60, nicht aber den Notfalltransport nach § 30 umfasst.

Zu Nummer 13 (§ 105)

Grundsätzlich sind Förderungen von Eigeneinrichtungen nach Absatz 1c – wozu auch die Eigeneinrichtungen des Notdienstes zählen – bereits über Absatz 1a Satz 3 Nummer 4 über den Strukturfonds möglich. Nach Absatz 1b

können zudem bereits jetzt zusätzliche Mittel zweckgebunden zur Förderung der Sicherstellung der Strukturen des Notdienstes bereitgestellt werden. Von dieser Möglichkeit ist aber nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht worden. Vor dem Hintergrund des Ausbaus und der Vernetzung der Leitstellen, der Konkretisierung des Sicherstellungsauftrages und der Einrichtung sektorenübergreifender Behandlungsstrukturen müssen daher künftig die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich zusätzliche Mittel zweckgebunden zur Sicherstellung der neuen und auszubauenden Strukturen des Notdienstes vereinbaren. Die Finanzierung der Förderung wird dadurch begrenzt, dass der Betrag in gleicher Höhe von den beiden Vertragsparteien bereitzustellen ist.

Die privaten Krankenversicherungsunternehmen müssen in Anlehnung an ihren um Beihilfeanteile bereinigten Anteil am Krankenversicherungsmarkt eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 7 Prozent an der unter ihrer Beteiligung bestimmten Förderung der Strukturen des Notdienstes leisten. Dabei werden die verfassungsrechtlichen Vorgaben an die Zulassung derartiger Sonderabgaben (besonderer, über das Finanzierungsanliegen hinausgehender Sachzweck der Finanzierung, spezifische Sachnähe der Herangezogenen und eine gruppennützige Verwendung der Abgaben) gewahrt. Medizinische Notfälle ergeben sich unabhängig vom Versicherungsstatus. Es ist notwendig, übergreifende Strukturen zur Versorgung aller Versicherten zu schaffen, die der allgemeinen Krankenversicherungspflicht unterliegen. Zwar dienen die Regelungen im Fünften Buch Sozialgesetzbuch und damit Maßnahmen in Absatz 1b Satz 5 zunächst der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung von gesetzlich Versicherten und sind insofern nicht unmittelbar den Versicherten der privaten Krankenversicherungsunternehmen gewidmet. Dennoch ist es Realität, dass Versicherte der privaten Krankenversicherungsunternehmen, die ihren Versicherten gegenüber gesetzlich zum Aufwendungsersatz für medizinisch notwendige Heilbehandlungen verpflichtet sind, aber weder regelmäßig noch flächendeckend eigenen Notfallversorgungsstrukturen vorhalten, auf die Sicherstellungsstrukturen der Kassenärztlichen Vereinigungen zurückgreifen. Auch zukünftig sollten die mit diesem Gesetz verbesserten Strukturen der Notfallversorgung wie beispielsweise die Akuteitstelle für diesen Personenkreis weiterhin nutzbar sein. Für die privaten Krankenversicherungsunternehmen können sich darüber hinaus mit den verbesserten Notfallversorgungsstrukturen Einsparpotentiale ergeben.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. und die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen vereinbaren das Nähere zur Bereitstellung des Finanzierungsanteils der privaten Krankenversicherungsunternehmen. Die vorzugsweise an den Versicherten zahlen zu orientierende interne Umlage des Beitrags der privaten Krankenversicherungsunternehmen bleibt deren interner Disposition überlassen. Der Betrag, den die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam zur Verfügung stellen müssen, wird um den Betrag gemindert, den die privaten Krankenversicherungsunternehmen bereitstellen.

Förderfähig sind dabei zunächst die Strukturen nach § 75 Absatz 1b Satz 5 Nummer 2 und 3, § 75 Absatz 1c und § 133a; hierzu zählen insbesondere die Errichtung und der Betrieb der Akuteitstellen, inklusive der Vorhaltung des Personals zur Ersteinschätzung und von Beratungsärztinnen und -ärzten, der aufsuchende Dienst und Maßnahmen zur digitalen Vernetzung der Akuteitstelle mit den Rettungsleitstellen. Darüber hinaus sind die integrierten Notfallstrukturen nach den §§ 123 bis 123b förderfähig; hierzu zählen insbesondere die Errichtung und Vorhaltung von Notdienstpraxen und Maßnahmen zur digitalen Vernetzung.

Kooperationspraxen nach § 123 Absatz 1 Satz 6 können durch Mittel aus dem Strukturfonds nach Absatz 1a gefördert werden.

Zur Bestimmung des Betrags zur Finanzierung der Förderung müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen den Vertragsparteien eine hinreichend detaillierte Kalkulation für ihren Bedarf vorlegen. Die Positionen sind auch dahingehend zu begründen, warum über die Mittel nach Absatz 1a hinaus ein Finanzierungsbedarf besteht. Um eine Doppelfinanzierung im Zusammenhang mit dem Notdienst zu vermeiden, soll der Betrag zur Finanzierung der Förderung um die bereits nach der regionalen Euro-Gebührenordnung oder einem Gesamtvertrag abgerechneten Leistungen und Kosten, nicht ausgeschöpfte Mittel des Honorarvolumens für die Vergütung der Leistungen im Notfall und im Notdienst nach § 87b Absatz 1 Satz 3 sowie sonstige Entgelte gemindert werden. Aufgrund dieser Kalkulation finden die Vertragsverhandlungen statt. Erfolgt keine Einigung, so entscheidet das zuständige Schiedsamt für die vertragsärztliche Versorgung nach § 89, sobald dort ein entsprechender Antrag gestellt wird. Der Betrag zur Finanzierung der Förderung ist jährlich anhand des Bedarfs und der Kalkulationen zu evaluieren und demgemäß anzupassen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat jährlich einen Bericht über die Anzahl und den jeweiligen Inhalt der Vereinbarungen einschließlich der Höhe der vereinbarten Beträge bezogen auf die einzelnen Förderzwecke zu veröffentlichen.

Zu Nummer 14 (§ 115a)

Mit dieser Änderung wird den Krankenhäusern bei Einweisung durch den Rettungsdienst eine vorstationäre Behandlung der Patientin oder des Patienten ermöglicht. Damit erhalten die Krankenhäuser eine kostendeckende Vergütung der ambulanten Behandlung im Sinne der Abklärung der Erforderlichkeit einer Aufnahme zur vollstationären Krankenhausbehandlung bzw. der Vorbereitung einer Aufnahme zur vollstationären Krankenhausbehandlung.

Zu Nummer 15 (§ 115e)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuregelung der Kostenübernahme für Krankentransporte und Krankenfahrten in § 60 und der gesonderten Regelung des Anspruchs auf Notfalltransport in § 30 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 5.

Zu Nummer 16 (§ 116b)**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Neuverortung des erweiterten Landesausschusses in § 90 Absatz 4a.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Neuverortung des erweiterten Landesausschusses in § 90 Absatz 4a.

Zu Nummer 17 (§ 120)**Zu Buchstabe a**

Es handelt sich um eine klarstellende Regelung dahingehend, dass auch Leistungen von Krankenhäusern und Ärztinnen und Ärzte, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, die jedoch im Rahmen der Zusammenarbeit in den Notdienst einbezogen sind, nach den für Vertragsärzte geltenden Grundsätzen aus der Gesamtvergütung zu vergüten sind.

Zu Buchstabe b

Der Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss zum Erlass einer Richtlinie, die Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und standardisierten Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, die sich zur Behandlung eines Notfalls nach § 76 Absatz 1 Satz 2 an ein Krankenhaus wenden, beinhaltet, wird aufgehoben. Damit verliert die bereits beschlossene, aber wegen Beanstandung nicht in Kraft getretene Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses ihre Rechtsgrundlage und ist hinfällig. Ein der neuen gesetzlichen Lage angepasster Auftrag zum Erlass einer Richtlinie mit Vorgaben für ein standardisiertes digitalisiertes Ersteinschätzungsinstrument zur Steuerung der Hilfesuchenden im Rahmen der Strukturen des Integrierten Notfallzentrums wird in § 123 Absatz 3 aufgenommen.

Zu Nummer 18 (§ 123)

§ 123 regelt die bundesweit flächendeckende Einrichtung von Integrierten Notfallzentren.

Zu Absatz 1

Absatz 1 beschreibt die Zusammensetzung und grundsätzliche Funktion von Integrierten Notfallzentren. Diese bestehen aus der Notaufnahme eines zugelassenen Krankenhauses, einer Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung in räumlicher Integration mit der Notaufnahme des Krankenhausstandortes und einer zentralen Ersteinschätzungsstelle. Die fachliche Leitung und die Verantwortung für die Ersteinschätzungsstelle obliegt grundsätzlich dem Krankenhaus. Dieses ist auch außerhalb der Öffnungszeiten der Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort vertreten. In der Kooperationsvereinbarung, die die Kassenärztliche Vereinigung und das Krankenhaus nach § 123a Absatz 2 schließen, kann jedoch etwas Abweichendes vereinbart werden.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden durch die Konkretisierung des Sicherstellungsauftrags verpflichtet, die notdienstliche Akutversorgung insbesondere durch Kooperation und organisatorische Verknüpfung mit zuge-

lassenen Krankenhäusern in Integrierten Notfallzentren sicherzustellen und die Notaufnahme des Krankenhauses unmittelbar in den Notdienst einzubeziehen. Wie bereits heute gilt dann das jeweilige zugelassene Krankenhaus als zur vertragsärztlichen Versorgung gehörig und unterliegt diesbezüglich nicht den Einschränkungen des § 76 Absatz 1 Satz 2; es kann selbständig eine notdienstliche ambulante Erstversorgung erbringen und diese auch vertragsärztlich abrechnen. Dies ergibt sich aus § 75 Absatz 1b Satz 10. Reziprok werden zugelassene Krankenhäuser, an deren Standort ein Integriertes Notfallzentrum eingerichtet werden soll, zur Kooperation im Rahmen des Integrierten Notfallzentrums verpflichtet. Hiermit wird an die bereits jetzt aufgrund von § 75 Absatz 1b Satz 3 des geltenden Rechts bestehende Rechtslage angeknüpft, aber diese für zugelassene Krankenhäuser, deren Standort als Standort für ein Integriertes Notfallzentrum festgelegt wurde, und für die Kassenärztlichen Vereinigungen verbindlich. Gleichzeitig wird der kooperative Charakter eines Integrierten Notfallzentrums betont, dass Notaufnahme und Ersteinschätzungsstelle grundsätzlich in Trägerschaft des zugelassenen Krankenhauses beziehungsweise die Notdienstpraxis in Trägerschaft der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung verbleiben. Eine gemeinsame Trägerschaft zwischen Krankenhaus und Kassenärztlicher Vereinigung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Steuerung innerhalb des Integrierten Notfallzentrums. Die zentrale Ersteinschätzungsstelle trifft für Hilfesuchende, die mit einem von ihnen als dringend erachteten gesundheitlichen Anliegen selbständig ein Integriertes Notfallzentrum aufsuchen, eine Entscheidung dazu, welche Dringlichkeit die Behandlung hat. Für die Zeiten, in denen die Notdienstpraxis geöffnet hat, entscheidet sie außerdem, in welcher Versorgungsebene des Integrierten Versorgungszentrums, also Notaufnahme oder Notdienstpraxis, die Patientin oder der Patient am besten versorgt werden kann. Hilfesuchende, die aufgrund einer ärztlichen Verordnung von Krankenhausbehandlung ein Integriertes Notfallzentrum aufsuchen oder durch den Rettungsdienst eingeliefert werden, fallen nicht unter diese Regelung. Für Hilfesuchende, welche bereits kein von ihnen als dringend erachtetes gesundheitliches Anliegen schildern, beispielsweise eine Routineuntersuchung wünschen, steht demgegenüber allein die vertragsärztliche Regelversorgung offen; sie können zum Beispiel auf die Rufnummer 116117 verwiesen werden. Eine Ersteinschätzung findet nicht statt. Aus Gründen der Patientensicherheit ist nach einer bloßen Ersteinschätzung eine Verweisung aus den Räumlichkeiten des Integrierten Notfallzentrums heraus für Patientinnen und Patienten nur nach einer separat zu vergütenden tatsächlichen Untersuchung durch eine Ärztin beziehungsweise einen Arzt entweder in der Notdienstpraxis oder der Notaufnahme möglich. Die Ersteinschätzung kann im Wege der Delegation durch nichtärztliches Personal erbracht werden. Ab dem vom Gemeinsamen Bundesausschuss in seiner Richtlinie nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 bestimmten Zeitpunkt erfolgt die Ersteinschätzung auf der Grundlage eines digitalen standardisierten Instruments. Das Ergebnis des Ersteinschätzungsinstruments dient der Ersteinschätzungsstelle als maßgebliche Entscheidungsgrundlage.

Innerhalb des Integrierten Notfallzentrums werden bei der Fallübergabe zwischen den Kooperationspartnern alle verfügbaren und für die weitere Behandlung erforderlichen Daten in einem standardisierten Datenformat wechselseitig digital übermittelt. Für die Steuerung der Patientinnen und Patienten im Integrierten Notfallzentrum sind die Kooperationspartner befugt, die hierfür notwendigen personenbezogenen Daten zu verarbeiten und auszutauschen. Eine entsprechende Rechtsgrundlage wird vorgesehen.

Sollte nach erfolgter notdienstlicher Akutversorgung im Integrierten Notfallzentrum die medizinische Erforderlichkeit einer Weiterbehandlung bestehen, wird den Patientinnen und Patienten ein Termin in der ambulanten Regelversorgung, einschließlich einer telefonischen oder videounterstützten Versorgung, über das System der Terminservicestelle vermittelt.

Die Bewertung der Behandlungsdringlichkeit im Rahmen der Ersteinschätzung nach Satz 1 erfolgt in mehreren Dringlichkeitsstufen. Die Steuerung von Hilfesuchenden über die Akutleitstelle beziehungsweise die Kooperation mit den Rettungsleitstellen nach § 133a ist entscheidend für eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Akut- und Notfallversorgung. Um einen Anreiz für eine Kontaktaufnahme mit der Akutleitstelle zu schaffen, wird vorgesehen, dass Hilfesuchende, die das Integrierte Notfallzentrum auf der Grundlage einer telefonischen Vermittlung durch die Akutleitstelle aufsuchen, dort bei gleicher medizinischer Behandlungsdringlichkeit innerhalb derselben Dringlichkeitsstufe grundsätzlich vorrangig behandelt werden. Das Nähere zum Nachweis der Vermittlungen der Akutleitstelle regelt der Bundesmantelvertrag-Ärzte. Neben der medizinischen Behandlungsdringlichkeit können weitere Faktoren zur Vermeidung sozialer Härten wie zum Beispiel Aufgaben der Kinderbetreuung oder Pflege in die Entscheidung über die Behandlungsreihenfolge mit einbezogen werden.

Zu Absatz 3

Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in einer Richtlinie innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes Vorgaben für ein standardisiertes digitales Ersteinschätzungsinstrument, Mindestanforderungen für das Personal an der Ersteinschätzungsstelle sowie die sächliche und personelle Ausstattung der Notdienstpraxis fest. Zusätzlich legt der Gemeinsame Bundesausschuss auch Mindestanforderungen an die Auswahl der Standort von Integrierten Notfallzentren und Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche fest.

Die Richtlinie soll Vorgaben an ein standardisiertes digitales Ersteinschätzungsinstrument enthalten, das für Hilfesuchende einerseits die Dringlichkeit des Behandlungsbedarfs feststellen und andererseits eine Entscheidung, ob sie in der Notaufnahme oder in der Notdienstpraxis zu versorgen sind, generieren kann. Das System zur Ersteinschätzung muss validiert und patientensicher sein. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern, Menschen mit Behinderung und psychisch Erkrankten sind zu berücksichtigen. Die Vorgaben sind mit den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu einem gestuften System der Notfallversorgung in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)“ (Regelungen zu einem gestuften System der Notfallversorgung) abzustimmen. Die neu zu entwickelnden Vorgaben sind mit den bereits derzeit nach diesen Regelungen in den Notaufnahmen zur Anwendung kommenden Systemen zur Behandlungspriorisierung, wie zum Beispiel dem Manchester Triage System (MTS), in Einklang zu bringen. Diese Systeme sollen ein Bestandteil des neuen Ersteinschätzungsinstruments sein.

Die Richtlinie soll zudem Vorgaben zum Nachweis der Einhaltung der Vorgaben an ein standardisiertes digitales Ersteinschätzungsinstrument umfassen. Es soll bestimmt werden, wie und durch welche Stellen die Konformität mit den Anforderungen nach Satz 1 Nummer 1 festgestellt wird.

Ebenfalls festzulegen sind Vorgaben zur Form und zum Inhalt des Nachweises der Verwendung des Ersteinschätzungsinstruments für die Abrechnung der Einzelleistung nach Absatz 4 Satz 1 und ein Zeitpunkt, ab dem nach Absatz 2 Satz 3 die Ersteinschätzungsstellen die Ersteinschätzung mit einem entsprechenden, den Anforderungen nach Nummer 1 genügenden Ersteinschätzungsinstrument durchführen müssen. Der Zeitpunkt hängt davon ab, ob zumindest ein Instrument, welches die Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses nach Satz 1 Nummer 1 erfüllt, tatsächlich auf dem Markt zur Verfügung steht und ein Nachweis der Konformität nach Satz 1 Nummer 2 erbracht wurde. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat diese Vorgabe regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls den festgelegten Zeitpunkt anzupassen. Ab diesem Zeitpunkt ist der Nachweis der Verwendung des Ersteinschätzungssystems Voraussetzung für die Vergütung der Ersteinschätzung nach Absatz 4 Satz 1. Diese Regelung soll eine bundeseinheitliche Nutzung und gleichmäßige Einführung der beschriebenen Ersteinschätzungssysteme sicherstellen.

Der bisherige Auftrag an den Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 120 Absatz 3b wird so an die neuen gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen angepasst und inhaltlich auf die Steuerung zwischen Notaufnahme und Notdienstpraxis unter Berücksichtigung einer möglichen Kooperationspraxis beschränkt. Dennoch können wesentliche Vorarbeiten des Gemeinsamen Bundesausschusses hinsichtlich der Richtlinie zur Ersteinschätzung des Versorgungsbedarfs in der Notfallversorgung (Beschluss über eine Erstfassung vom 6. Juli 2023) mit in die Richtlinie einfließen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt in der Richtlinie außerdem Mindestanforderungen an die sächliche und personelle Ausstattung der Notdienstpraxen in Integrierten Notfallzentren. Die Mindestanforderungen sollen sich an der üblichen personellen und sachlichen Ausstattung einer Hausarztpraxis orientieren und sollen dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Festlegungen zur einheitlichen Ausstattung der Notdienstpraxen sind erforderlich für die Bewertung, welche Art und Schwere von medizinischen Hilfesuchen dort behandelt werden können. Zur Sicherstellung der Einhaltung der Mindestanforderungen nach Satz 1 Nummer 5 hat der Gemeinsame Bundesausschuss in seiner Richtlinie gemäß Satz 1 Nummer 6 auch ein aufwandsarmes Nachweis- und Kontrollverfahren zu bestimmen.

Die Länder erhalten ein Antrags- und Mitberatungsrecht entsprechend § 92 Absatz 7e. Vor der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Richtlinie ist den einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die abgegebenen Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. Damit kann auch die Expertise der jeweils einschlägigen wissenschaftlichen Fachgesellschaften in die Entscheidungsfindung des Gemeinsamen Bundesausschusses einfließen.

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die Auswirkungen der Richtlinie nach Satz 1 hinsichtlich der Entwicklung der Inanspruchnahme der Notaufnahmen und der Notdienstpraxen, der Auswirkungen auf die Patientenversorgung sowie die Erforderlichkeit einer Anpassung seiner Regelungen bis zum 31. Dezember 2026 zu prüfen und dem Bundesministerium für Gesundheit spätestens zu diesem Zeitpunkt hierzu zu berichten. Das Nähere zur Umsetzung dieses Evaluations- und Berichtsauftrags, insbesondere auch zur Übermittlung der hierzu erforderlichen Informationen an den G-BA durch die jeweiligen Stellen, regelt der G-BA nach Satz 1 Nummer 7 in seiner Richtlinie.

Zu Absatz 4

Der ergänzte Bewertungsausschuss in seiner Zusammensetzung nach § 87 Absatz 5a beschließt innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Frist die notwendigen Anpassungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs für ärztliche Leistungen. Ziel ist es, den personellen und technischen Aufwand durch eine Ersteinschätzung nach Absatz 2 Satz 1 angemessen abzubilden und als Einzelleistung unabhängig von der Weiterbehandlung zu vergüten. Er hat außerdem die Entwicklung der Leistungen in Integrierten Notfallzentren zu evaluieren und hierüber dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 31. Dezember 2027 zu berichten. Zur Umsetzung des Evaluationsauftrags ist eine Kennzeichnung der Leistungen nach dem Erbringungsort erforderlich. Daher müssen die entsprechenden Abrechnungsdaten mit einer Kennzeichnung versehen werden. Der Bewertungsausschuss und der erweiterte Bewertungsausschuss werden daher beauftragt, die notwendigen Fallkennzeichnungen zu beschließen. Zur Umsetzung des Evaluationsauftrags ist eine Kennzeichnung der Leistungen nach Erbringungsort (Notaufnahme, Notdienstpraxis) erforderlich. Da die eindeutige Zuordnung mit derzeitigen Abrechnungsdaten nicht möglich ist, wird der ergänzte Bewertungsausschuss ergänzend mit einer Vorgabe zur Kennzeichnung der Fälle nach Erbringungsort beauftragt.

Zu Absatz 5

Zur bedarfsgerechten Versorgung von Patientinnen und Patienten bei Hinweisen auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung ist eine psychiatrische und psychosomatische Behandlungskompetenz vor Ort oder über telemedizinische oder telefonische Konsile sicherzustellen. Die Vorgaben gemäß Absatz 6 gelten entsprechend.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt die telemedizinische Anbindung von Integrierten Notfallzentren an Fachärztinnen und -ärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Integrierte Notfallzentren haben dafür zu sorgen, dass sie durch telemedizinische und telefonische Konsilien von Fachärztinnen und -ärzten für Kinder- und Jugendmedizin unterstützt werden, wenn an ihrem Standort kein Integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche vorhanden ist. Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a kann Empfehlungen für eine landesweite Konzeption und Koordinierung dieser telemedizinischen Unterstützung aussprechen. Dies kann durch Nutzung des telemedizinischen kinder- und jugendärztlichen Notdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung, durch Kooperationen mit Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche oder mit anderen Leistungserbringern mit kinder- und jugendmedizinischem Schwerpunkt erfolgen, etwa durch eine digitale Vernetzung zu einem virtuellen Integrierten Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche. Die zu unterstützenden Integrierten Notfallzentren haben die erforderliche technische Ausstattung für eine telemedizinische Anbindung vorzuhalten. Die Vorgaben der Vereinbarung nach § 367 Absatz 1 sind dabei einzuhalten.

Zu Absatz 7

Absatz 7 regelt die Berichtspflichten zur Versorgung in den Integrierten Notfallzentren. Die Kassenärztlichen Vereinigungen berichten den zuständigen obersten Landesbehörden jährlich über die Versorgung in den Integrierten Notfallzentren in Hinblick auf Abweichungen von den gesetzlichen Öffnungszeiten der Notdienstpraxis, auf die Anzahl der eingerichteten Kooperationspraxen und der eingerichteten Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche und auf die Anteile der Inanspruchnahme des Integrierten Notfallzentrums mit und ohne vorherigen Kontakt zur Akutleitstelle. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich.

Zu Absatz 8

Mit der Neuregelung wird sichergestellt, dass alle Krankenhäuser mit Notaufnahme ein bundeseinheitliches Ersteinschätzungsinstrument zur Steuerung von Patientinnen und Patienten einsetzen. Ziel ist es, eine gleichwertige

Qualität der Ersteinschätzung bundesweit zu gewährleisten und die Patientinnen und Patienten frühzeitig und bedarfsgerecht in die geeignete Versorgungsebene zu steuern. Eine Regelung, die die Nutzung des Ersteinschätzungsinstrumentes nur für Krankenhäuser mit Integriertem Notfallzentrum (INZ) vorsieht, würde zu einer fragmentierten Versorgungslandschaft führen. Dies birgt die Gefahr, dass Versicherte bei gleichen Beschwerden je nach Struktur des aufgesuchten Krankenhauses unterschiedlich beurteilt und behandelt werden.

Die Steuerung in die bedarfsgerechte Versorgung über die Ersteinschätzungsstelle ist ein Kernelement der Notfallreform. Um einheitliche Qualität sicherzustellen, soll die Kassenärztliche Bundesvereinigung verpflichtet werden, ein einheitliches Ersteinschätzungsinstrument bereitzustellen. Auf diese Weise wird vermieden, dass unterschiedliche Systeme nebeneinander bestehen und damit die Transparenz sowie die Vergleichbarkeit der Steuerungsentscheidungen eingeschränkt werden.

Die Vergütung ambulanter Notfallbehandlungen nach § 76 Absatz 1 Satz 2 wird an die Nutzung des Ersteinschätzungsinstrumentes gebunden. Damit wird gewährleistet, dass die Nutzung des Systems verpflichtend erfolgt und Abweichungen von den vorgesehenen Steuerungswegen konsequent sanktioniert werden. Sofern eine Ersteinschätzung nicht erfolgt oder das Ergebnis nicht beachtet wird, reduziert sich die Vergütung um 50 Prozent. Die Regelung führt dazu, dass die Notaufnahmen entlastet, die Patientenströme wirksam gesteuert und bundesweit gleiche Versorgungsstandards sichergestellt werden. Zugleich wird die Steuerungsqualität durch ein einheitliches digitales System verbessert, wodurch die Verlässlichkeit der Ersteinschätzung steigt und die Versorgung effizienter gestaltet werden kann.

Zu Absatz 9

Die Verpflichtung zur Meldung standardisierter Notfalldaten an das AKTIN-Notaufnahmeregister schafft eine verlässliche, wissenschaftlich fundierte Datengrundlage für die Weiterentwicklung der Notfallversorgung. Durch die Anbindung aller Krankenhäuser mit Notaufnahme wird eine bundesweit einheitliche und umfassende Dokumentation gewährleistet, die sowohl Versorgungsforschung als auch Qualitätssicherung stärkt.

Das AKTIN-Notaufnahmeregister ist als kooperatives Forschungs- und Datenprojekt bereits erprobt und technisch in der Lage, strukturierte Routinedaten zu erfassen und für wissenschaftliche und versorgungssteuernde Zwecke verfügbar zu machen. Mit der neuen Meldeverpflichtung wird die bislang freiwillige Beteiligung in eine verbindliche Pflicht überführt, sodass ein vollständiges Bild der Versorgung in deutschen Notaufnahmen entsteht. Dies ermöglicht, regionale Unterschiede und Versorgungsengpässe frühzeitig zu erkennen und evidenzbasierte Entscheidungen für die Weiterentwicklung der Notfallversorgung zu treffen.

Die Regelung trägt damit entscheidend zur Verbesserung von Transparenz, Patientensicherheit und Versorgungsqualität bei. Gleichzeitig wird durch die Nutzung eines bestehenden Registers ein effizientes Verfahren gewählt, das auf erprobten Strukturen aufbaut und die Belastung der Krankenhäuser durch Mehrfachmeldungen reduziert.

Zu Nummer 19

Zu § 123a

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Bestimmung der Standorte für Integrierte Notfallzentren. Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a legt die Standorte von Integrierten Notfallzentren erstmals innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes im Einvernehmen mit den obersten Landesplanungsbehörden fest. Die Planung soll eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte flächendeckende Versorgung mit gleichmäßigem Zugang der Bevölkerung zu Integrierten Notfallzentren als zentrale Anlaufstelle der Notfallversorgung an dafür geeigneten Standorten sicherstellen. Die Standortfestlegung unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung; bei veränderten Tatsachen, wie etwa dem Wegfall von Voraussetzungen für die Einrichtung eines Integrierten Notfallzentrums, kann eine neue Standortfestlegung erforderlich sein. Der erweiterte Landesausschuss bestimmt hierzu zunächst Planungsregionen zur flächendeckenden Versorgung mit Integrierten Notfallzentren. Damit nur solche Krankenhausstandorte festgelegt werden können, die über die erforderliche personelle und sachliche Ausstattung für die Erbringung einer stationären Notfallversorgung verfügen, soll ein Krankenhausstandort mindestens die Anforderungen der Notfallstufe 1 Basisnotfallversorgung nach den Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen des Gemeinsamen Bundesausschusses erfüllen. Die Mindestanforderungen an die Standorte zur Einrichtung von Integrierten Notfallzentren nach § 123 Absatz 3 Nummer 6 sind einzuhalten. Ein weiteres Kriterium ist, dass kein überwiegendes berechtigtes Interesse des Krankenhauses entgegensteht. Dabei ist das Interesse

an einer flächendeckenden Versorgung durch Integrierte Notfallzentren gegen das berechtigte Interesse des Krankenhauses abzuwägen. Als berechtigte Interessen in Betracht kommen beispielsweise geplante Schließungen des Krankenhausstandortes oder anstehende Strukturveränderungen in der Notfallversorgung, sodass der Standort die weiteren Standortkriterien nicht mehr erfüllen könnte. Dies gilt auch, wenn das Krankenhaus nachweist, dass es die mit der Bestimmung als Standort eines Integrierten Notfallzentrums verbundenen neuen Aufgaben personell oder finanziell nicht erfüllen kann.

Die Bundeswehrkrankenhäuser sind vom erweiterten Landesausschuss bei der Festlegung der Standorte der Integrierten Notfallzentren nach Satz 1 vorrangig zu berücksichtigen. Diese gesetzliche Festlegung trägt der besonderen Bedeutung der Bundeswehrkrankenhäuser Rechnung. Bundeswehrkrankenhäuser sind medizinische, stationäre Behandlungseinrichtungen der Bundeswehr mit dem besonderen Auftrag, die jederzeitige Abstellung von ärztlichem und nichtärztlichem medizinischen Fachpersonal für Einsätze der Bundeswehr – einschließlich der Landes- und Bündnisverteidigung – sicherzustellen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist es erforderlich, dass die Bundeswehrkrankenhäuser und die bei ihnen tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte ein möglichst breites Leistungsspektrum zur Vorbereitung auf den Einsatzfall der Bundeswehr erbringen. Dies schließt insbesondere die Einschätzung und Versorgung von Not- und Akutfällen ein. Indem der erweiterte Landesausschuss bei der Standortfestlegung die Bundeswehrkrankenhäuser vorrangig zu berücksichtigen hat, wird sein Ermessen dahingehend beschränkt. Dies steht im Einklang mit der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung für eine wirksame militärische Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland und damit für die Sicherung der staatlichen Existenz durch Streitkräfte, die organisatorisch so zu gestalten und personell so auszubilden und auszustatten sind, dass sie ihren militärischen Aufgaben im In- und Ausland gewachsen sind, Artikel 73 Nummer 1 des Grundgesetzes.

Der erweiterte Landesausschuss soll bei seiner Planung die gesetzlich festgelegten Kriterien berücksichtigen. Dabei ist insbesondere die Erreichbarkeit von Integrierten Notfallzentren zu berücksichtigen. Diese ist geprägt durch die Entfernung zu einem Standort und die benötigte Zeit zur Überbrückung dieser Entfernung. Gesetzlich sind daher Erreichbarkeitsvorgaben festgelegt wie zum Beispiel eine Fahrzeit von 30 Minuten mit einem Kraftfahrzeug sowie die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Auch die allgemeine verkehrstechnische Anbindung, zum Beispiel die Parkplatzsituation, kann berücksichtigt werden. Neben der Fahrzeit mit einem Kraftfahrzeug wird auch der Zielerreichungsgrad angegeben, der angibt, für wie viel Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner im räumlichen Einzugsgebiet eines Integrierten Notfallzentrums eine längere Anfahrt als die generell vorgegebenen Fahrzeiten mit einem Kraftfahrzeug zumutbar ist. Auch die Zahl der zu versorgenden Menschen in der Planungsregion ist zu berücksichtigen. Dies kann dazu führen, dass eine gegenüber der Vorgabe nach Nummer 1 höhere Dichte an Integrierten Notfallzentren nötig ist. Zudem ist mit in die Berücksichtigung einzubeziehen, ob bereits geeignete Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Notaufnahme eines Krankenhausstandortes vorhanden sind, um bereits etablierte Versorgungsangebote möglichst zu erhalten und insoweit auch Ressourcen zu schonen. Bei der Auswahl der Standorte ist auch zu berücksichtigen, ob grundsätzlich die Möglichkeit besteht, das Integrierte Notfallzentrum mit einer Kooperationspraxis zu vernetzen.

Wenn nach diesen Kriterien in einer Planungsregion mehrere Krankenhausstandorte infrage kämen, sind solche als Standort für ein Integriertes Notfallzentrum zu bevorzugen,

1. die die höhere Notfallstufe nach den Regelungen zu einem gestuften System der Notfallversorgung oder die nach anderen messbaren Parametern, insbesondere Fallzahlen, leistungsfähigere Notaufnahme aufweisen,
2. die notfallmedizinisch relevante Fachabteilungen vorhalten; dies sind insbesondere Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie, Allgemeine Innere Medizin und Neurologie,
3. in denen Notdienstpraxen unmittelbar in der Notaufnahme eingerichtet werden können, da eine solche räumliche Nähe mehr Effizienz und verwaltungstechnische Synergien sowie Vorteile für die Patientensicherheit ermöglicht.

Der erweiterte Landesausschuss nach § 90 Absatz 4a kann in Hinblick auf die Sicherstellung der Versorgung von den Sätzen 3 bis 5 abweichende Standortentscheidungen treffen, wenn dies zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erforderlich ist, etwa, wenn nach den dort genannten Kriterien in einer Planungsregion aufgrund von regionalen Besonderheiten kein Krankenhaus in Betracht kommt. Dies ermöglicht in solchen Planungsregionen eine möglichst flexible Festlegung, damit im Ergebnis auch in strukturschwachen und ländlichen Gebie-

ten eine Notfallversorgung sichergestellt werden kann. Die Festlegung eines Standortes für ein Integriertes Notfallzentrum erfolgt durch Verwaltungsakt gegenüber dem betroffenen zugelassenen Krankenhaus. Gegen diese Entscheidung steht der Rechtsweg vor den Sozialgerichten offen. Widerspruch und Klage haben hierbei keine aufschiebende Wirkung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Kooperationsvereinbarung zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Krankenhausträger. Für die Organisation des Integrierten Notfallzentrums ist diese innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Krankenhausstandort als Standort eines Integrierten Notfallzentrums festgelegt worden ist, zu schließen.

Ein gemeinsames Organisationsgremium zur operativen Umsetzung der Zusammenarbeit und zur Realisierung eines gemeinsamen Qualitätsmanagements ist verbindlich einzurichten. Das gemeinsame Organisationsgremium im Integrierten Notfallzentrum kann beispielsweise das Nähere zur Umsetzung der Zusammenarbeit (regelmäßige Besprechungen) und die einzelnen Prozessabläufe festlegen sowie die Einhaltung der Kooperationsvereinbarung überwachen. Insbesondere soll das Gremium unter Berücksichtigung der Kooperationsvereinbarung Prozessabläufe für die Ersteinschätzung bestimmen. Das gemeinsame (sektorenübergreifende) Qualitätsmanagement umfasst dabei alle erforderlichen Maßnahmen zur Planung, Umsetzung, Sicherung, Überprüfung und Verbesserung von Prozessen sowie ihrer Leistungsbedingungen im Integrierten Notfallzentrum. Hierzu kann auch ein Beschwerdemanagement oder eine Patientenbefragung gehören. So kann das gemeinsame Qualitätsmanagement beispielsweise Symptome oder Diagnosen ersteingeschätzter Patientinnen und Patienten vergleichen, sodass die Ersteinschätzungsstelle eine Rückkopplung zur Qualität der Ersteinschätzung erhält. Damit können die Kooperationspartner sicherstellen, dass fehlerhafte Weiterleitungen in eine ungeeignete Versorgungsebene im Sinne der Patientensicherheit vermieden werden. Die für das gemeinsame Qualitätsmanagement erforderlichen Daten dürfen von den Kooperationspartnern zu diesem Zweck verarbeitet werden. Die Verpflichtungen zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung nach den §§ 135a ff. bleiben unberührt.

In der Kooperationsvereinbarung ist insbesondere das Nähere zu den folgenden Punkten zu regeln:

1. Es sind Vorgaben zu dem gemeinsamen Organisationsgremium festzulegen. Die Kooperationspartner können insbesondere eine gemeinsame Geschäftsordnung vereinbaren.
2. Regelungen zur Umsetzung der Vernetzung und interoperablen, digitalen Fallübergabe innerhalb des Integrierten Notfallzentrums sind vorzusehen.
3. Die Kooperationsvereinbarung muss Regelungen zur Durchführung der Ersteinschätzung vor dem in der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 123 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 festgelegten Zeitpunkt enthalten. Ab diesem Zeitpunkt muss die Ersteinschätzung durch ein standardisiertes digitales Ersteinschätzungsinstrument erfolgen. In dem Zeitraum davor kann die Ersteinschätzung anderweitig erfolgen. In der Kooperationsvereinbarung ist zu bestimmen, wie eine Entscheidung zu treffen ist, in welche Versorgungsebene die Hilfesuchenden gesteuert werden und welche Dringlichkeit ihr Anliegen hat.
4. Vereinbarungen zur Organisation sowie zur personellen Besetzung der Ersteinschätzungsstelle einschließlich der erforderlichen Schulungen und regelmäßigen Fortbildungen des Personals sind zu schließen. Die personelle Besetzung der Ersteinschätzungsstelle wird von den Kooperationspartnern festgelegt. Sie bestimmen eine ausreichende Qualifikation des Personals und regeln, welche Schulungen und regelmäßigen Fortbildungen erforderlich sind. Die Vorgaben der Richtlinie nach § 123 Absatz 3 Nummer 5 sind einzuhalten.
5. Auch die Anmietung oder Bereitstellung von Räumlichkeiten, Einrichtung und Verbrauchsmaterial der Notdienstpraxis sind zu regeln. Dies umfasst insbesondere die Vereinbarung der Höhe der Miete, der Nutzungsentgelte oder der Entgelte.
6. Ebenso ist die Nutzung der technischen und diagnostischen Einrichtungen des Krankenhauses durch die Notdienstpraxis im Rahmen der notdienstlichen Akutversorgung, einschließlich der entsprechenden Nutzungsentgelte, Gegenstand der Kooperationsvereinbarung.
7. Es sind Regelungen zu vereinbaren für den Fall, dass einer der beiden Kooperationspartner wiederholt und schwerwiegend gegen Inhalt der Kooperationsvereinbarung verstößt, und für den Fall, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Notdienstpraxis nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Öffnungszeiten nach Satz 5

oder zu den vereinbarten Zeiten nach Satz 6 betreibt. Dies können etwa Ausgleichszahlungen, Vertragsstrafen oder andere Sanktionen sein.

In der Kooperationsvereinbarung ist sicherzustellen, dass bei der Finanzierung durch die Länder das EU-Beihilfenrecht berücksichtigt wird.

Für die Notdienstpraxis werden Mindestöffnungszeiten vorgegeben. Diese sind mindestens täglich von 10 bis 22 Uhr. Kürzere Öffnungszeiten können in der Kooperationsvereinbarung festgelegt werden, soweit belegbar ist, dass die vorgegebenen Öffnungszeiten aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme vor Ort nicht bedarfsgerecht sind.

Vertragliche Regelungen zu den vorgesehenen Inhalten der Kooperationsvereinbarung können auch bereits als Rahmenvertrag in dreiseitigen Verträgen nach § 115 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 landesweit vorgegeben werden. Dies führt zu einer weiteren Vereinheitlichung in dem jeweiligen Land.

Zur Sicherstellung eines effektiven Informationsaustausches zwischen den eingesetzten informationstechnischen Systemen innerhalb des Integrierten Notfallzentrums muss die Schnittstelle für die digitale Fallübergabe nach Satz 4 Nummer 2 interoperabel ausgestaltet sein. Zu diesem Zweck soll die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Einvernehmen mit dem Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen die technische Spezifikation der Schnittstelle zur Einbindung der digitalen Fallübergabe erstellen. Hierdurch soll eine einheitliche technische Umsetzung der Schnittstelle ermöglicht werden; dies stellt technisch den reibungslosen Austausch der Inhalte der digitalen Fallübergabe sicher.

Die rechtsverbindliche Festlegung der so erstellten Spezifikation findet im Rahmen des IOP-Regelprozesses gemäß § 385 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 durch das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen der Rechtsverordnung nach § 385 Absatz 1 Satz 1 statt. Dies stellt sicher, dass die Spezifikation widerspruchsfrei zu weiteren Spezifikationen für IT-Systeme im Gesundheitswesen erstellt wird und erleichtert insgesamt auch die sektorübergreifende Kommunikation von Informationen.

Zu § 123b

§ 123b regelt Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Standortbestimmung für Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche. Der erweiterte Landesausschuss kann nach § 90 Absatz 4a die Krankenhausstandorte im Einvernehmen mit den obersten Landesplanungsbehörden bestimmen, an denen diese eingerichtet werden. Voraussetzung ist, dass es sich um Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin oder Krankenhäuser mit einer pädiatrischen Abteilung handelt, welche die Voraussetzungen des Moduls Notfallversorgung Kinder gemäß den Regelungen zur Notfallversorgung des Gemeinsamen Bundesausschusses erfüllen, und, dass keine berechtigten Interessen des Krankenhauses oder der Kassenärztlichen Vereinigung entgegenstehen, die das Interesse an einer flächendeckenden Versorgung mit Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche überwiegen. Seitens der Kassenärztlichen Vereinigung kann ein berechtigtes Interesse insbesondere darin bestehen, dass die regional unterschiedlich verteilten und teilweise begrenzten Kapazitäten von Fachärztinnen und Fachärzten für Kinder und Jugendmedizin für einen Betrieb eines Notfallzentrums für Kinder und Jugendliche zusätzlich zu der ambulanten Versorgung in den Arztpraxen nicht ausreichend vorhanden sein können. Die zusätzliche Beanspruchung der Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte durch den Einsatz in Notfallzentren für Kinder und Jugendliche muss für die regional verfügbare Fachärzteschaft zumutbar sein und darf deren Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. Die Versorgung in den Vertragsarztpraxen muss gewahrt bleiben. Diese Kriterien sind bei der Entscheidung, ob ein Integriertes Notfallzentrum für Kinder und Jugendliche eingerichtet wird oder eine telemedizinische Anbindung nach § 123 Absatz 6 ausreicht, zu beachten. Die Mindestanforderungen an die Standorte zur Einrichtung von Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche gemäß § 123 Absatz 3 Nummer 5 sind einzuhalten.

Es wird eine gesetzliche Frist für die erstmalige Entscheidung festgelegt.

Zu Absatz 2

Die übrigen Regelungen für die Integrierten Notfallzentren nach § 123 Absatz 1 bis 5 und 7 sowie § 123a Absatz 1 Satz 7 bis 9 sowie Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. Dies umfasst alle Regelungen außer jenen zur telemedizi-

nischen Unterstützung von Integrierten Notfallzentren durch Kinderärztinnen und Kinderärzte und zur Standortbestimmung, die für Integrierte Notfallzentren für Kinder und Jugendliche in Absatz 1 gesondert normiert ist.

Zu Nummer 20 (§ 133)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Fassung. Sie wird als Folgeänderung an die Aufnahme der medizinischen Notfallrettung als eigenständigen Leistungsbereich und der Etablierung von Empfehlungen des Qualitätsausschuss Notfallrettung angepasst. Ziele der Neueregungen sind zum einen eine erhöhte Transparenz der Kosten und zu anderen eine höhere Qualität der medizinischen Leistungen im Rettungsdienst für Versicherte.

Zu Absatz 1

Absatz 1 stellt klar, dass die Leistungserbringer nach § 30 die nach Landesrecht bestimmten Träger oder mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben nach Landesrecht beauftragten Einrichtungen oder Unternehmen sind. Damit wird zudem berücksichtigt, dass die generelle (Bedarfs-)Planung des Rettungsdienstes den Ländern obliegen bleibt. Der durch die Länder zugewiesene Aufgabenbereich der Rettungsdienste, beispielsweise auch für den Katastrophen- oder Bevölkerungsschutz, welcher über Leistungen der medizinischen Notfallrettung für Versicherte hinausgeht, bleibt unberührt. Der Rettungsdienst bleibt also im bisherigen Umfang sachlich von der vergaberechtlichen Bereichsausnahme nach § 107 Absatz 1 Nummer 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erfasst.

Zu Absatz 2

Die Abkehr von der bloßen Übernahme von Fahrtkosten für Versicherte und die damit verbundene Aufteilung in Notfallmanagement mit oder ohne Gesundheitsleitsystem, Notfallrettung vor Ort (beispielsweise durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter oder aber auch durch Ärztinnen und Ärzte vor Ort beziehungsweise telemedizinisch), Notfalltransport (abhängig vom Transportmittel) oder Krankentransport und spezielle ambulante Notfallversorgung bedingt, dass zukünftig Verträge differenziert nach diesen einzelnen Leistungen abzuschließen sind. Auch etwaige landesrechtliche oder kommunalrechtliche Bestimmungen müssen für eine Kostenübernahme zukünftig in ihren Entgeltatbeständen entsprechend differenzieren.

Um mehr Transparenz über die Vergütung der medizinischen Notfallrettung zu erreichen, müssen den Krankenkassen oder ihren Landesverbänden vor Vertragsschluss die der Kalkulation der einzelnen Leistungen zu Grunde liegenden Daten transparent vorliegen. Zusätzlich stehen ihnen zukünftig Qualitäts- und Leistungsdaten nach § 133e Absatz 2 zur Verfügung. Sie haben bei Vertragsschluss die Empfehlungen des Qualitätsausschuss Notfallrettung nach § 133c Absatz 1 Nummer 1 zu berücksichtigen. Zwar handelt es sich bei den Beschlüssen des Ausschusses nach § 133c Absatz 1 Nummer 1 bloß um Empfehlungen, dennoch können diese insbesondere Indizwirkung für eine qualitative und gleichzeitig wirtschaftliche Leistung entfalten, sodass sie zumindest initial herangezogen werden müssen. Das Nähere zum Verfahren der Berücksichtigung dieser Empfehlungen kann nach Absatz 5 der Spitzenverband Bund der Krankenkassen regeln. Hervorzuheben ist, dass die Anforderungen für Rettungsleitstellen, die Teil eines Gesundheitsleitsystems nach § 133a sind, finanziell beachtet und somit besondere Anreize bestehen müssen, sich entsprechend zu vernetzen. Ziel sollte es sein, dass das Notfallmanagement für Versicherte nur noch durch Gesundheitsleitsysteme stattfindet.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt zunächst klar, dass, wenn die Entgelte für die Inanspruchnahme von den einzelnen Leistungen der medizinischen Notfallrettung und von Krankentransporten durch landesrechtliche oder kommunalrechtliche Bestimmungen festgelegt oder aufgrund landesrechtlicher Regelungen ermittelt werden, die Versicherten einen Anspruch auf Übernahme der Kosten haben. Versicherte haben stets einen unmittelbaren Anspruch; die Festlegung der Entgelte wirkt sich nur auf die Vergütungsebene zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern aus.

Damit jedoch auch hier die in Absatz 2 angelegten Transparenz- und Qualitätsmechanismen greifen, bleibt die gesetzliche Ermächtigung der Krankenkassen, ihre Leistungspflicht zur Übernahme der Kosten auf Festbeträge unterhalb derartiger öffentlich-rechtlicher Kostentarife beschränken, erhalten und wird nunmehr verbindlich für die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen vorgeschrieben. Diese setzen gemeinsam und einheitlich Festbeträge für ein Bundesland, eine Kommune oder einen administrativen Rettungsdienstbereich fest.

Weitere inhaltliche Änderungen zur bestehenden Rechtslage ergeben sich hinsichtlich Satz 1 Nummer 1 und 3. Insoweit müssen nunmehr gemäß Nummer 1 zusätzlich zu einer bloßen Erörterung die Berechnungsgrundlagen

für den Entgelttatbestand, also die Kalkulation, wie vor einem Vertragsschluss nach Absatz 2 transparent dargelegt werden. Bei Nummer 3 müssen die Krankenkassen oder ihre Landesverbände Festbeträge festsetzen, wenn die dem Entgelttatbestand entsprechende tatsächliche Leistung des Leistungserbringers gemessen an den rechtlich vorgegebenen Sicherstellungsverpflichtungen unwirtschaftlich ist oder nicht dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht. Dabei können die Empfehlungen des Qualitätsausschuss Notfallrettung nach § 133c Absatz 1 Nummer 1 auch hier Indizwirkung entfalten. Das Nähere zum Verfahren bei der Festsetzung gemäß Nummer 3 regelt nach Absatz 5 der Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Hinsichtlich Nummer 2 handelt es sich um eine Folgeänderung zur Etablierung der medizinischen Notfallrettung.

Zu Absatz 4

Absatz 4 stellt klar, dass, wie bereits heute, auch zur Vergütungshöhe von Krankenfahrten Vertragsvereinbarungen stattfinden.

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht vor, dass im Landesrecht geregelt werden kann, dass Leistungserbringer unmittelbar mit den Krankenkassen abrechnen. Die Versicherten sind damit von Vorleistungen freigestellt. Damit wird bei entsprechender Regelung im Landesrecht die bisherige Praxis der unmittelbaren Abrechnung rechtlich abgesichert und eine finanzielle Vorleistungspflicht der Versicherten ausgeschlossen.

Zu Absatz 6

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt in einer Richtlinie das Nähere zum Verfahren und zur Umsetzung der Vertragsgestaltung und der Festbeträge. Diese Richtlinie kann die Krankenkassen insbesondere anleiten, wie bei der Vertragsgestaltung mit den Empfehlungen des Qualitätsausschuss Notfallrettung nach § 133c Absatz 1 Nummer 1 umzugehen ist. Der bisherige Verweis auf die Bildung von Rahmenempfehlungen entsprechend den Verträgen im Hilfsmittelbereich nach § 127 Absatz 9 wird nicht übernommen, da hiervon kein Gebrauch gemacht worden ist.

Zu Nummer 21

Zu § 133a

§ 133a regelt die Errichtung des Gesundheitsleitsystems durch die Vernetzung der Rettungsleitstellen unter der Notrufnummer 112 mit den Akutleitstellen unter der Rufnummer 116117.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Bildung von Gesundheitsleitsystemen durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen. Auf Antrag eines Trägers einer Rettungsleitstelle ist die zuständige Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet, mit diesem ein Gesundheitsleitsystem zu bilden. Aus kompetenzrechtlichen Gründen kann der Bundesgesetzgeber nur die Kassenärztlichen Vereinigungen zu einer Kooperation verpflichten. Um eine flächendeckende Einführung sicherzustellen, können die Länder in ihren Rettungsdienstgesetzen entsprechende landesweite Vorgaben machen. Aber auch einzelne Leitstellen können eine Kooperation im Rahmen eines Gesundheitsleitsystems eingehen. Voraussetzung für eine Kooperation ist allerdings, dass die Rettungsleitstelle über eine digitale standardisierte Notrufabfrage verfügt, da sonst eine abgestimmte und patientensichere Weiterleitung von Hilfesuchenden innerhalb des Gesundheitsleitsystems nicht möglich ist.

In einem Gesundheitsleitsystem arbeiten die Träger der Rettungsleitstellen mit der Notrufnummer 112 und die Kassenärztlichen Vereinigungen als Träger der Akutleitstelle zusammen. Das Gesundheitsleitsystem beschränkt sich auf die organisatorische und technische, insbesondere digitale Kooperation. Darüber hinaus können weitere Formen der Zusammenarbeit bis hin zur gemeinsamen Trägerschaft im Einvernehmen der Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung geregelt werden.

Das Gesundheitsleitsystem übernimmt nicht die weiteren Aufgaben der Kooperationspartner, insbesondere nicht die über die Sicherstellung der Leistungen des Rettungsdienstes hinausgehenden öffentlichen Aufgaben der Leitstellen mit der Notrufnummer 112. Bei Anrufen zu der Rufnummer 116117 handelt es sich nicht um eine Notrufverbindung im Sinne des § 164 Absatz 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes.

Zu Absatz 2

In einer Kooperationsvereinbarung sind die Einzelheiten der Zusammenarbeit festzulegen. Wesentliche Grundlage einer solchen Zusammenarbeit ist insbesondere ein gemeinsames und verbindliches Verständnis zur Einschätzung der Dringlichkeit und des Versorgungsbedarfs. In einer Kooperationsvereinbarung ist daher insbesondere die Abstimmung der von den Kooperationspartnern verwendeten Abfragesysteme zu regeln. Dabei sind die unterschiedlichen Abfragesysteme angemessen zu berücksichtigen und so aufeinander abzustimmen, dass es zu übereinstimmenden Bewertungen des Gesundheitszustandes kommt, damit im Ergebnis eine widerspruchsfreie und rechtssichere Überleitung von Hilfesuchenden gewährleistet ist. Das jeweils verwendete Abfragesystem muss dazu geeignet sein, sowohl lebensbedrohliche Zustände in weniger als einer Minute zu erkennen als auch Behandlungsanlässe mit geringer oder fehlender Dringlichkeit zu identifizieren. Die Einhaltung der Standards der Notrufabfrage müssen überprüfbar sein und einer kontinuierlichen Kontrolle unterliegen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen nutzen das System nach § 75 Absatz 1c Satz 3. Sie wirken darauf hin, dass die Abstimmungen der Abfragesysteme mit den Rettungsleitstellen möglichst einheitlich sind. Dabei sind die Anforderungen des Beschäftigtendatenschutzes zu beachten.

Darüber hinaus ist in der Kooperationsvereinbarung insbesondere der Umgang mit den Abfrageergebnissen zu vereinbaren, also die Entscheidung, welches Versorgungsangebot für ein bestimmtes Abfrageergebnis bedarfsgerecht und welche Rufnummer für die Disponierung dieses Versorgungsangebots zuständig ist. Die Reaktion auf das konkrete Hilfeersuchen erfolgt auf regionaler Ebene unter Berücksichtigung des dort vorhandenen Versorgungsangebotes. Hierzu und zur Zuständigkeit der Rufnummern für die Disponierung der jeweiligen Versorgung sind präzise Festlegungen in der Kooperationsvereinbarung zu treffen.

Es ist eine Verpflichtung zur Übernahme und unverzüglichen Bearbeitung von Fällen vorzusehen, die aufgrund des Ergebnisses des jeweiligen Abfragesystems und der erfolgten Festlegungen der Zuständigkeiten an die jeweils andere Leitstelle übergeben werden. Eine Rücküberweisung ist grundsätzlich nur aufgrund eines veränderten Patientenzustandes oder weiterer medizinischer Erkenntnisse aufgrund einer vertieften Abfrage möglich.

Die Kooperationspartner sind technisch so zu vernetzen, dass eine unmittelbare telefonische Weiterleitung und eine medienbruchfreie Bearbeitung und Übertragung der zum jeweiligen Hilfeersuchen aufgenommenen Daten möglich sind. Um die technische Umsetzung einer sicheren Vernetzung und Kommunikation zu erleichtern und den Aufwand zu reduzieren, soll möglichst auf Dienste der Telematikinfrastruktur zurückgegriffen werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung stellt eine Schnittstelle zur digitalen Fallübergabe zur Verfügung, die auch die notwendigen Datensätze und -formate umfasst. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung erstellt die technische Spezifikation der für eine digitale Fallübergabe notwendigen Anforderungen für die eingesetzten informationstechnischen Systeme im Einvernehmen mit dem Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen. Die verbindliche Festlegung der Spezifikationen für das Gesundheitswesen erfolgt gemäß § 385 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 durch das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen der Rechtsverordnung nach § 385 Absatz 1 Satz 1.

Zu Absatz 3

Gemäß Absatz 3 vereinbaren die Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung ein gemeinsames Qualitätsmanagement, insbesondere dafür notwendige Strukturen (wie zum Beispiel ein Review-Gremium), für die ständige Evaluation der Abfragesysteme und der Überprüfung der Zuordnungen von Hilfesuchenden zur jeweiligen Versorgungsebene. Im Rahmen des Qualitätsmanagements sind auch geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der jeweiligen Abfragesysteme und der gemeinsamen Patientensteuerung zu treffen. Hierfür sind die einzelnen Prozessabläufe der Abfrage, insbesondere die Abfrage selbst, in den Leitstellen nachverfolgbar zu dokumentieren. Die entsprechenden Daten müssen im Sinne einer Feedbackschleife mit den Daten des jeweiligen disponierten Leistungserbringers, wie beispielsweise des Hausbesuchsdienstes, zusammengeführt und ausgewertet werden. So können beispielsweise Symptome oder Diagnosen verglichen werden und die Leitstelle erhält eine Rückkopplung zur Qualität der Abfrage. Damit soll sichergestellt werden, dass fehlerhafte Weiterleitungen in eine ungeeignete Versorgungsebene im Sinne der Patientensicherheit vermieden werden. Hierfür können auch entsprechende Fehlermeldesysteme etabliert werden, an die alle Beteiligten der Akut- und Notfallversorgung Vorfälle melden, bei denen der Verdacht einer Ersteinschätzungs- beziehungsweise Dispositionsfehlers besteht. Es wird klargestellt, dass der jeweils aufsuchende Leistungserbringer nur derjenigen Leitstelle die erforderlichen personenbezogenen Daten zurückmeldet, von der er disponiert wurde. Diese Leitstelle wertet die Daten dann aus

und analysiert sie gemeinsam mit dem Kooperationspartner. Die Kooperationspartner sind befugt, personenbezogene Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des gemeinsamen Qualitätsmanagements zu verarbeiten und sie wechselseitig auszutauschen. Dies umfasst auch die Aufzeichnungen der eingehenden Anrufe, die aufgrund von Einwilligungen oder auf der Grundlage von landesrechtlichen Befugnisnormen erhoben wurden, soweit die jeweilige Ermächtigungsgrundlage dies umfasst. Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten der Kooperationspartner verarbeitet werden, sind die Anforderungen des Beschäftigtendatenschutzes zu beachten.

Zu Absatz 4

Die Einfügung von Absatz 4 stellt klar, dass, je nach Absprache in der Kooperationsvereinbarung des Gesundheitsleitsystems, auch die Kassenärztlichen Vereinigungen Krankentransporte zu ambulanten Behandlungen vermitteln dürfen, soweit dies durch landesrechtliche Vorschriften ermöglicht wird.

Die Vorschrift gibt vor, dass beide Kooperationspartner im Gesundheitsleitsystem Leistungen der speziellen ambulanten Notfallversorgung (SANV) nach § 30 Absatz 4 Satz 2 sowie komplementäre Dienste für vulnerable Gruppen vermitteln sollen. Leistungen der speziellen ambulanten Notfallversorgung sind insbesondere notfallpflegerische und notfallpalliative Leistungen, psychische Notfallhilfen, vorbeugender Rettungsdienst sowie Leistungen einer fachgerechten Versorgung außerklinischer geburtshilflicher Notfälle. Komplementäre Dienste für vulnerable Gruppen sind alle geeigneten, regional vorhandenen Angebote unabhängig von der Trägerschaft, die Menschen in Not- oder Problemsituationen helfen. Dies kann etwa ein Dienst für wohnungslose Menschen sein, wie ein Kälte-Bus, ambulante Krisendienste, ein sozialpsychiatrischer oder ein psychosozialer Dienst. Durch die Aufforderung an das Gesundheitsleitsystem, diese komplementären Dienste zu vermitteln, kann auch Hilfesuchenden mit spezifischen Problemlagen passgenau geholfen werden. Das Repertoire der Leitstellen wird erweitert und auch Rettungsmittel können zielgerichteter eingesetzt werden. Die Vermittlung durch die Leitstelle hat keine Folge für die Finanzierung des komplementären Dienstes.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt Berichtspflichten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Zusammenarbeit in Gesundheitsleitsystemen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit jährlich über die Anzahl, den jeweiligen Stand und die wesentlichen Inhalte der Vereinbarungen zu den Gesundheitsleitsystemen einschließlich der Auswertung des gemeinsamen Qualitätsmanagements. Die Berichte sollen perspektivisch dazu beitragen, unter Einbindung der maßgeblichen Akteure bundeseinheitliche Standards zu entwickeln. Das Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht die Daten in einem geeigneten Format.

Zu § 133b

§ 133b regelt das Nähere zum Qualitätsausschuss Notfallrettung.

Zu Absatz 1

Absatz 1 beschreibt die Rechtsnatur, Organisationsstruktur und Aufgaben des Ausschusses. Er hat die Aufgabe, Empfehlungen nach § 133c zu erlassen und das Bundesministerium für Gesundheit in allen Fragen der medizinischen Notfallrettung zu beraten. Organisatorisch ist er dem Bundesministerium für Gesundheit untergeordnet und besitzt somit keine eigene Rechtsfähigkeit.

Zu Absatz 2

Absatz 2 umfasst Regelungen zur Zusammensetzung und Entscheidungsfindung. Der Ausschuss besteht aus 31 stimmberechtigten Mitgliedern und einer beziehungsweise einem unabhängigen Vorsitzenden. Der unabhängige Vorsitz wird mit einfacher Mehrheit durch die Vertreterinnen der Bundesländer und des Spitzenverband Bund der Krankenkassen bestimmt. Können sich die Mitglieder innerhalb der Frist nicht auf einen Vorsitz einigen, ernennt das Bundesministerium für Gesundheit einen kommissarischen Vorsitz für die Dauer von einem Jahr. Der Vorsitz leitet die Sitzungen, verfügt aber nicht über ein Stimmrecht. Von den 31 Mitgliedern werden 16 Mitglieder jeweils auf Vorschlag eines Bundeslandes und acht Mitglieder auf Vorschlag des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen vom Bundesministerium für Gesundheit ernannt. Die Mitglieder, die auf Vorschlag der Bundesländer und des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen ernannt wurden, können mit einfacher Mehrheit insgesamt sieben weitere Vertreter aus den Bereichen der Leistungserbringer des Rettungsdienstes, der maßgeblichen Fachgesellschaften und der maßgeblichen Berufsverbände im Rettungsdienst vorschlagen. Aus jedem Bereich muss mindestens ein Mitglied vorgeschlagen werden. Das Bundesministerium für Gesundheit hat die vorgeschlagenen Per-

sonen zu ernennen, wenn keine grundlegenden Bedenken gegen die Ernennung bestehen. Wird von dem Vorschlagsrecht kein Gebrauch gemacht, entscheidet das Bundesministerium für Gesundheit unverzüglich nach sachgerechtem Ermessen über die Ernennung der fehlenden Mitglieder. Die Mitglieder sind bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden. Die Amtszeit der Ausschussmitglieder beträgt fünf Jahre. Der Qualitätsausschuss Notfallrettung legt das Nähere zur Arbeitsweise, Besetzung und Beschlussfassung unverzüglich in einer Geschäftsordnung fest. Hierzu kann insbesondere auch die Gründung von spezialisierten und themenbezogenen Unterausschüssen gehören, in denen die Expertise sachverständiger Personen oder von Fachgesellschaften, Berufsverbänden und Leistungserbringern einbezogen werden kann. Wird die Geschäftsordnung nicht bis zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] beschlossen, legt das Bundesministerium für Gesundheit die Geschäftsordnung unverzüglich fest. Zur Koordinierung der Tätigkeit des Ausschusses richtet das Bundesministerium für Gesundheit eine Geschäftsstelle ein.

Zu Absatz 3

Damit der Ausschuss für die Erfüllung seiner Aufgaben über hinreichend Fachexpertise verfügt, kann er dem Bundesministerium für Gesundheit empfehlen, geeignete Dritte mit Unterstützungsleistungen zu beauftragen. Die Patientenorganisationen nach § 140f können beratend an seinen Sitzungen teilnehmen. Der Ausschuss soll sachverständige Personen zur Beratung hinzuziehen und vor Erlass der Empfehlungen geeignete Fachgesellschaften und Vertreter der maßgeblichen Berufsverbände und Leistungserbringer im Rettungsdienst anhören. Durch diese Mechanismen wird insgesamt eine wissenschaftlich aktuelle, fundierte und evidenzbasierte Entscheidungsfindung ermöglicht.

Zu § 133c

Aus § 133 ergibt sich, dass die Krankenkassen bei dem Abschluss ihrer Vergütungsverträge oder bei der Festsetzung von Festbeträgen die Empfehlungen des Qualitätsausschusses Notfallrettung zu berücksichtigen haben. Zu diesem Zweck sieht diese neue Vorschrift vor, dass der Qualitätsausschuss Notfallrettung Empfehlungen in Form eines Katalogs von Struktur- und Prozessqualitätsparametern für das Notfallmanagement, die medizinische Notfallrettung sowie für Krankentransporte und Krankentransportflüge erstellt und diese fortschreibt. Der Ausschuss beschließt außerdem Spezifikationen für interoperable Datensätze und informationstechnische Vorgaben für eine strukturierte, einheitliche und digitale Dokumentation und Kommunikation nach § 133d sowie Empfehlungen für die Übermittlung der Daten der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung nach § 133e. Zweck der Regelung ist eine leitliniengerechte, qualitativ hochwertige, für Patienten sichere und gleichzeitig wirtschaftliche medizinischen Versorgung.

Zu Absatz 1

Absatz 1 umschreibt die grundsätzliche Ausgestaltung des Katalogs.

Zu Satz 2

Zu Nummer 1

Der Katalog von Struktur- und Prozessqualitätsparametern beinhaltet zunächst den Umfang und Ausgestaltung der jeweiligen Qualitätsparameter. Das bedeutet, er definiert insbesondere zunächst die nach den Absätzen 2 und 3 genannten Qualitätskriterien. Qualitätskriterien für die Bewertung der Qualität der Leistungserbringung bei einzelnen Versorgungsaspekten sind solche Eigenschaften, deren Erfüllung typischerweise bei einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung erwartet wird.

Zu Nummer 2

Darüber hinaus verfasst er Indikatoren dafür, ob und wie entsprechende Qualitätskriterien eingehalten werden. Qualitätsindikatoren sind Maße, deren Ausprägung eine Unterscheidung zwischen guter und schlechter Qualität von Strukturen, Prozessen und/oder Ergebnissen der Versorgung ermöglichen sollen. Sie sind Hilfsgrößen, welche die Qualität einer Einheit durch Zahlen beziehungsweise Zahlenverhältnisse indirekt abbilden. Zusätzlich soll der Ausschuss definieren, welche Grade der Übereinstimmung mit diesen Anforderungen bestehen können. So werden auch Mindestanforderungen definiert.

Zu Nummer 4

Der Ausschuss soll außerdem Abweichungsmöglichkeiten vorsehen, also in welchen Fällen gegebenenfalls von einer Qualitätsempfehlung abgewichen werden kann ohne, dass beispielsweise eine geringere Vergütung empfohlen wird.

Zu Nummer 5

Schließlich kann er verschiedene Zeitpunkte empfehlen, ab wann die Vorgaben erfüllt und evaluiert werden sollten.

Zu Absatz 2

Absatz 2 beinhaltet einen beispielhaften Katalog von Inhalten, die der Ausschuss hinsichtlich des Notfallmanagements vorgeben soll.

Zu Nummer 1

Der Katalog soll Aussagen über die Qualifikation des Personals, also beispielsweise der Disponentinnen und Disponenten, zur generellen Ausstattung und zu Art und Maß der Besetzung von Leitstellen und sonstigem Bereitschaftspersonal treffen. Dies umfasst auch Empfehlungen hinsichtlich des Einsatzes von Telenotärztinnen oder Telenotärzten zur Unterstützung oder Sicherstellung einer fachgerechten Patientinnen- und Patientenversorgung.

Zu Nummer 2

Der Ausschuss soll Empfehlungen zur automatisierten und standardisierten Ortung von Notrufenden erlassen. Durch automatisierte und standardisierte Ortungen von Notrufenden können Leitstellen Einsatzmittel schneller und bedarfsgerechter disponieren.

Zu Nummer 3

Dies gilt auch hinsichtlich der Nutzung von protokollgestützten, qualitätsgesicherten, standardisierten softwaregestützten Abfragesystemen. Damit kann auch sichergestellt werden, dass die Voraussetzungen für die Errichtung eines Gesundheitsleitsystem nach § 133a seitens der Leitstellen vorliegen. Zusätzlich sind mit dem Ziel der Vermittlung einfacher Maßnahmen, die ohne formale Ausbildung eigenständig durchgeführt werden können, Empfehlungen für die durch die Leitstellen zu erteilenden standardisierten und qualitätsgesicherten Erste-Hilfe-Anweisungen zu treffen.

Zu Nummer 4

Gesetzlich intendiert sind auch Empfehlungen hinsichtlich Maßnahmen zur Förderung der Laienreanimation und der Ersten Hilfe durch Laien in anderen zeitkritischen lebensbedrohlichen Situationen (wie beispielsweise die Stillung von starken Blutungen, Unterstützung der Anwendung von der Patientin oder dem Patienten mitgeführten Auto-Injektoren bei schweren Allergien oder auch die Unterstützung einer Geburt) sowie der Einbindung registrierter Ersthelfer über mobile Alarmierungs-Applikationen und öffentlich zugänglicher automatisierter externer Defibrillatoren; dies umfasst auch die telefonische Anleitung Anrufender. So hat die Praxis gezeigt, dass diesbezüglich teilweise erhebliche Defizite vorliegen und durch entsprechende Maßnahmen Leben gerettet werden können.

Zu Nummer 5

Der Ausschuss soll darüber hinaus nach medizinischer Indikation und disponiertem Einsatzmittel differenzierte Empfehlungen zu Hilfsfristen beziehungsweise Planungsfristen sowie Maßnahmen zur Optimierung des jeweiligen Zielerreichungsgrades beschließen. Hinsichtlich des Notfallmanagements ist dabei entscheidend, dass rechtzeitig ein bedarfsgerechtes Einsatzmittel disponiert wird.

Zu Nummer 6

Im Zusammenhang damit steht auch die Auswahl von bedarfsgerechten Einsatzmitteln (Disposition) und Maßnahmen zur automatischen Disposition anhand des Einsatzmittelstandorts. Damit sollen die Empfehlungen auch beinhalten, welches Einsatzmittel im Einzelfall bedarfsgerecht und wirtschaftlich ist und der Ausschuss soll Maßnahmen zur GPS-gestützten Ortung von Einsatzmitteln empfehlen. Durch eine genaue Standortermittlung können Leitstellen entsprechende Einsatzmittel noch schneller und bedarfsgerechter disponieren.

Zu Nummer 7

Zusätzlich sind Empfehlungen zur Nutzung standardisierter und vernetzter Einsatzleitsysteme (Leitstellensoftware) vorgesehen. Diese Software sollte eine landkreis- und länderübergreifende Alarmierung von Einsatzmitteln ermöglichen. Vorgesehen sind auch die Bereitstellung und Honorierung entsprechender technischer und organisatorischer Schnittstellen. Dies kann beispielsweise der Bildung von Redundanzen sowie der Vernetzung zum Gesundheitsleitsystem nach § 133a dienen.

Zu Nummer 8

In diesem Zusammenhang stehen auch Empfehlungen des Einsatzes von digitalen Lösungen zur Patientensteuerung, zur Patientenzuweisung und zur Patientenvoranmeldung mithilfe eines integrierten softwaregestützten Behandlungskapazitäten-Nachweises in geeignete Versorgungseinrichtungen. Ziel ist ein schneller und integrierter Austausch zwischen den Krankenhäusern, den Leitstellen für den Rettungsdienst, den Gesundheitsbehörden und anderen medizinischen Diensten, wie dem Ärztlichen Notdienst, der Kassenärztlichen Vereinigung oder niedergelassenen Ärzten.

Zu Nummer 9

Ein besonderes Qualitätsmerkmal für das Notfallmanagement sollte die Anbindung und Koordination von spezialisierten Formen der ambulanten Notfallversorgung oder weiteren ambulanten Versorgungsformen und Maßnahmen des vorbeugenden Rettungsdienstes sein. Durch entsprechende Maßnahmen können nicht bedarfsgerechte Einsätze durch kostenintensive Rettungswagen oder Krankenhausaufnahmen vermieden werden. Dies können beispielsweise Organisationseinheiten sein, die sich im Rahmen eines Case-Managements um Personen kümmern, die besonders häufig die Notfallrettung alarmieren und dafür sorgen, dass für diese die richtige Versorgungsebene gefunden wird. Entsprechend ist dies nunmehr auch ausdrücklich in § 133a Absatz 4 aufgenommen.

Zu Nummer 10

Außerdem sind Empfehlungen zur Nutzung digitaler Instrumente zur Weitergabe von Fall- und Einsatzdaten zwischen den am Notfallmanagement beteiligten Akteuren, den Leistungserbringern im Rettungsdienst und den weiterführenden Versorgungseinrichtungen vorgesehen, um eine medienbruchfreie und sektorenübergreifende Datenübermittlung sicherzustellen.

Zu Absatz 3

Auch Absatz 3 beinhaltet einen beispielhaften Katalog von Empfehlungsinhalten. Es sind Empfehlungen hinsichtlich der medizinischen Notfallrettung, wozu auch die medizinische Berg- und Wasserrettung zählen kann, zu beschließen.

Zu Nummer 1

Der Katalog soll zunächst Aussagen über die Qualifikation (auch zu Fortbildungen und Rezertifizierungen) des Personals, also beispielsweise der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter, der Notärztinnen und Notärzte sowie der ärztlichen Leitung Rettungsdienst, zur generellen Ausstattung (beispielsweise einheitliche Ausstattungs- und Qualitätsstandards für boden- und luftgebundene Rettungsmittel) und zu Art und Maß der Besetzung von Rettungsmitteln und sonstigem Bereitschaftspersonal treffen. Dies umfasst auch Empfehlungen zu Vorgaben hinsichtlich Telenotärztinnen oder Telenotärzten sowie notärztlicher Sonderdienste zur Unterstützung oder Sicherstellung einer fachgerechten Patientinnen- und Patientenversorgung.

Zu Nummer 2

Der Ausschuss soll darüber hinaus nach medizinischer Indikation und disponiertem Einsatzmittel differenzierte Empfehlungen zu Hilfsfristen sowie Maßnahmen zur Optimierung des jeweiligen Zielerreichungsgrades beschließen. Hinsichtlich der medizinischen Notfallrettung ist dabei entscheidend, dass das Einsatzmittel rechtzeitig nach Disponierung am Notfallort eintrifft. Unter Umständen kann der Ausschuss es auch für medizinisch erforderlich ansehen, entsprechend Empfehlungen zu Prähospitalzeiten zu beschließen. Dies ist die Zeit zwischen Eingang der Notrufmeldung in der Leitstelle bis zur Ankunft in einer nächstgelegenen für die Versorgung geeigneten Einrichtung.

Zu Nummer 3

Vorgesehen sind auch Empfehlungen zur medizinischen Versorgung vor Ort und während des Transports. Dies können insbesondere Vorgaben zur Umsetzung der eigenverantwortlichen Durchführung heilkundlicher Maßnahmen durch Notfallsanitäter nach § 2a des Gesetzes über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters sein und Handlungsempfehlungen auf der Basis aktueller Leitlinien der medizinischen Fachgesellschaften. Damit kann eine gleichwertige Versorgungsqualität erzielt werden.

Zu Nummer 4

Dies gilt auch für die Konkretisierung der Aufgaben der ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes, insbesondere hinsichtlich derer im Rahmen des Qualitätsmanagements und zur Einbindung in den Einsatzdienst.

Zu Nummer 5

Weitergehend sind Empfehlungen hinsichtlich der Entscheidung bezüglich der Art und Weise einer Weiterversorgung durch andere Beteiligte vorgesehen. Dies kann den Transport zur weiterführenden Versorgung in ein geeignetes Krankenhaus oder eine andere Einrichtung beziehungsweise die Übergabe an die vertragsärztliche, ambulante Notfallversorgung der zuständigen kassenärztlichen Vereinigung beinhalten.

Zu Nummer 6

In den Katalog sind zusätzlich Empfehlungen zur Qualitätssicherung aufzunehmen. Dies kann die Verankerung von Prozessoptimierungs- und Qualitätsmanagementsystemen, inklusive Meldeprozessen, die Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen und die standardisierte und fortlaufende, medizinische Einsatzauswertung durch die Ärztliche Leitung beinhalten.

Zu Nummer 7

Außerdem sind Empfehlungen zum Einsatz spezialisierter Transportmittel, wie Luftrettungsmitteln, Intensivtransportwagen und auf die Versorgung von Kindern spezialisierter Rettungsfahrzeuge zu treffen. Dies kann beispielsweise Vorgaben zur Disposition, Ausstattung, Hilfs- und Planungsfristen und Qualifikationen des Personals beinhalten.

Zu Nummer 8

Schließlich sind Empfehlungen zum Einsatz eines ärztlichen Führungsdienstes, beispielweise für Maßnahmen, die aufgrund der Komplexität des Einsatzgeschehens erforderlich sind, oder zur Durchführung besonderer invasiver medizinischer Maßnahmen.

Zu Absatz 4

Der Qualitätsausschuss Notfallrettung erstellt entsprechend Absatz 3 auch einen Katalog mit Empfehlungen zu Krankentransporten und Krankentransportflügen. Er entscheidet nach eigenem Ermessen, welche mit Absatz 3 vergleichbaren Qualitätsparameter er für erforderlich hält.

Zu Absatz 5

Soweit das Bundesministerium für Gesundheit oder eine zuständige oberste Landesbehörde beantragt, dass über ein Thema beraten wird, hat der Qualitätsausschuss Notfallrettung hierüber zu beraten und zu beschließen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann Fristen für die Erstellung von Empfehlungen setzen. Kommen diese Empfehlungen innerhalb der Fristen nicht zustande, kann das Bundesministerium für Gesundheit die Empfehlungen selbst erstellen. Die Geschäftsstelle des Qualitätsausschusses Notfallrettung veröffentlicht die Empfehlungen.

Zu Absatz 6

Der Qualitätsausschuss Notfallrettung beschließt zudem Empfehlungen zur Übermittlung der Daten der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung nach § 133e. Das Bundesministerium für Gesundheit erlässt eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, die die für die Ermittlung der Leistungsqualität erforderlichen Daten der Leistungserbringer zur Qualitätssicherung nach § 133e festlegt. Dies umfasst Strukturdaten und einsatzspezifische Leistungsdaten sowie Angaben zur Qualifikation des beteiligten Personals. Zur Ermittlung der Leistungsqualität ist es zudem erforderlich, dass die Daten einer regionalen Einheit zugeordnet werden können.

Zu Absatz 7

Der Ausschuss erstellt Spezifikationen für eine strukturierte, einheitliche und digitale Dokumentation und Kommunikation nach § 133d. Hierbei soll auf die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Einvernehmen mit dem Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen (KIG) entwickelten Spezifikationen für die Vernetzung und interoperable Fallübergabe innerhalb Integrierter Notfallzentren nach § 123a Absatz 2 Satz 10 sowie auf den Spezifikationen nach § 133a Absatz 2 Satz 8 für die digitale Fallübergabe innerhalb eines Gesundheitssystems aufgesetzt werden. Die Spezifikationen nach diesem Absatz sind im Einvernehmen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft zu erstellen, da die von ihnen vertretenen Gruppen von der Anwendung der Spezifikationen in der Praxis unmittelbar betroffen sein werden. Bei der Erstellung der Spezifikationen ist das KIG nach § 385 rechtzeitig einzubeziehen. Das Bundesministerium für Gesundheit kann dann auf Basis der Empfehlung des KIG die gesamte oder Teile der Spezifikation nach § 133d per Rechtsverordnung verbindlich festlegen. Der Wirkungsbereich der Festlegung beschränkt sich hierbei allerdings auf Systeme, die nicht ausschließlich in Landeshand liegen. Die Spezifikationen werden gemäß § 385 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 auf der entsprechenden Plattform veröffentlicht.

Zu § 133d

Für die Notfallversorgung der Versicherten ist die Verarbeitung und damit auch die Übermittlung der erhobenen Behandlungsdaten insbesondere für die medizinisch erforderliche Weiterbehandlung durch weiterversorgende Stellen von essenzieller Bedeutung. Diese Datenübermittlung ist eine wesentliche Voraussetzung, um eine erfolgreiche medizinische Behandlung im Rahmen der weitgehend arbeitsteiligen Notfallversorgung zu gewährleisten. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der bereits nach geltendem Recht bestehenden Befugnis zur Verarbeitung der für die Behandlung erforderlichen Behandlungsdaten durch die jeweiligen Behandler einerseits und der mit der Neuregelung eingeführten Verpflichtung zur Datenübermittlung sowie zu spezifischen Vorgaben zur Ausgestaltung dieser Datenübermittlung. Diese Verpflichtung gilt, sobald die erforderlichen technischen Voraussetzungen vorliegen. Es muss also die entsprechende Rechtsverordnung nach § 133c Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 385 erlassen worden und die technische Umsetzung dahingehend abgeschlossen sein, dass die Datenübermittlung in der vorgesehenen Weise möglich ist. Die Datenübermittlung zwischen den an der rettungsdienstlichen Versorgung Beteiligten soll unter Nutzung der sicheren Übermittlungsverfahren der Telematikinfrastruktur erfolgen. Voraussetzung ist ein Anschluss der jeweiligen Leistungserbringer beziehungsweise der Einrichtung an die Telematikinfrastruktur.

Ziel ist, dass alle Versorgungsstrukturen, die bei Notfällen oder bei Anhaltspunkten eines Notfalls tätig werden, Daten technisch so austauschen können, dass sie in dem jeweiligen Empfängersystem sofort nutzbar sind.

Soweit die hierfür erforderlichen technischen Voraussetzungen bestehen, sind die im Rahmen der Notfall- und Akutversorgung erhobenen Daten zusätzlich durch die hierzu eingebundenen, zugriffsberechtigten Leistungserbringer unmittelbar nach der erfolgten Versorgung in der elektronische Patientenakte des Versicherten zu speichern.

Auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten außerhalb der Notdienststrukturen nach § 75 Absatz 1b Satz 5, zum Beispiel durch zugelassene Hausärztinnen und Hausärzte, andere zugelassene Vertragsärztinnen und -ärzte oder in zugelassenen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), findet die Vorschrift keine Anwendung.

Zu § 133e**Zu Absatz 1**

Um den jeweiligen Planungsbehörden und -stellen eine effektive und effiziente Planung und Ausgestaltung der jeweiligen Versorgungsstrukturen zu ermöglichen und das Leistungsgeschehen insgesamt transparenter darzustellen, werden die Leistungserbringer der medizinischen Notfallrettung verpflichtet, die für die Ermittlung der Leistungsqualität erforderlichen Daten anonymisiert und elektronisch an eine vom GKV-SV geführte Datenstelle auf Bundesebene zu übermitteln. Die Datensätze werden vom Bundesministerium für Gesundheit in einer Rechtsverordnung einheitlich festgelegt. Die Übermittlung der Daten dient dem Zweck der Qualitätssicherung, durch die Messung und die darauf aufbauende Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Leistungen nach § 30.

Zu Absatz 2

Die Datenstelle führt die Daten in einer bundesweiten Statistik zusammen, die sich nach bundes- und landesweiten Ergebnissen gliedert. Dabei ist sicherzustellen, dass aus den verarbeiteten Daten Rückschlüsse auf einzelne Leistungserbringer oder einzelne Einsätze nicht möglich sind. Die Statistik wird jährlich jeweils zum 1. Juli veröffentlicht.

Die Datenstelle stellt darüber hinaus dem Bundesministerium für Gesundheit, dem Qualitätsausschuss Rettungsdienst, den für den Rettungsdienst zuständigen Landesbehörden sowie den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen auf Anforderung Auswertungen für ihre Belange zur Verfügung.

Die erfassten statistischen Daten liefern wichtige Erkenntnisse zu Qualität und Umfang der erbrachten Leistungen unmittelbar aus dem Versorgungsalltag, bilden das Leistungsgeschehen damit transparent ab und sind Voraussetzung für die Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen und zweckmäßigen integrierten Notfallversorgung. Die so gewonnenen Daten können auch als Grundlage für die Verhandlungen der Verträge zur Vergütung oder die Festsetzung von Entgelten für die Leistungen der medizinischen Notfallrettung dienen.

Zu Nummer 22 (§ 136b)

Die vorgeschlagene Regelung schafft die Grundlage für ein bundesweit einheitliches Echtzeit-Nachweissystem der stationären Versorgungskapazitäten. Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie haben deutlich gemacht, dass der Mangel an aktuellen und verlässlichen Daten über Intensiv- und Notfallkapazitäten die Steuerung des Gesundheitssystems erheblich erschwert und in einzelnen Regionen zu Engpässen geführt hat. Bisherige Register wie das DIVI-Intensivregister haben gezeigt, dass digitale Nachweissysteme zur Entlastung beitragen können, sie waren jedoch weder umfassend noch dauerhaft rechtlich abgesichert.

Mit dem neuen Absatz 9 wird der Gemeinsame Bundesausschuss verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten eine Richtlinie zu erlassen, die Inhalt, Umfang und Verfahren des Echtzeit-Nachweises festlegt. Krankenhäuser, Notdienstpraxen und Rettungsdienste werden zur fortlaufenden Meldung ihrer verfügbaren, belegten oder überlasteten Kapazitäten verpflichtet. Damit soll eine präzise und jederzeit aktuelle Übersicht über die Versorgungslage gewährleistet werden. Durch die webbasierte Veröffentlichung strukturierter Daten wird Transparenz geschaffen und eine zielgerichtete Steuerung der Patientenzuweisung ermöglicht. Im Falle von Großschadenslagen oder Katastrophen erhalten die zuständigen Behörden einen unmittelbaren Datenzugriff, um schnell und koordiniert reagieren zu können.

Besonders hervorzuheben ist die enge Vernetzung mit den Rettungsleitstellen, die im Rahmen der Richtlinie in das Nachweissystem eingebunden werden, um Notfallpatientinnen und -patienten unmittelbar und ohne Zeitverlust in geeignete, verfügbare Einrichtungen steuern zu können.

Die Führung des Verzeichnisses obliegt einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss zu bestimmenden Stelle; im Falle einer Beauftragung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus wird die Finanzierung über bestehende Zuschläge nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sichergestellt. Damit ist eine verlässliche institutionelle Trägerschaft sowie eine sachgerechte Kostentragung gewährleistet, ohne die Krankenhäuser zusätzlich zu belasten.

Zur Sicherung der Qualität und zur Weiterentwicklung der Regelung wird der Gemeinsame Bundesausschuss verpflichtet, bis ... [einsetzen: Datum des letzten Tages des elften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] die Auswirkungen der Richtlinie auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und Patientenversorgung zu evaluieren und dem Bundesministerium für Gesundheit Bericht zu erstatten. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass das Nachweissystem an neue medizinische, technische und organisatorische Anforderungen angepasst werden kann und dauerhaft zu einer resilienten, patientenorientierten Notfallversorgung beiträgt.

Zu Nummer 23 (§ 136c)

Um die Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Notfallstufen gemäß § 136c an den aktuellen Stand der Wissenschaft anzupassen, wird festgelegt, dass diese sich in Bezug auf die Vorgaben für das Personal und die Ausstattung an die Empfehlungen der maßgeblichen Fachgesellschaften zu orientieren haben.

Zu Nummer 24 (§ 291b)

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Einbindung von Notaufnahmen in den Notdienst durch Kooperationsvereinbarungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung wird nunmehr in § 75 Absatz 1b Satz 10 geregelt.

Zu Nummer 25 (§ 377)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Angleichung der Terminologie im Fünften Buch Sozialgesetzbuch. Notfallambulanzen werden künftig einheitlich als Notaufnahmen bezeichnet.

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch)

Der neugefasste § 75 Absatz 1e sieht neben den bereits bestehenden und durch Artikel 1 in § 75 Absatz 1e überführten Evaluations- und Berichtspflichten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung weitere Pflichten vor, die mit der Einführung der Akutleitstelle einhergehen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung legt dem Bundesministerium für Gesundheit ein entsprechendes Evaluationskonzept vor.

Zu Artikel 3 (Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes)**Zu Nummer 1 (§ 12a)**

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Definition der Integrierten Notfallzentren nach § 123 und der Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendliche nach § 123b.

Zu Nummer 2 (§ 17b)

Aktuell besteht für die Leistungen der Notaufnahmen, die nicht unter die Vergütung durch die Regelungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) fallen, aufgrund des Fehlens eines Fachabteilungsschlüssels keine Möglichkeit der fallabhängigen Vergütung. Der Betrieb von Notaufnahmen ist deshalb meist defizitär und es besteht ein finanzieller Anreiz für die Krankenhäuser, Patientinnen und Patienten (kurzzeit-)stationär aufzunehmen. Die Einführung der Leistungsgruppe Notfallmedizin hat dieses Problem reduziert, da ein Anknüpfungspunkt für die Vergütung von Leistungen vorlag. Durch die geplante Abschaffung der Leistungsgruppe Notfallmedizin im Krankenhausreformsanftpassungsgesetz tritt das Problem allerdings wieder prioritär auf. Um die Finanzierung der Notaufnahmen im Sinne der Notwendigkeit einer umfassenden Vorhaltung notfallmedizinischer Versorgungskapazitäten gerecht zu werden, wird deshalb eine Regelung eingeführt, die eine hundertprozentige Vorhaltefinanzierung des gemäß den Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V vorzuhaltenden ärztlichen Personals vorsieht. So ist die Finanzierung der Notaufnahmen zumindest teilweise gesichert und die Notfallversorgung umfassender sichergestellt.

Zu Artikel 4 (Änderung des Krankenhausentgeltgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Anpassung der Anforderungen für Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V, die eine regelmäßige Aktualisierung der Regelung sicherstellt.

Zu Artikel 5 (Änderung der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Definition der Integrierten Notfallzentren nach § 123 und der Integrierten Notfallzentren für Kinder und Jugendlichen nach § 123b.

Zu Artikel 6 (Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte)**Zu Nummer 1**

Gemäß Satz 2 in Verbindung mit § 17 des Bundesmantelvertrags – Ärzte sind bestimmte Facharztgruppen verpflichtet, wöchentlich mindestens fünf offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung anzubieten und an die jeweilige zur Sicherstellung der Versorgung zuständige Kassenärztliche Vereinigung zu melden. Diese Regelung wird durch einen neuen Satz 3 konkretisiert, um im Sinne der Reform der Notfallversorgung eine bessere Verteilung der offenen Sprechstunden zu erreichen. Vertragsärztinnen und Vertragsärzte müssen bei der Festsetzung ihrer offenen Sprechstunden nunmehr explizit auch die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten nach einer ausreichenden Versorgung bei akuter Behandlungsbedürftigkeit berücksichtigen. Ziel muss dabei sein,

dass die Patientinnen und Patienten möglichst an jedem Wochentag während der Sprechstundenzeiten die Möglichkeit haben, bei akutem Behandlungsbedarf auch ohne vorherige Terminvereinbarung eine vertragsärztliche Versorgung (in den zur offenen Sprechstunde verpflichteten Arztgruppen) in Anspruch nehmen zu können. Die gleichmäßige Verteilung der offenen Sprechstunden über die Woche ist nicht durch jeden einzelnen Vertragsarzt, sondern innerhalb der jeweiligen Arztgruppe nach § 17 Absatz 1c des Bundesmantelvertrags – Ärzte sicherzustellen. Hierzu bedarf es – abhängig von der bisherigen Planung der betroffenen Arztpraxen – unter Umständen einer durch die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen ihres Sicherstellungsauftrages koordinierten Abstimmung der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte einer Arztgruppe in einem Planungsbereich über die Terminierung der jeweiligen offenen Sprechstunden. Dadurch werden die Möglichkeiten der Akutleitstellen verbessert, Versicherte im Akutfall an offene Sprechstunden zu vermitteln und diese haben somit seltener Anlass, eine Notaufnahme oder eine Notdienststruktur in Anspruch zu nehmen. Auch die Möglichkeiten der Integrierten Notfallzentren, Versicherte nach der Ersteinschätzung in die vertragsärztliche Regelversorgung weiterzuleiten, werden so verbessert.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1.

Zu Nummer 3

Gemäß Satz 8 werden die Bundesmantelvertragspartner nunmehr verpflichtet, bundeseinheitliche Regelungen zur zeitlichen Verteilung der offenen Sprechstunden nach Satz 3 zu treffen. Zudem sollen, anknüpfend an den neuen Satz 4, durch die Regelungen im Bundesmantelvertrag-Ärzte bundeseinheitliche Vorgaben zur Umsetzung einer möglichst gleichmäßigen zeitlichen Verteilung der offenen Sprechstunden innerhalb der Arztgruppen in den Planungsbereichen getroffen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere während der Schließzeiten der Integrierten Notfallzentren möglichst umfassend offene Sprechstunden angeboten werden sollen.

Zu Artikel 7 (Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter)

Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes sehen einige neue Handlungsfelder für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, beispielsweise in der speziellen ambulanten Notfallversorgung, im Sinne der Durchführung eigenständiger Maßnahmen und im Rahmen des „Ärztlichen Bereitschaftsdienstes“ der Kassenärztlichen Vereinigungen, vor. Um dem Umstand der sich ändernden Struktur und neuer Rollenbilder gerecht zu werden und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung nach Ihrem zehnjährigen Bestehen auf die aktuellen Rahmenbedingungen zu aktualisieren und im Sinne moderner pädagogischer Konzepte anzupassen, wird das Bundesministerium für Gesundheit verpflichtet, den Prozess der Neufassung anzustoßen.

Zu Artikel 8 (Evaluierung)

Die Evaluationsklausel stellt sicher, dass die Auswirkungen der §§ 30, 60 sowie 133 bis 133e innerhalb eines angemessenen Zeitraums überprüft werden. Durch die Berichtspflicht des Bundesministeriums für Gesundheit wird gewährleistet, dass belastbare Erkenntnisse über die Wirksamkeit, die Zielerreichung sowie mögliche unbeabsichtigte Nebenfolgen der Regelungen vorliegen. Der Zeitraum von drei Jahren ermöglicht es, erste praktische Erfahrungen aus der Umsetzung auszuwerten, ohne dass die Evaluierung durch eine zu frühe Betrachtung an Aussagekraft verliert. Mit der Zuleitung des Berichts an Bundestag und Bundesrat wird die Grundlage für eine fundierte parlamentarische und föderale Beratung geschaffen. Dadurch kann rechtzeitig entschieden werden, ob eine Fortführung, Anpassung oder Ergänzung der Regelungen erforderlich ist.

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Das Gesetz tritt vorbehaltlich Absatz 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Zu Absatz 2

Artikel 2 tritt am ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. Dadurch wird bewirkt, dass die bestehende Evaluations- und Berichtspflicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bezüglich der Terminservicestelle bis zum ... [einsetzen: Datum des letzten Tages des fünften auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] weiter besteht. Die erweiterte Pflicht zur Evaluation und Bewer-

tung auch der neu geregelten Akutleitstelle nach dem neugefassten § 75 Absatz 1e soll damit erst ein Jahr später, zum ... [einsetzen: Datum des ersten Tages des achtzehnten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats], bestehen. Aufgrund der Notwendigkeit, die neuen gesetzlichen Regelungen zur Akutleitstelle erst in der Praxis umzusetzen, würde ein früherer Bericht hierzu kein belastbares Ergebnis bringen.

